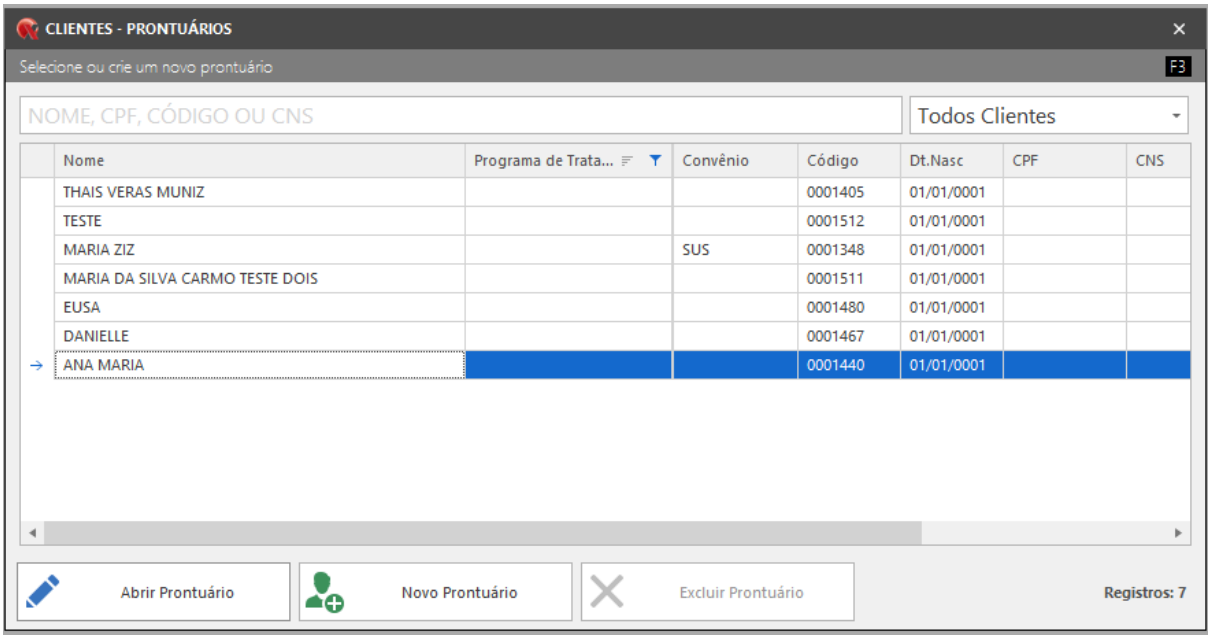
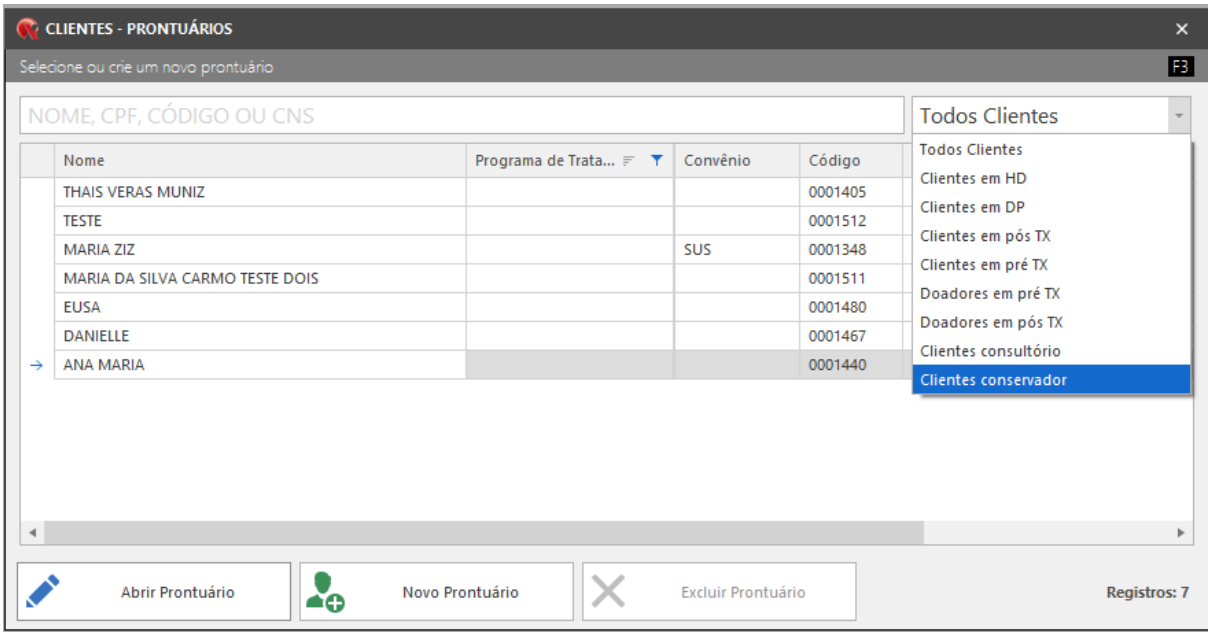
CLIENTES - PRONTUÁRIOS





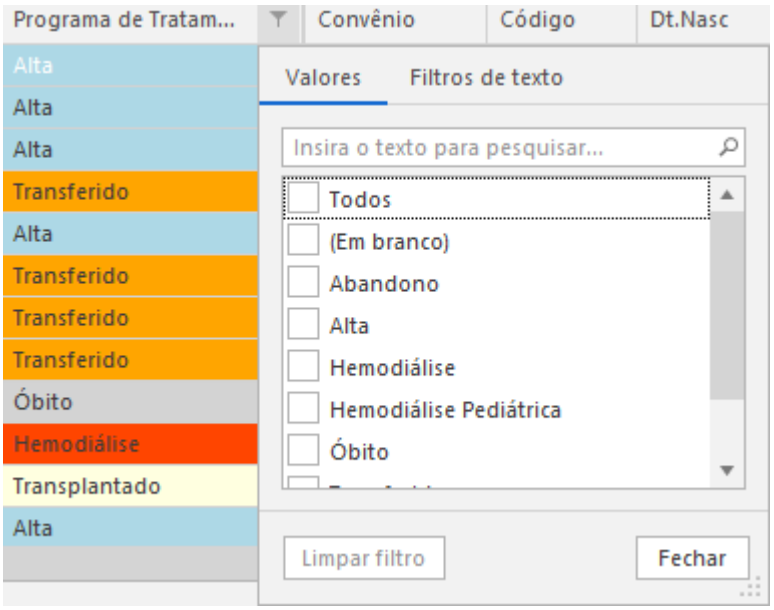
Campos presentes: Nome, Programa de Tratamento, Convênio, código, dt.Nasc, CPF, CNS, Telefone

Dir: Abrir prontuário, Novo Prontuário e Excluir Prontuário

Filtros: Todos Clientes, Clientes em HD, Clientes em DP, Clientes em pós TX, Clientes em pré TX**,** Doadores em pré TX, Doadores em pós TX, Clientes consultório, Clientes Conservador.

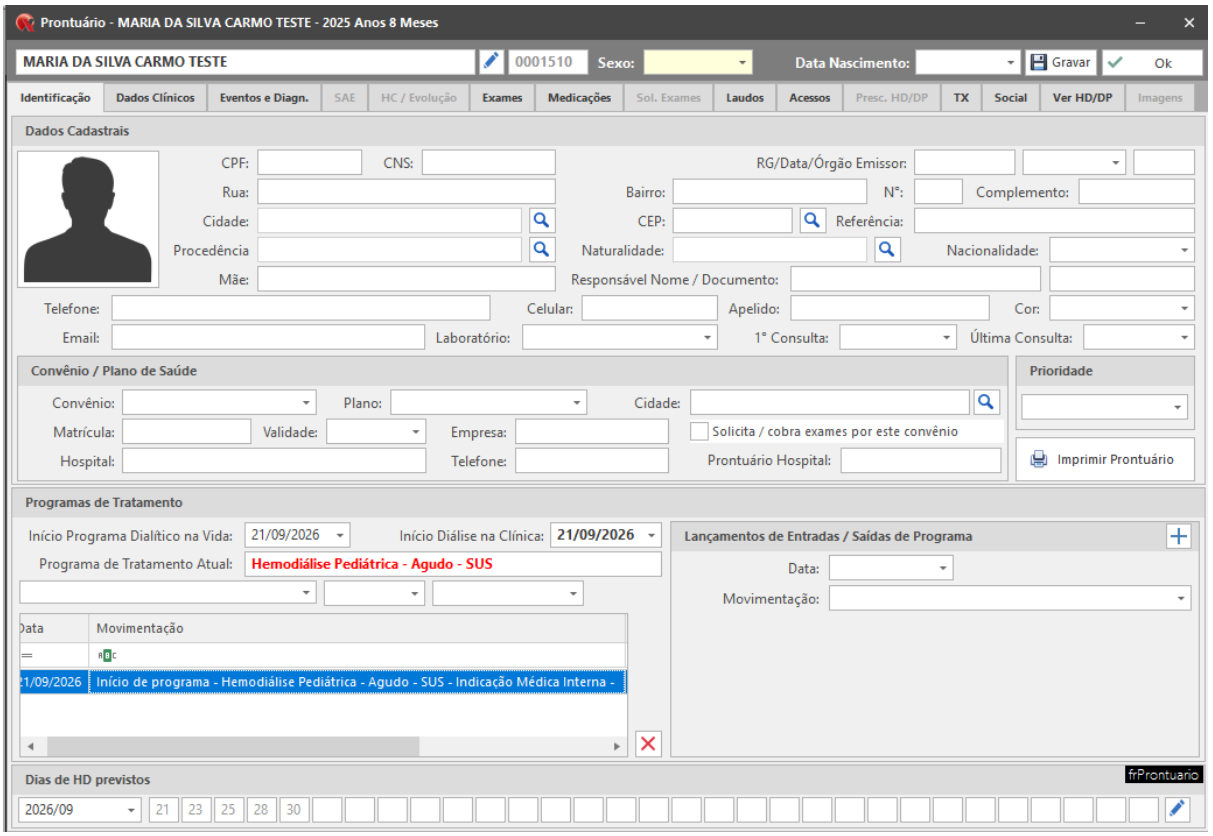
Infos: Total de registros

OBS: remover convênio



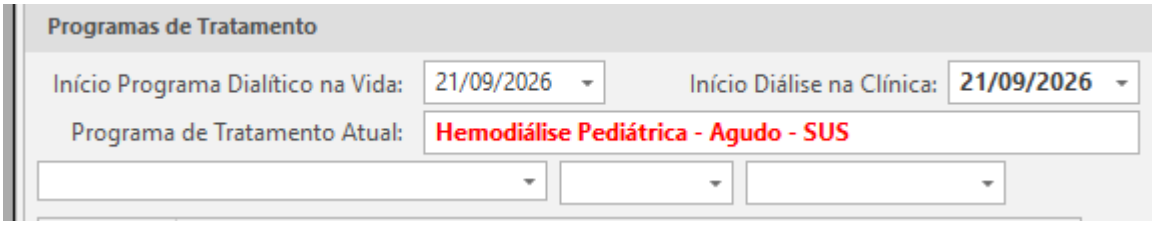
Programa de Tratamento: Em branco, abandono, alta, Hemodiálise, Hemodiálise Pediátrica, Óbito, Transferido, Transplantado (responsável pode cadastrar novo tratamento)

PRONTUÁRIO

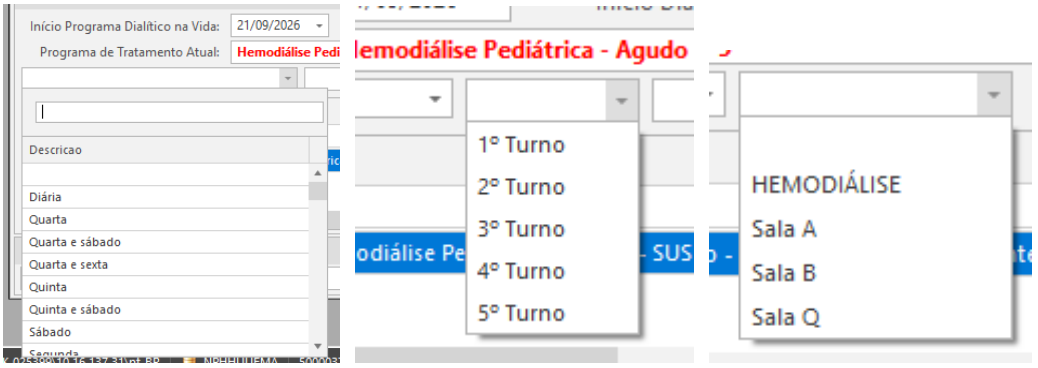


Informações vindas da API: Nome, Sexo, Cor, Nome da Mãe, Data de Nascimento, Nacionalidade, Naturalidade, UF, E-mail, Telefone, CEP, Logradouro/rua, Bairro, Municipio identidade(Nº Identidade, Órgão Emissor, UF, Data ID), CPF, Cartão SUS(CNS).

OBS: Não precisa por a box de convênio da aba de identificação..

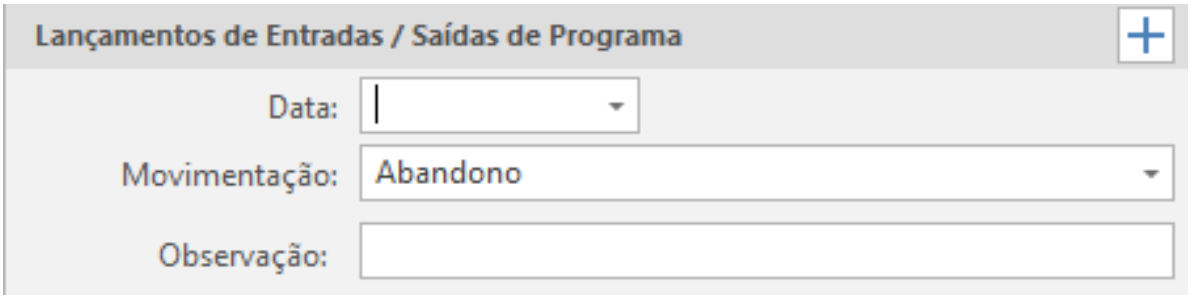


A primeira são dias da semana, conforme a imagem. A segunda são turnos e o terceiro campo são salas

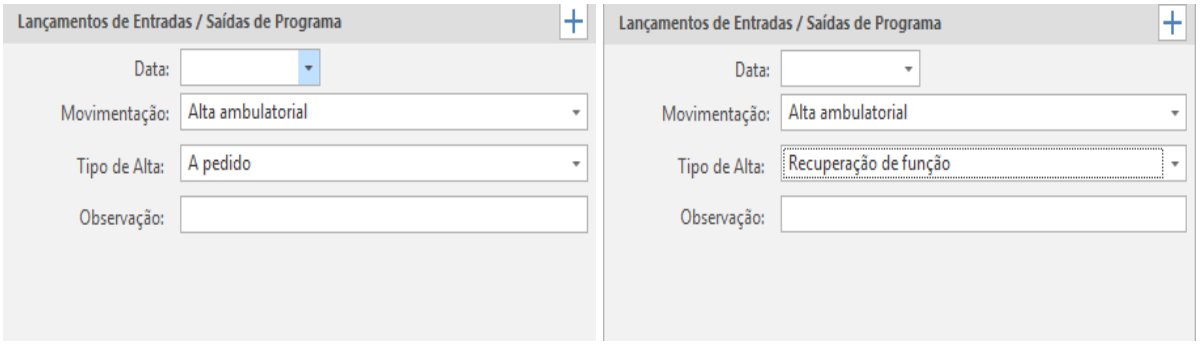


Lançamentos de Entrada / Saídas de Programa:

Abandono | Rejeição / Perda de transplante:

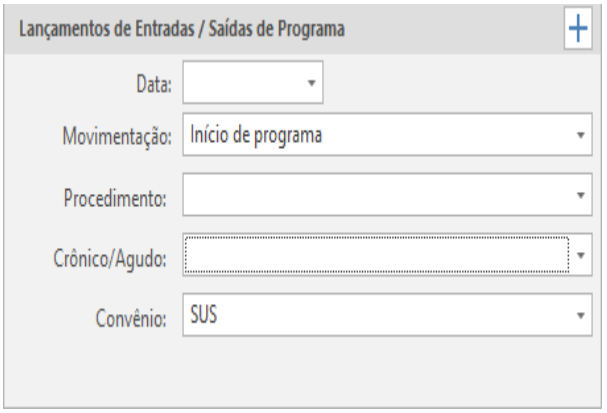


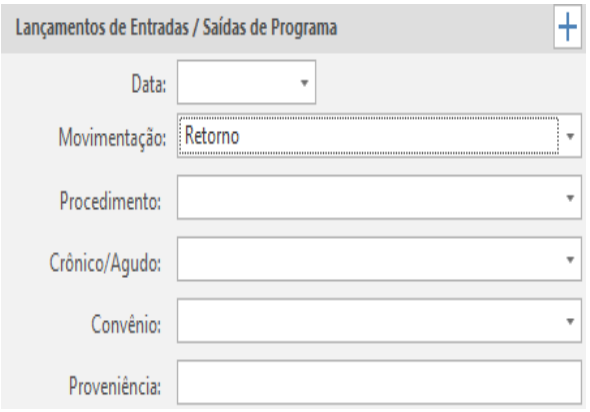
Alta ambulatorial:



A pedido | Recuperação de Função

Início de programa | Mudança de procedimento / Retorno:



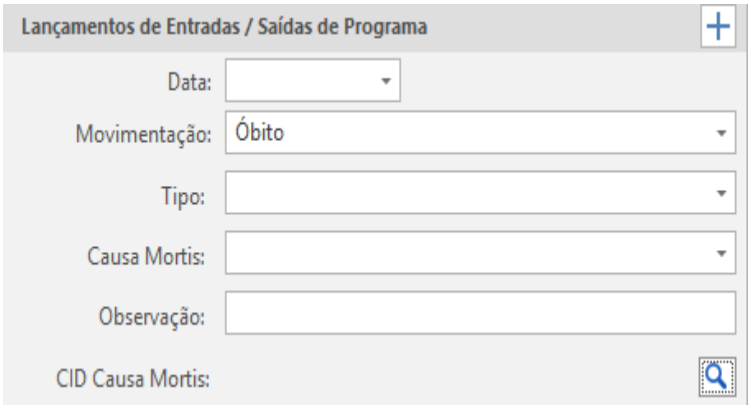


Procedimento (Início de programa | Mudança de procedimento):

Ambulat. - Acomp. Pós Doador
Ambulat. - Acomp. Pós TX
Ambulat. - Acomp. Pré Doador
Ambulat. - Acomp. Pré TX
Ambulat. - Conservador Est. 1
Ambulat. - Conservador Est. 2
Ambulat. - Conservador Est. 3a
Ambulat. - Conservador Est. 3b
Ambulat. - Conservador Est. 4
Ambulat. - Conservador Est. 5
Ambulat. - Consultório
Ambulat. - Doenças Raras
Ambulatório Externo
Atendimento AGUDOS
DPA
DPA Hospitalar
DPAC
DPAC Hospitalar
DPI
Hemodiafiltração
Hemodiafiltração Contínua
Hemodiafiltração Diária
Hemodiafiltração Home Care
Hemodiafiltração Pediátrica
Hemodiálise
Hemodiálise Contínua
Hemodiálise Diária
Hemodiálise Externa
Hemodiálise Externa Diária
Hemodiálise HIV/HB/HC
Hemodiálise HIV/HB/HC Diária
Hemodiálise Home Care
Hemodiálise Pediátrica
Hemodiálise Pediátrica Diária
Hemodiálise SLED
Hemofiltração Contínua
Plasmaferese
Ultrafiltração Contínua

Crônico/Agudo: apenas e categorias agudo, crônico e trânsito
Obs: Somente os procedimentos, DACP, Hemodiálise e Hemodiálise pediátrica, todos os outros procedimentos devem ser removidos. (adm pode fazer inclusão de novo procedimento)
Obs: remover convênio e verificar campo Proveniência

Óbito | Tipo:



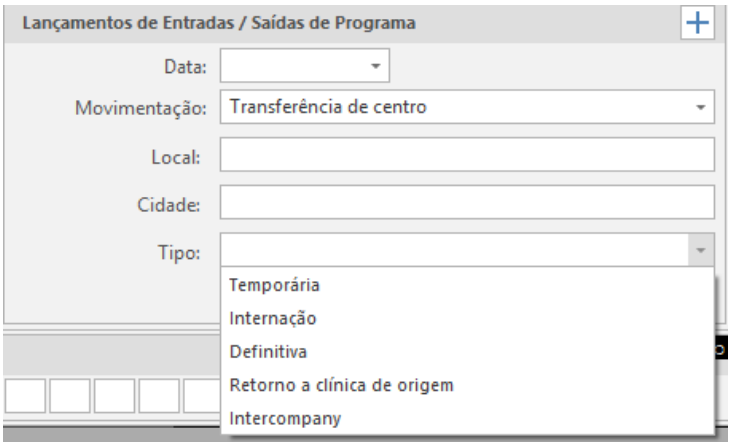
Decl. de óbito pelo IML
Decl. de óbito pelo médico assistente
Decl. de óbito pelo SVO
Sem informação

Causa Mortis (Óbito):

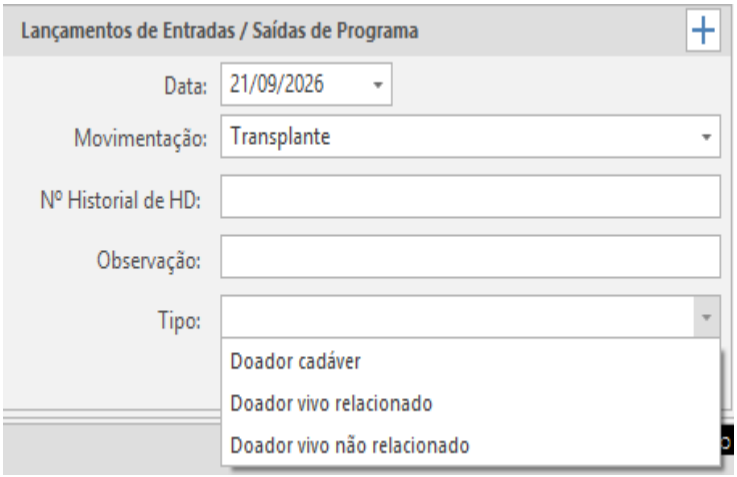
Acidente não relac. com trat.	Câncer Próstata	Demência	Hepatopatia tóxica	Outras
Acidente relac. com tratamento	Câncer Pulmão	Depressão da medula óssea	Hipercalemia	Outras causas infecciosas
AIDS	Câncer Vias Biliares	Doença card. ateroescleróica	Infarto agudo do miocárdio	Outras hemorragias
Aneurisma dissecante	Caquexia	Doença hepática policística	Infarto mesentérico	Outras hemorragias cranianas
Arritmia Cardíaca	Cardiomiopatia	Doença vascular	Infecção por CMV	Outras Hepatites virais
AVC isquêmico	Causa desconhecida	DPOC	Infecção Resp. (bacteriana)	Pancreatite
AVC hemorrágico	Choque Cardiogênico	Edema pulmonar	Infecção Resp. (fungo)	Parada cardíaca, causa desc.
AVC isquêmico ou hemor.	Choque misto	Embolia gasosa	Infecção Resp. (outra)	Perfuração de úlcera péptica
Câncer Cérebro	Choque não Classificado	Embolia Pulmonar	Infecção viral, outra	Perfuração intestinal(não 402)
Câncer Colo de útero	Cirrose	Encefalopatia anóxica	Insuf. cardíaca congestiva	Pericardite
Câncer Cólon	Coma diabético	Esquistossomose hepatoesplênic	Insuficiência hepática, outras	Peritonite
Câncer Endométrio	Coma hipoglicêmico	Hemorragia aneur. tórax/abd.	Insuficiência Respiratória	Sem informação
Câncer Estômago	Complicação cirúrgica	Hemorragia Cirúrgica	Linfoma	Septicemia - a peritonite
Câncer Mama	Convulsões	Hemorragia gastrointestinal	Mieloma Múltiplo	Septicemia - acesso vascular
Câncer Pâncreas	Covid-19	Hepatite B	Neoplasia, sítio não identif.	Septicemia - gangrena
Septicemia por outras causas				
Suicídio				
Tuberculose				

CID (Cadastro Internacional de Doenças): adicionar este campo com as doenças catalogadas de acordo com o CID e verificar se já consta no HUUFMA.

Transferência de Centro:



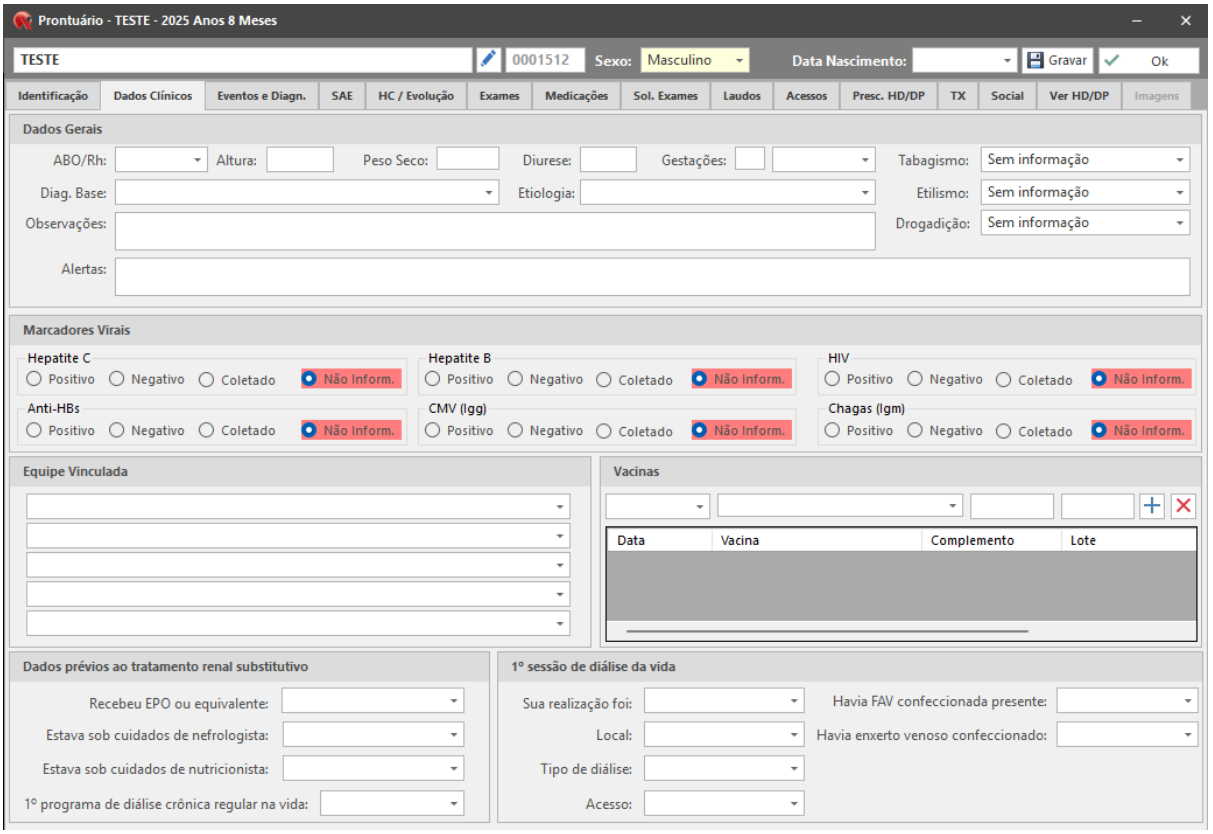
Transplante:



Dias de HD previstos:

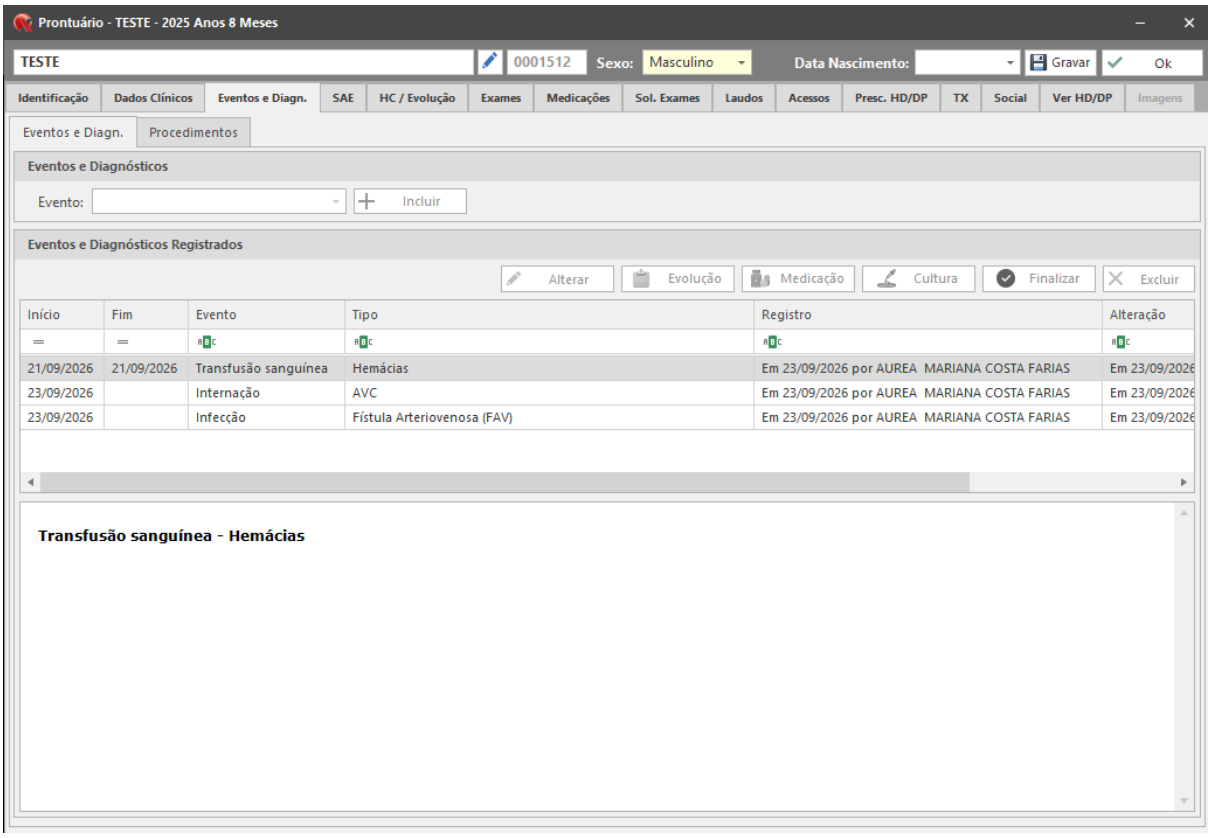


Dados Clínicos:



Obs: Verificar com o médico quais campos são utilizados

Eventos e Diagnósticos:

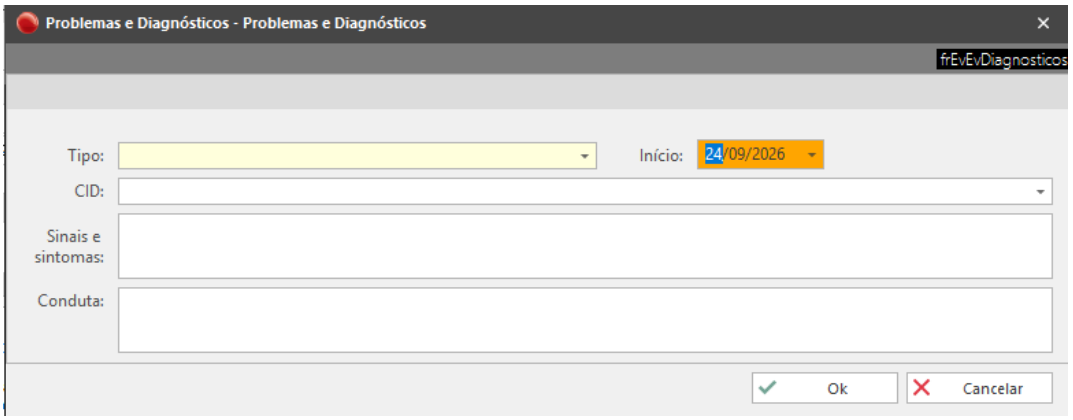


OBS: Tela Procedimentos não é utilizada e espaço que demonstra o evento selecionado com data tipo e informações e observações registradas nele

Evento: Eventos mais comuns, e possibilidade de registrar novos tipos de Eventos

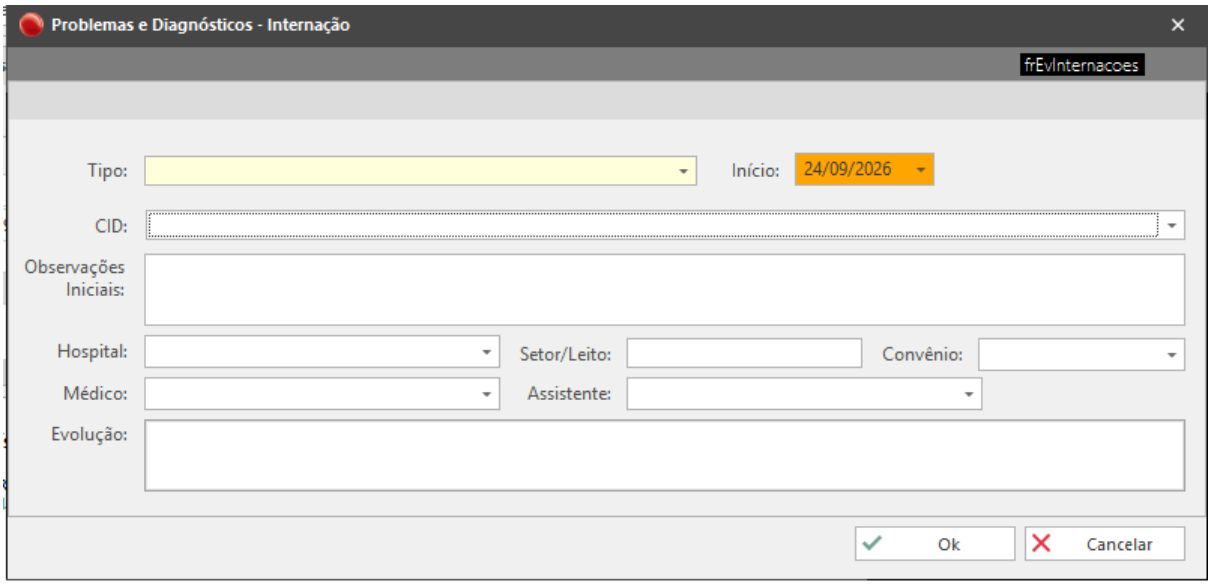
Eventos e Diagnósticos Registrados: Histórico de eventos registrados com a necessidade de registrar o início e o fim do evento com exceção de eventos imediatos como a transfusão de sangue, com a possibilidade de editá-los, incluir evolução, cultura, medicação e opção de exclusão.

Problemas e Diagnósticos:



OBS: campo Tipo possui os problemas e diagnósticos mais comuns com a possibilidade de marcar outros (incluir opção de registro de problemas e diagnósticos a nível administrador) e campo CID usa padrão internacional

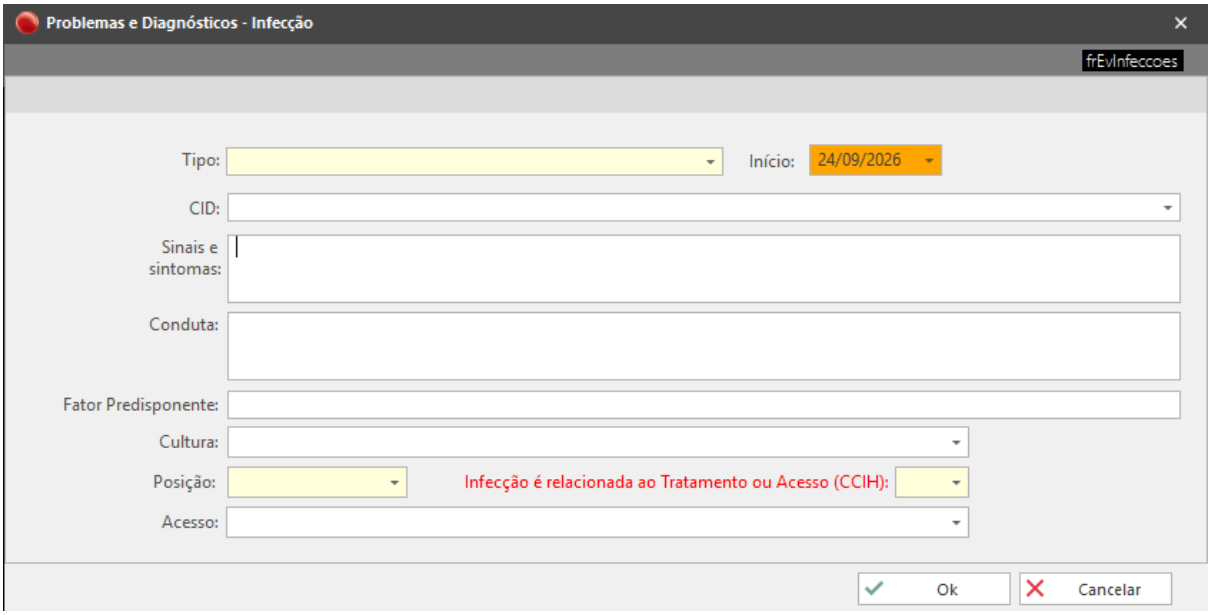
Internação:



OBS: campo Tipo possui as internações mais comuns com a possibilidade de marcar outros (incluir opção de registro de problemas e diagnósticos a nível administrador) e campo CID usa padrão internacional

OBS 2: Campo Hospital e convênio desnecessários, e Médico e Assistente com todos médicos registrados

Infecção:



OBS: campo Tipo possui as infecções mais comuns com a possibilidade de marcar outros (incluir opção de registro de problemas e diagnósticos a nível administrador) e campo CID usa padrão internacional

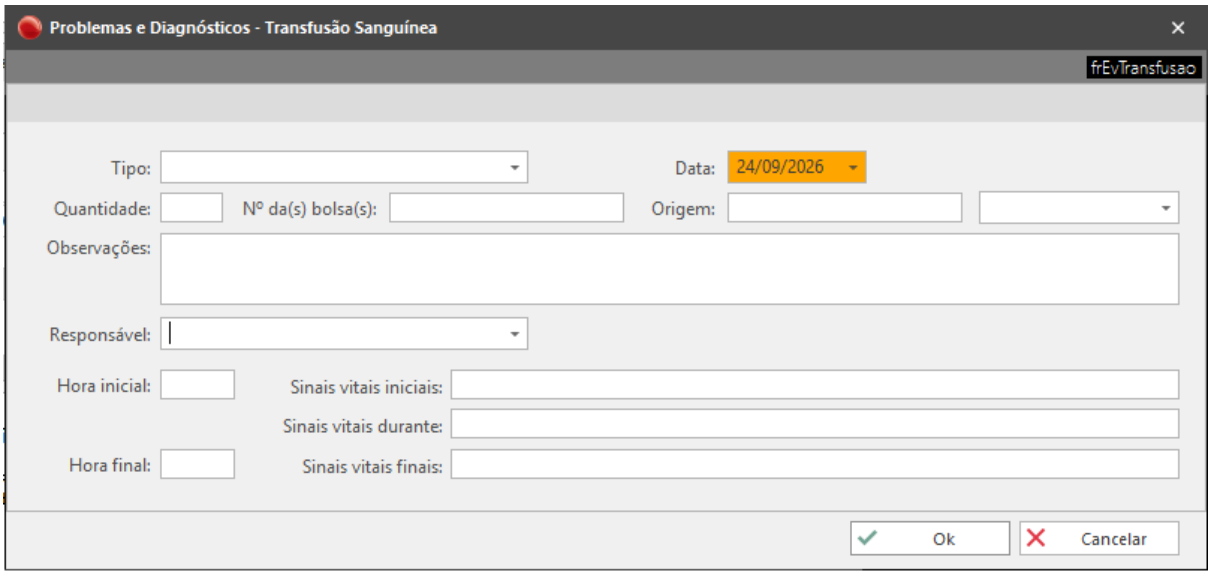
Cultura | Tipos:

Não Coletada	Sangue periférico
Fezes	Secreção de fístula arterio-venosa
Líquido ascítico	Secreção de incisão cirúrgica
Líquido de diálise peritoneal	Secreção de pele
Liquido pericárdico	Secreção vaginal
Líquido pleural	Sinovial
Líquor	Swab anal
Óstio do cateter de hemodiálise	Swab nasal
Óstio do cateter de Tenckhoff	Swab Osteo Cateter
Ponta de cateter	Urina
Sangue da fístula arterio-venosa	
Sangue da linha	
Sangue lúmen do cateter de hemodiálise	

Posição: Aguardando resultado, Confirmada, Descartada, Diagnóstico Clínico.

OBS: campo para selecionar se a infecção e relacionada ao tratamento ou acesso e campo

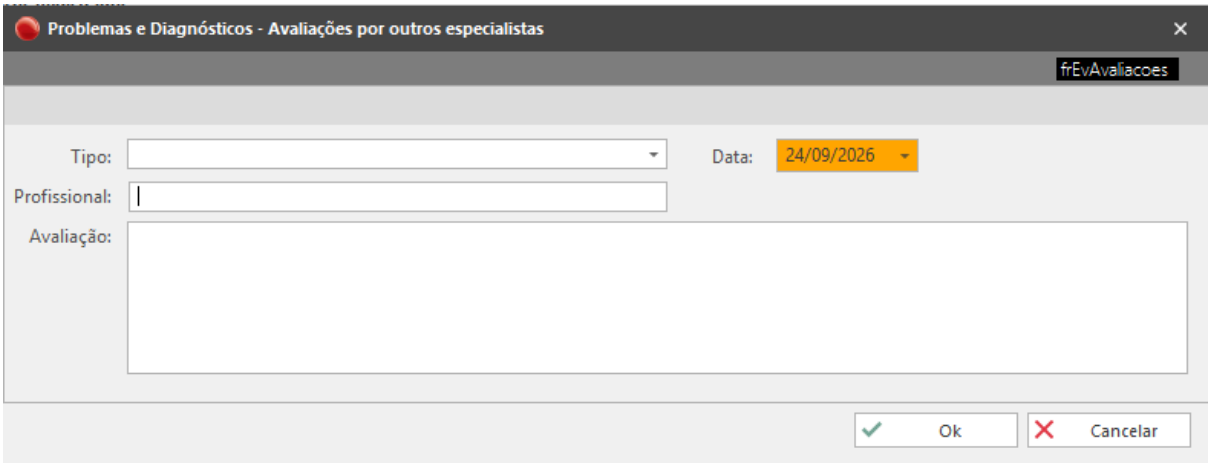
Transfusão Sanguínea:



Tipo: Hemácias, outro, Plaquetas, Plasma, Total

Responsável: nome dos médicos registrados

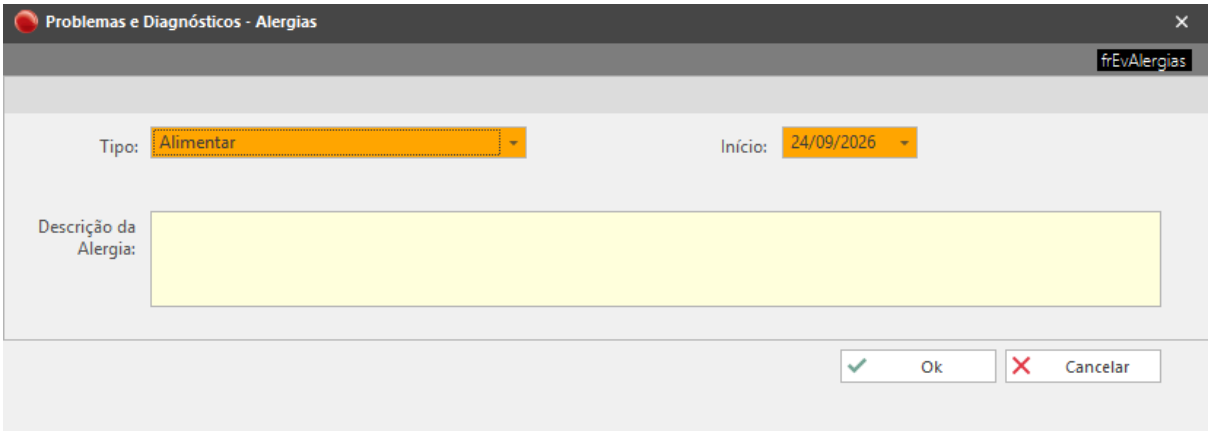
Avaliação por outro especialista:



Tipo: especialidade (cargo) do outro profissional que avaliou

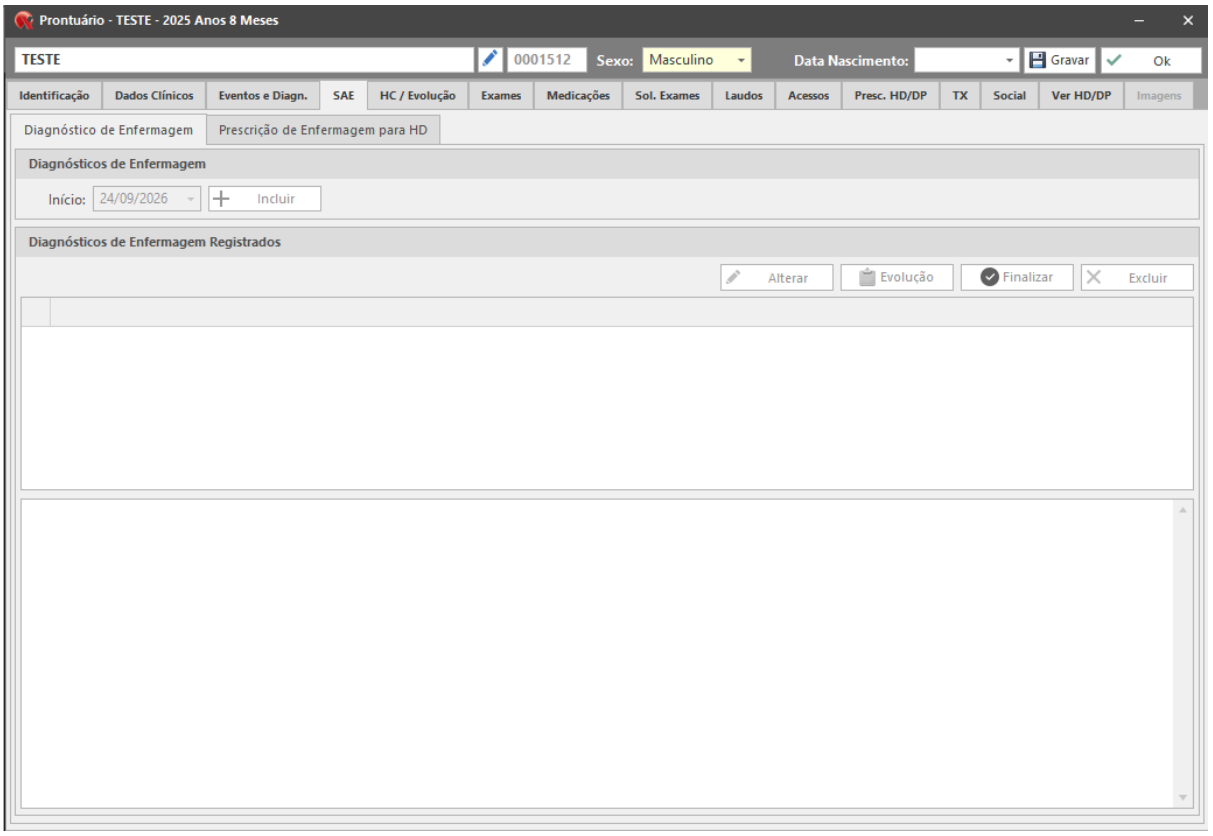
Profissional: incluir seleção de especialistas registrados no AGHU

Alergias:



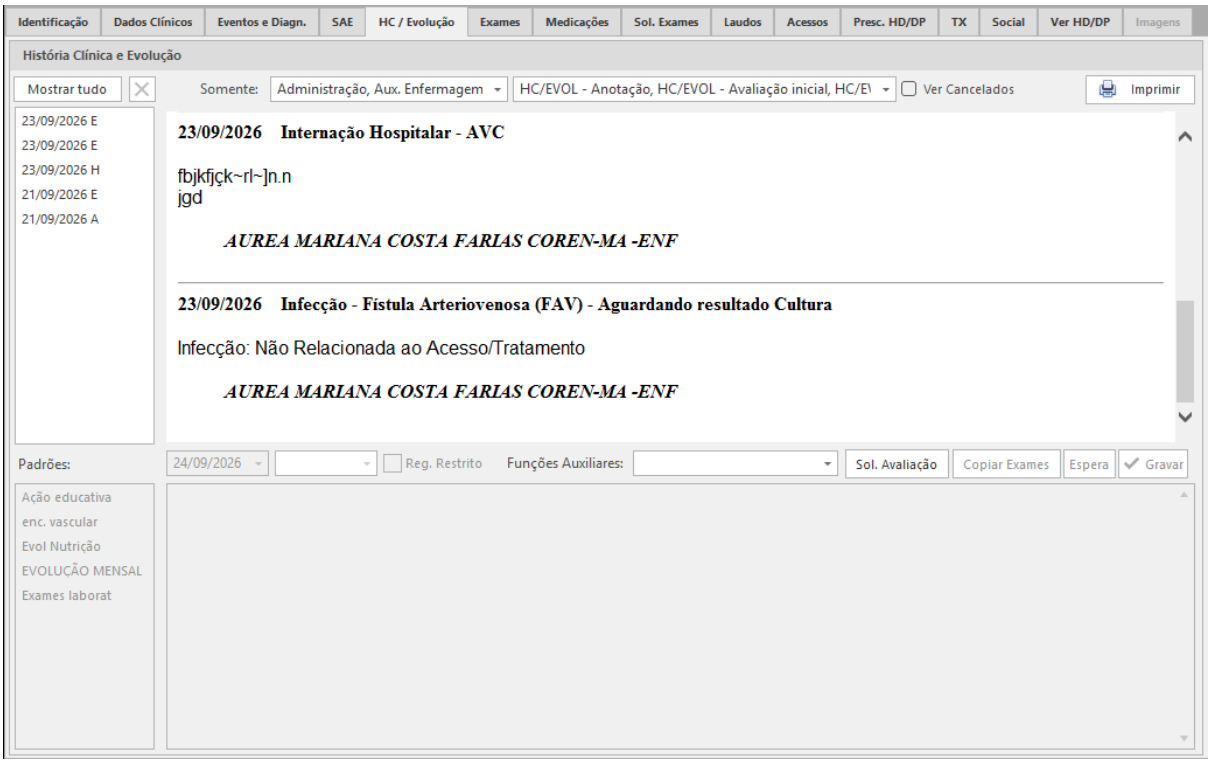
OBS: Classificadas como alimentar, medicamentosa e outra, com alimentar e outra tendo um campo de descrição da alergia e medicamentosa com campo campo para selecionar a alergia medicamentosa entre as registradas

SAE:



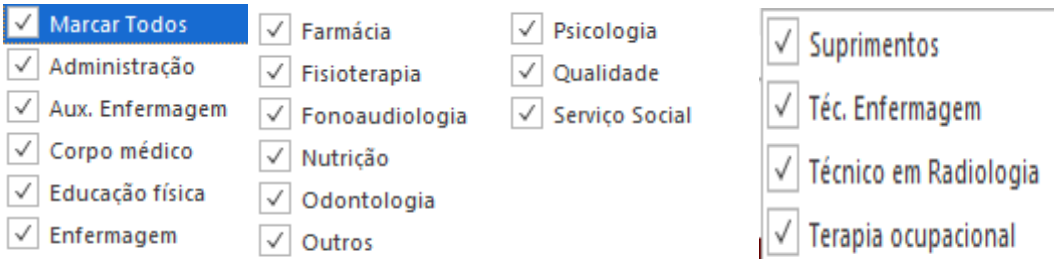
OBS: Não é utilizado

HC / Evolução:



OBS: Histórico de sessões com o tipo e data, demonstrar observações registradas por item

Opções de filtros:

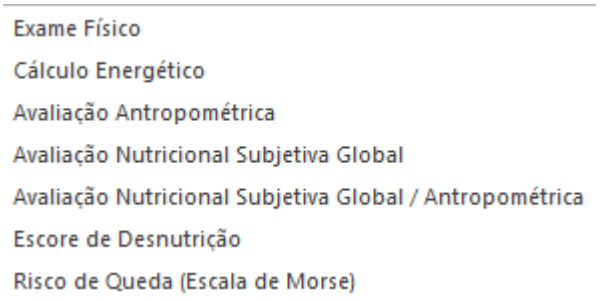


e filtro por nome dos enfermeiros

Padrões:



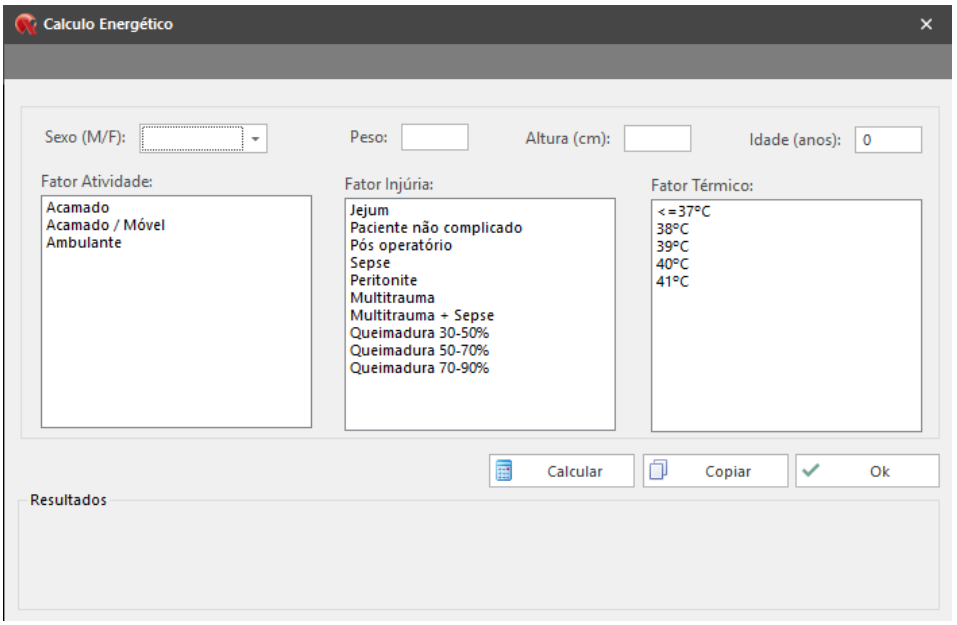
Funções Auxiliares:



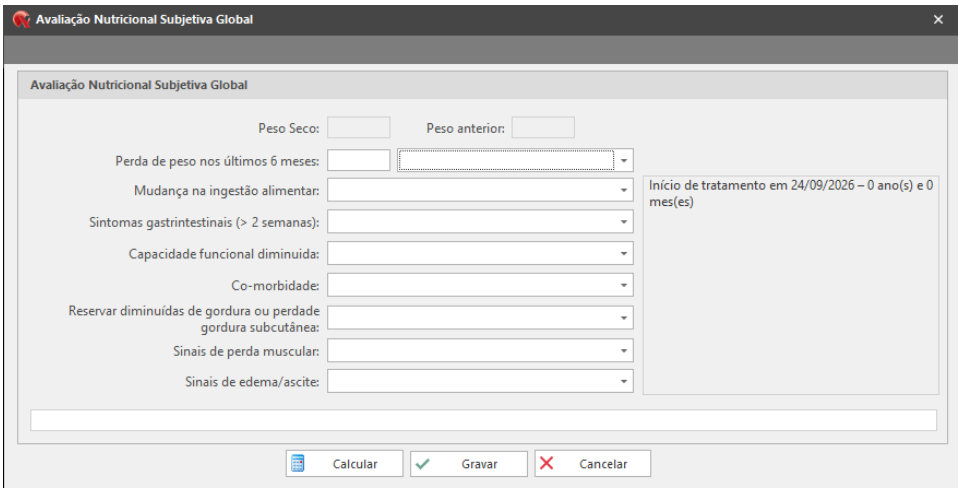
Exame Físico:

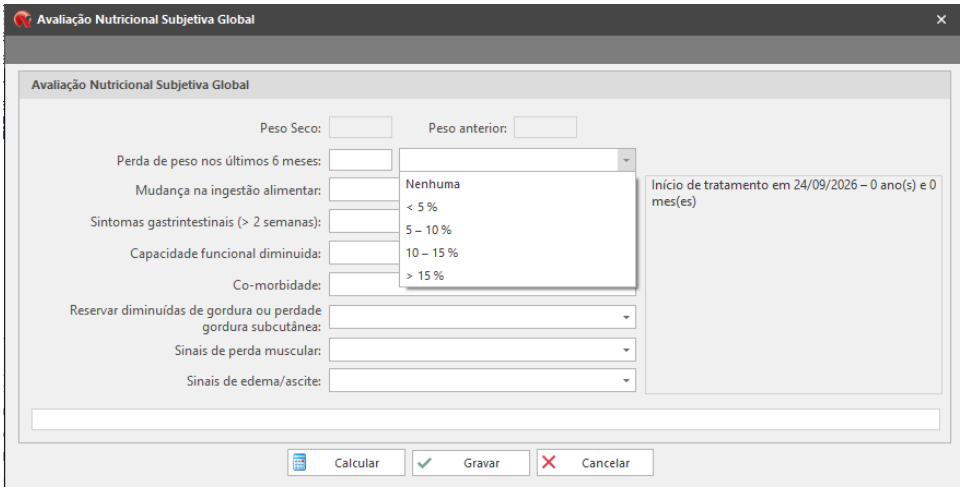


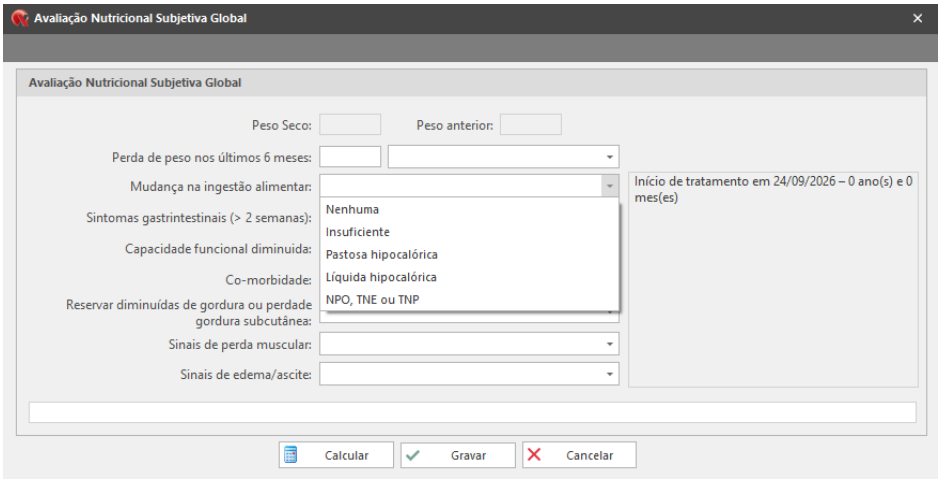
Cálculo Energético:

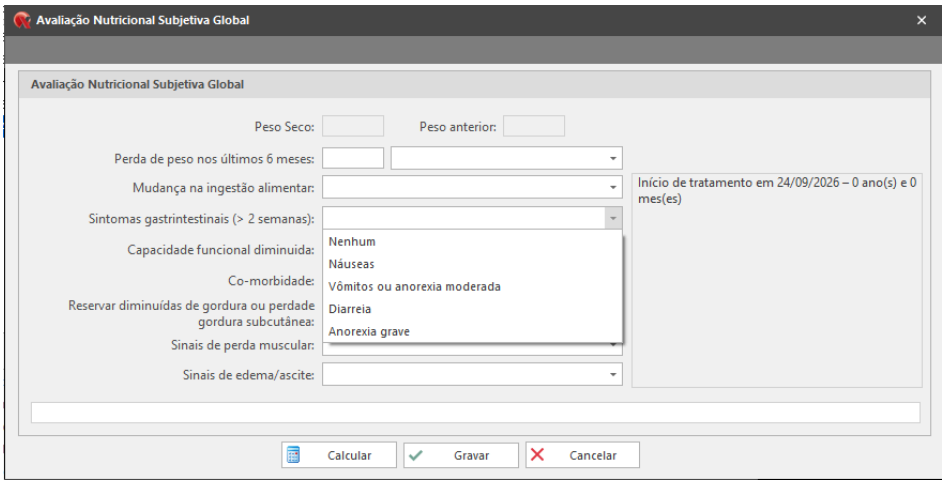


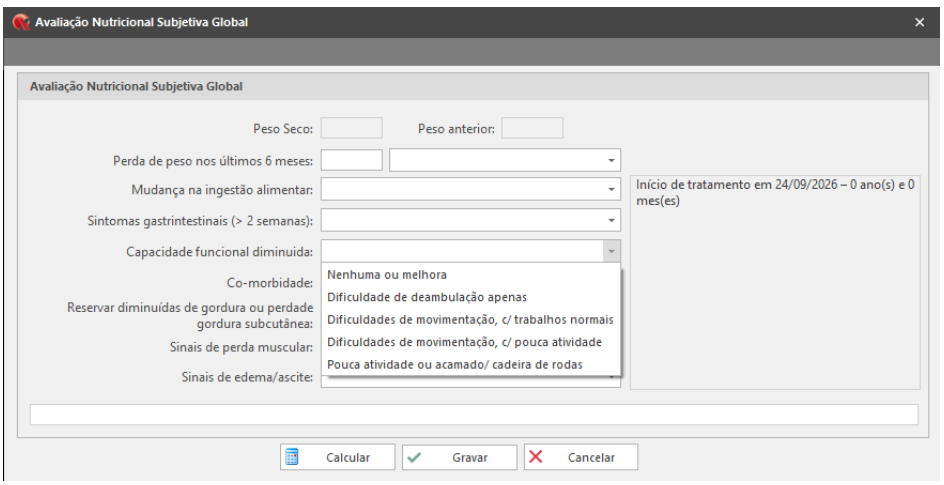
Avaliação Antropométrica:

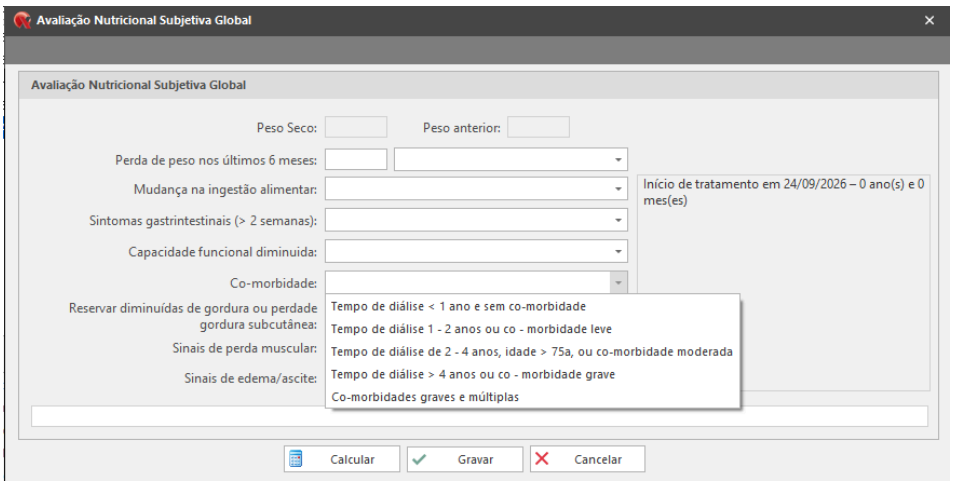





Avaliação Nutricional Subjetiva Global
Avaliação Nutricional Subjetiva Global
Peso Seco:
Peso anterior:
Perda de peso nos últimos 6 meses:
Mudança na ingestão alimentar:
Sintomas gastrintestinais (> 2 semanas):
Capacidade funcional diminuida:
Co-morbidade:
Reservar diminuídas de gordura ou perdade gordura subcutânea:
Sinais de perda muscular:
Sinais de edema/ascite:
Nenhuma
Insuficiente
Pastosa hipocalórica
Líquida hipocalórica
NPO, TNE ou TNP
Início de tratamento em 24/09/2026 – 0 ano(s) e 0 mes(es)
Calcular
Gravar
Cancelar


Avaliação Nutricional Subjetiva Global
Avaliação Nutricional Subjetiva Global
Peso Seco:
Peso anterior:
Perda de peso nos últimos 6 meses:
Mudança na ingestão alimentar:
Sintomas gastrintestinais (> 2 semanas):
Capacidade funcional diminuida:
Co-morbidade:
Reservar diminuídas de gordura ou perdade gordura subcutânea:
Sinais de perda muscular:
Sinais de edema/ascite:
Nenhum
Náuseas
Vômitos ou anorexia moderada
Diarreia
Anorexia grave
Início de tratamento em 24/09/2026 – 0 ano(s) e 0 mes(es)
Calcular
Gravar
Cancelar


Avaliação Nutricional Subjetiva Global
Avaliação Nutricional Subjetiva Global
Peso Seco:
Peso anterior:
Perda de peso nos últimos 6 meses:
Mudança na ingestão alimentar:
Sintomas gastrintestinais (> 2 semanas):
Capacidade funcional diminuida:
Co-morbidade:
Reservar diminuídas de gordura ou perdade gordura subcutânea:
Sinais de perda muscular:
Sinais de edema/ascite:
Nenhuma ou melhora
Dificuldade de deambulação apenas
Dificuldades de movimentação, c/ trabalhos normais
Dificuldades de movimentação, c/ pouca atividade
Pouca atividade ou acamado/ cadeira de rodas
Início de tratamento em 24/09/2026 – 0 ano(s) e 0 mes(es)
Calcular
Gravar
Cancelar



Campos - Reservar diminuídas de gordura ou perda de gordura subcutânea | Sinais de perda muscular | Sinais de edema/ascite: Todos com opção de classificar como nenhuma, leve, moderada ou grave.

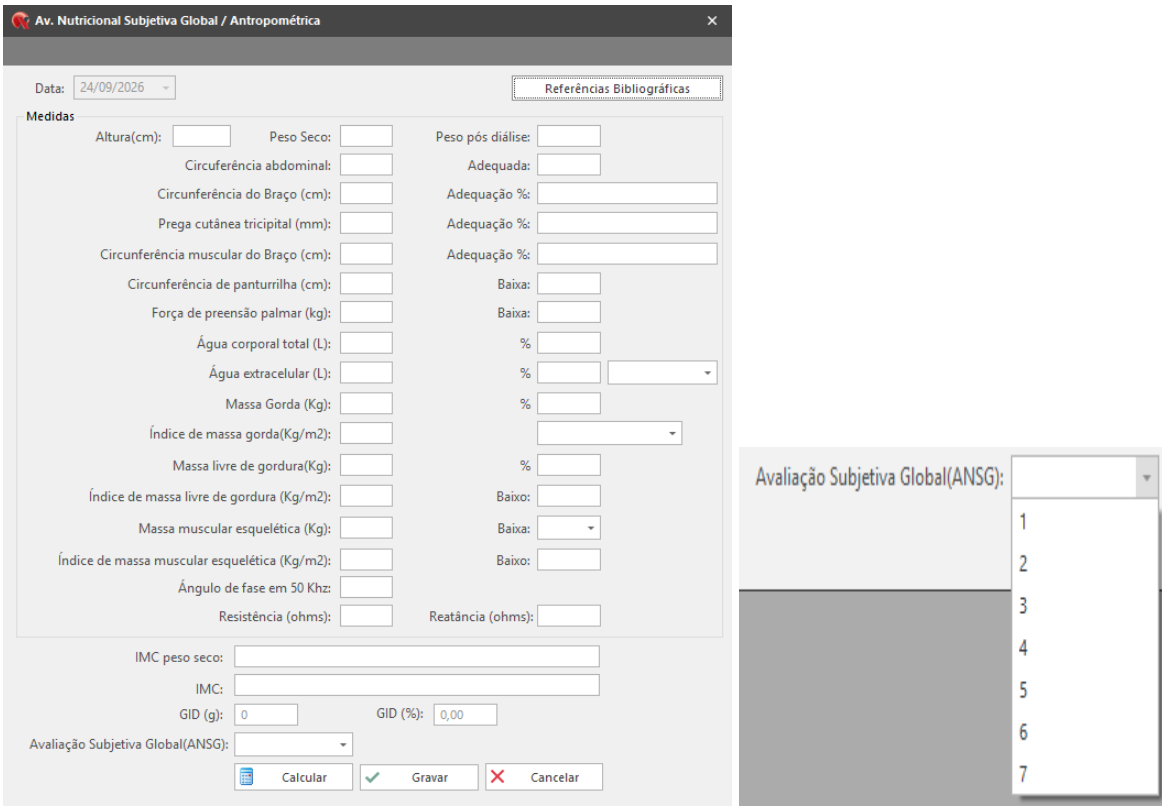
Nenhuma

Leve

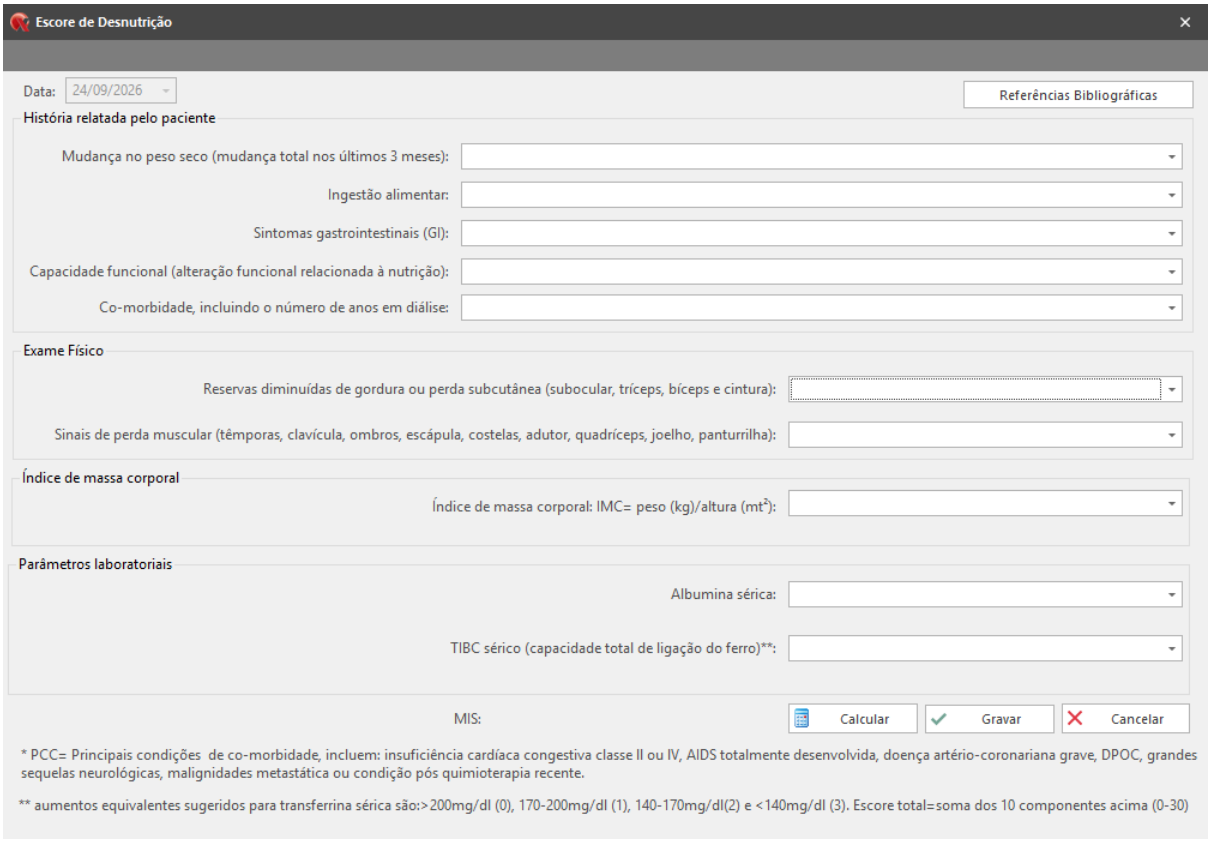
Moderada

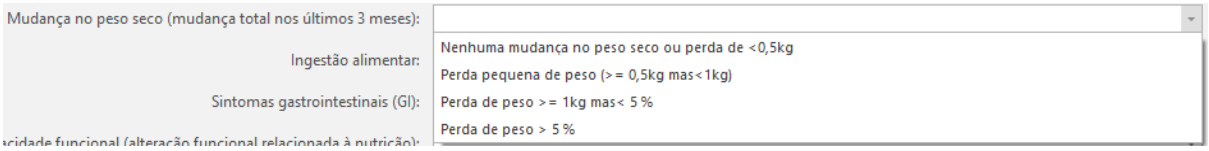
Grave

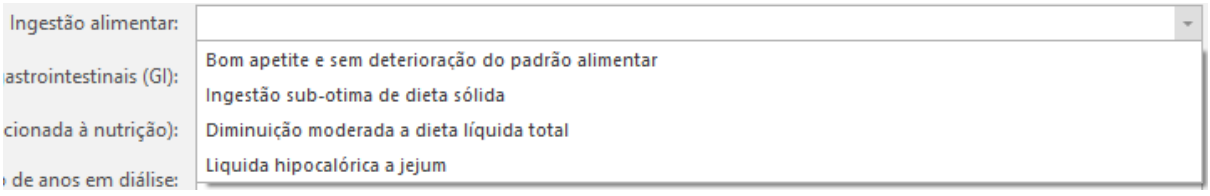
AV. Nutricional Subjetiva Global / Antropométrica

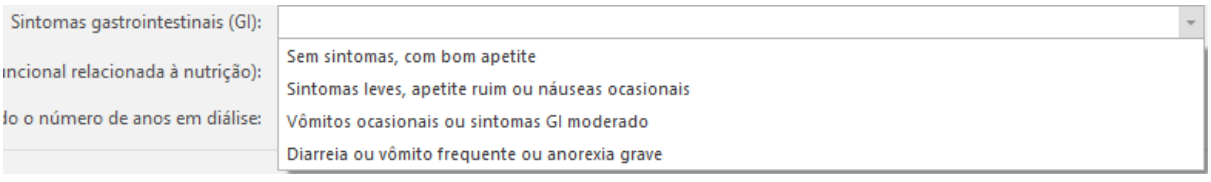


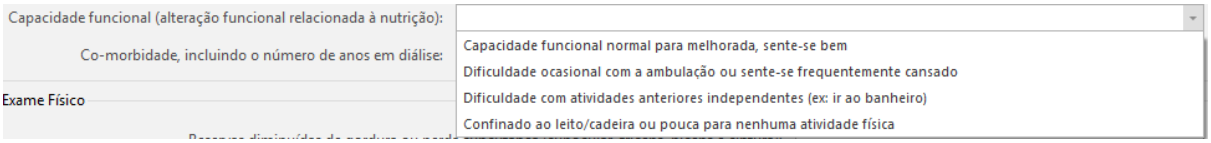
OBS: Campos de observação das porcentagem com opções de abaixo, dentro da faixa e acima e campo de baixa com opção de sim e não

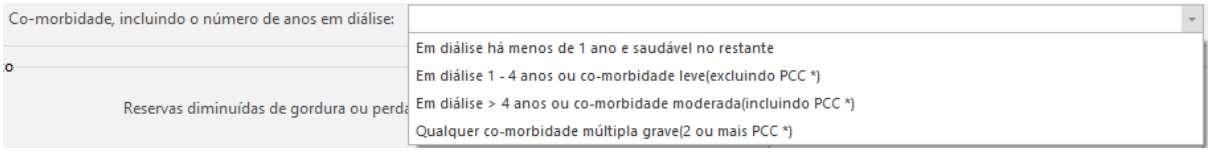

Escore de Desnutrição
Data: 24/09/2026
Referências Bibliográficas
História relatada pelo paciente
Mudança no peso seco (mudança total nos últimos 3 meses):
Ingestão alimentar:
Sintomas gastrointestinais (GI):
Capacidade funcional (alteração funcional relacionada à nutrição):
Co-morbidade, incluindo o número de anos em diálise:
Exame Físico
Reservas diminuídas de gordura ou perda subcutânea (subocular, tríceps, bíceps e cintura):
Sinais de perda muscular (têmporas, clavícula, ombros, escápula, costelas, adutor, quadríceps, joelho, panturrilha):
Índice de massa corporal
Índice de massa corporal: IMC= peso (kg)/altura (mt²):
Parâmetros laboratoriais
Albumina sérica:
TIBC sérico (capacidade total de ligação do ferro)**:
MIS:
Calcular
Gravar
Cancelar
* PCC= Principais condições de co-morbidade, incluem: insuficiência cardíaca congestiva classe II ou IV, AIDS totalmente desenvolvida, doença artério-coronariana grave, DPOC, grandes sequelas neurológicas, malignidades metastática ou condição pós quimioterapia recente.
** aumentos equivalentes sugeridos para transferrina sérica são:>200mg/dl (0), 170-200mg/dl (1), 140-170mg/dl(2) e <140mg/dl (3). Escore total=soma dos 10 componentes acima (0-30)

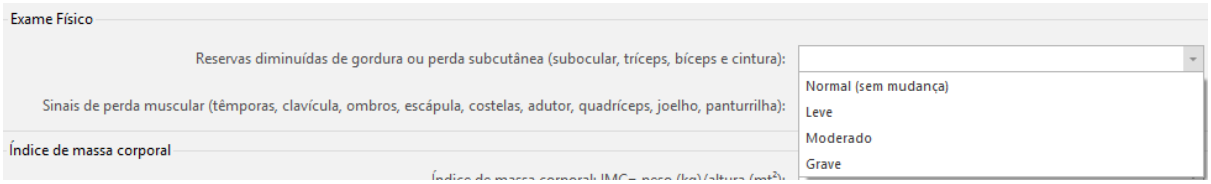

Mudança no peso seco (mudança total nos últimos 3 meses):
Ingestão alimentar:
Sintomas gastrointestinais (GI):
Nenhuma mudança no peso seco ou perda de <0,5kg
Perda pequena de peso (>= 0,5kg mas<1kg)
Perda de peso >= 1kg mas< 5 %
Perda de peso > 5 %


Ingestão alimentar:
Bom apetite e sem deterioração do padrão alimentar
Ingestão sub-otima de dieta sólida
Diminuição moderada a dieta líquida total
Liquida hipocalórica a jejum

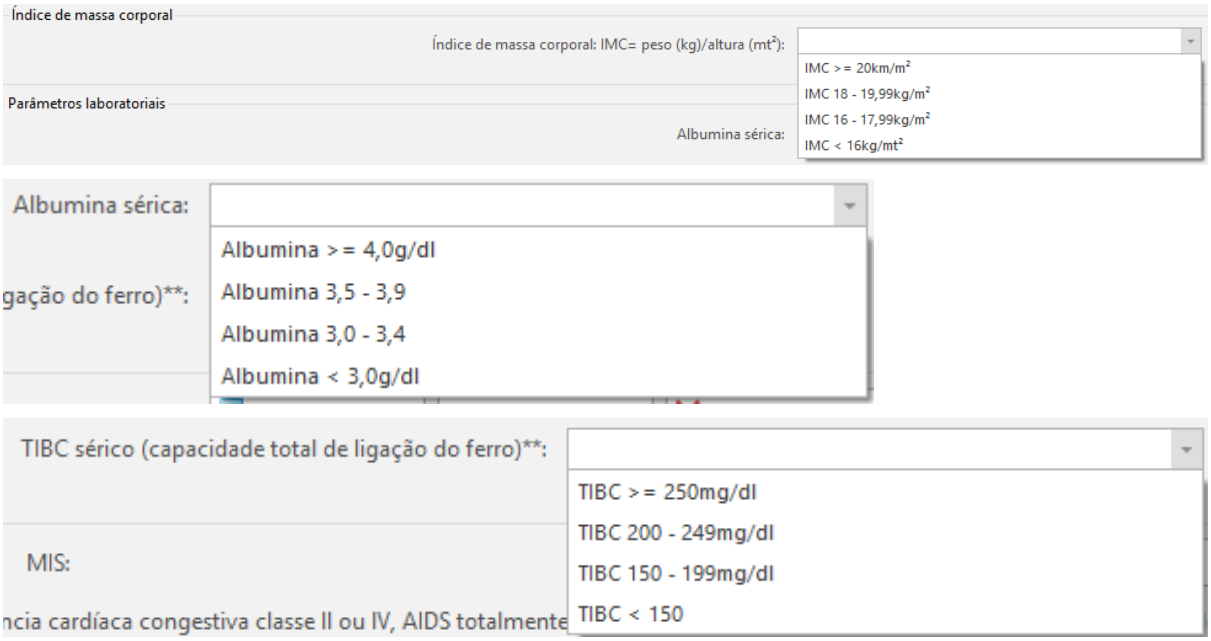

Sintomas gastrointestinais (GI):
Sem sintomas, com bom apetite
Sintomas leves, apetite ruim ou náuseas ocasionais
Vômitos ocasionais ou sintomas GI moderado
Diarreia ou vômito frequente ou anorexia grave


Capacidade funcional (alteração funcional relacionada à nutrição):
Co-morbidade, incluindo o número de anos em diálise:
Capacidade funcional normal para melhorada, sente-se bem
Dificuldade ocasional com a ambulação ou sente-se frequentemente cansado
Dificuldade com atividades anteriores independentes (ex: ir ao banheiro)
Confinado ao leito/cadeira ou pouca para nenhuma atividade física

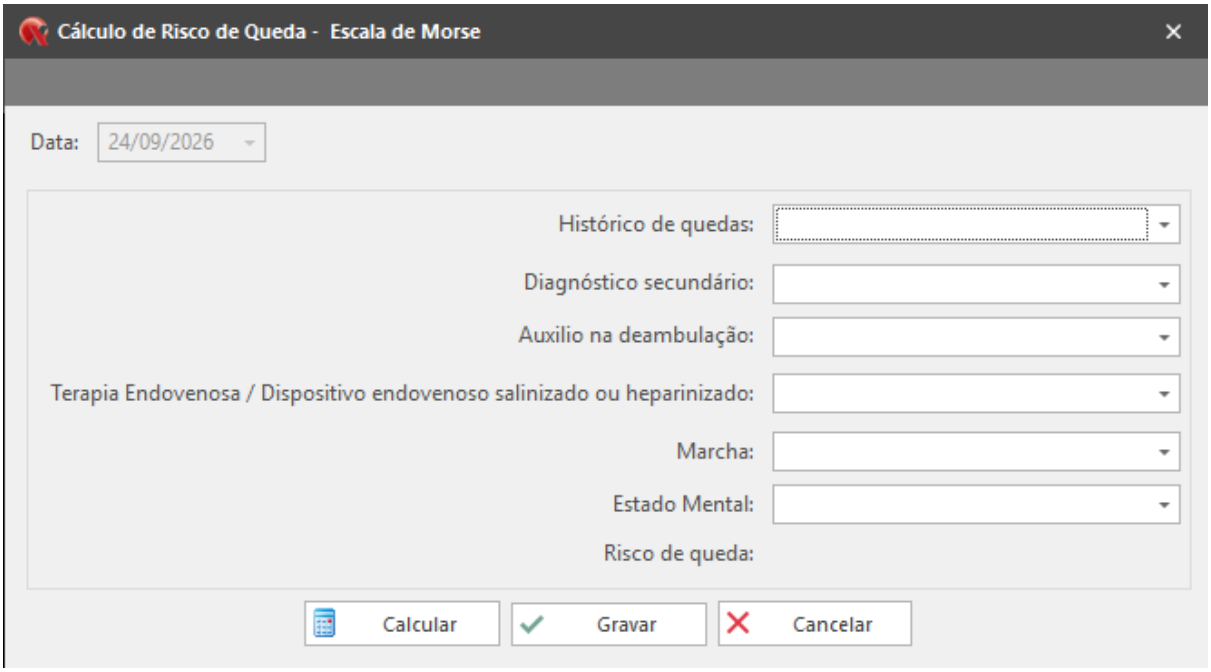

Co-morbidade, incluindo o número de anos em diálise:
Em diálise há menos de 1 ano e saudável no restante
Em diálise 1 - 4 anos ou co-morbidade leve(excluindo PCC *)
Em diálise > 4 anos ou co-morbidade moderada(incluindo PCC *)
Qualquer co-morbidade múltipla grave(2 ou mais PCC *)



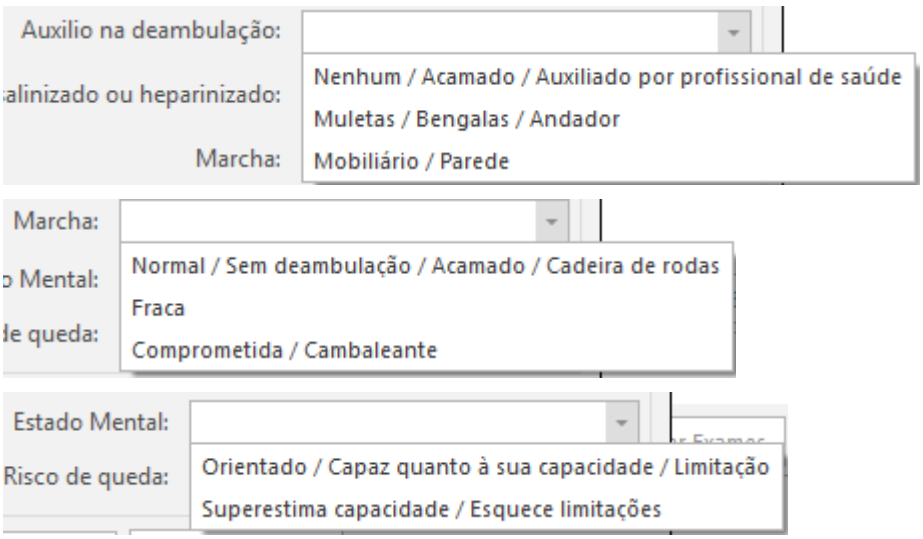
OBS: Ambos os campos têm as mesmas opções



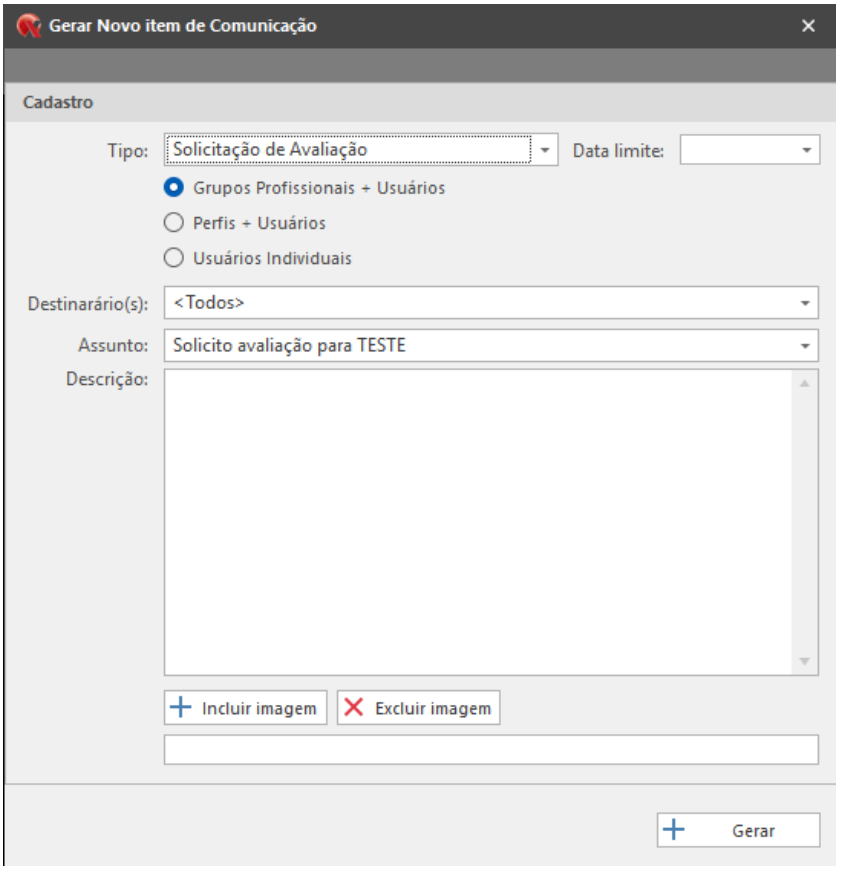
Cálculo de risco de queda:



OBS: Campos Histórico de quedas, Diagnóstico secundário e Terapia Endovenosa / Dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado com as mesmas opções de sim ou não (sugestão de mudar para check box)



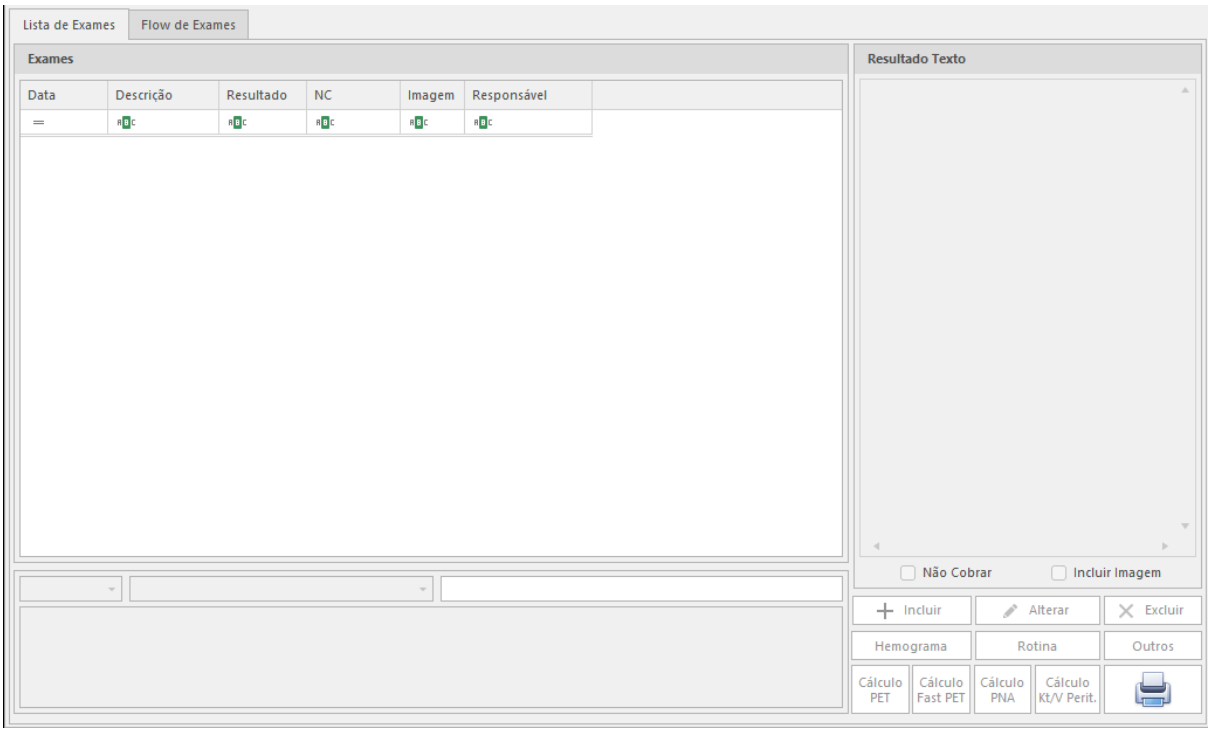
Solicitar Avaliação:



OBS: opções de filtros de destinatário que incluem por grupo profissional, perfis e usuários e usuários individuais

Exames:

Lista de Exames:

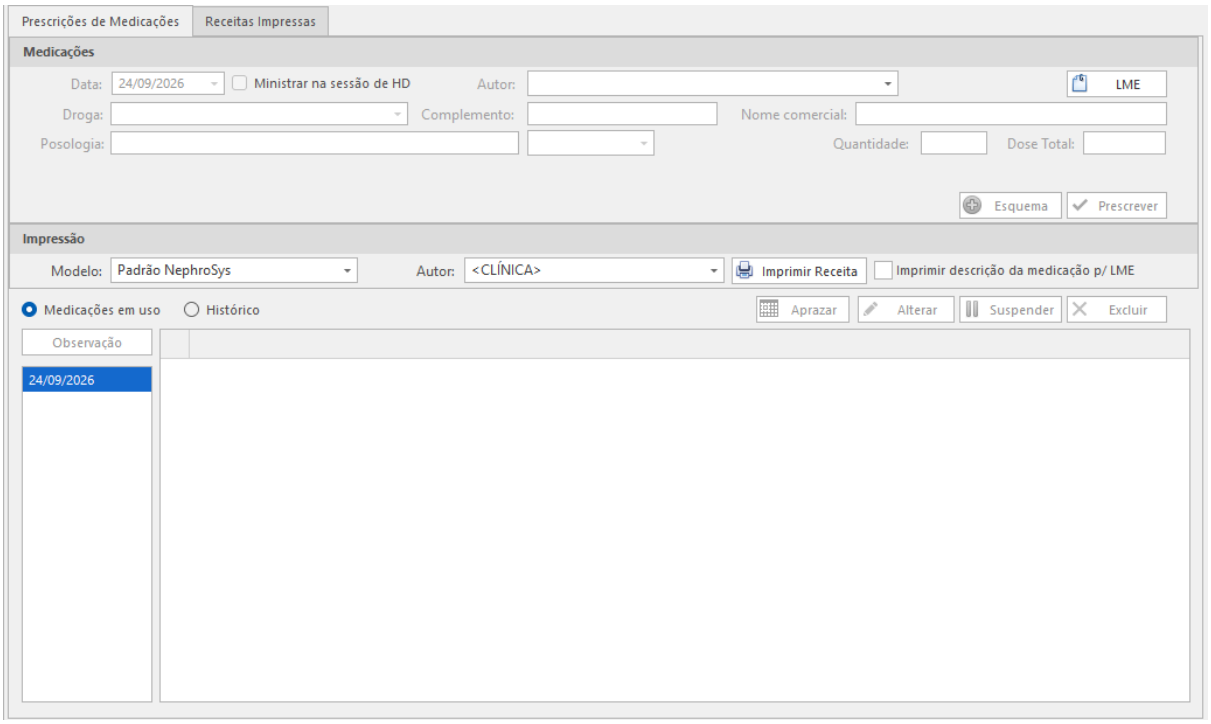


Flow de exames:

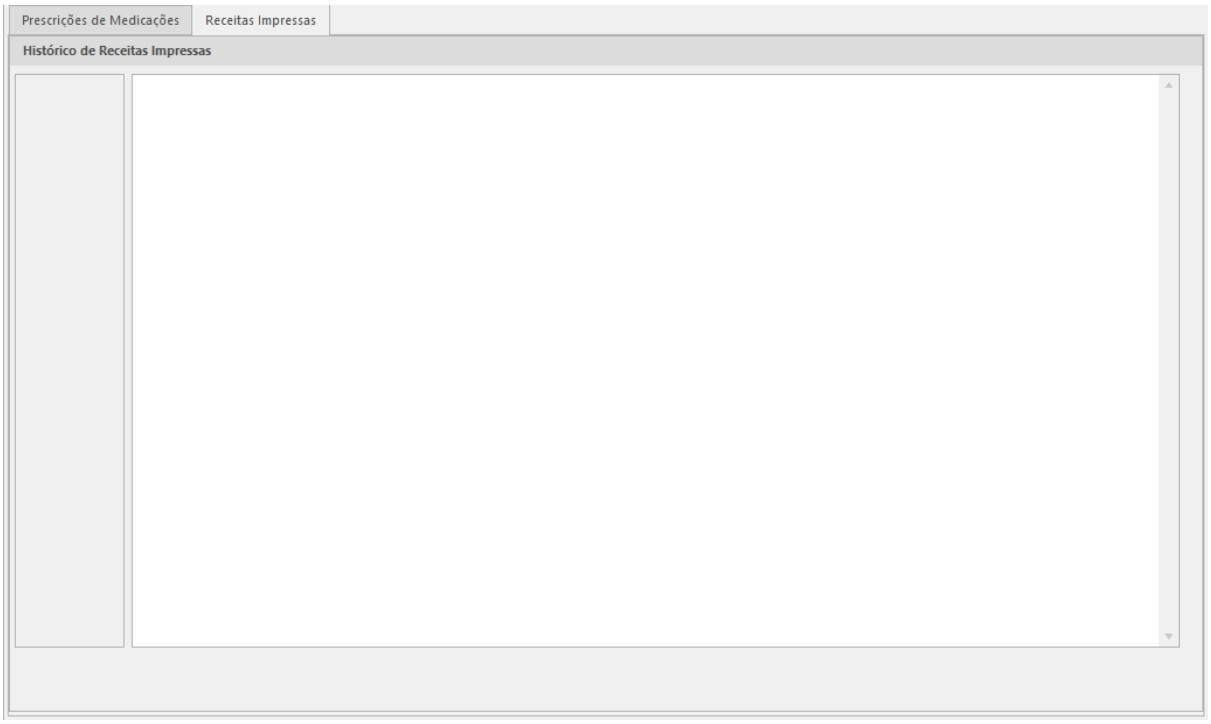


Medicações:

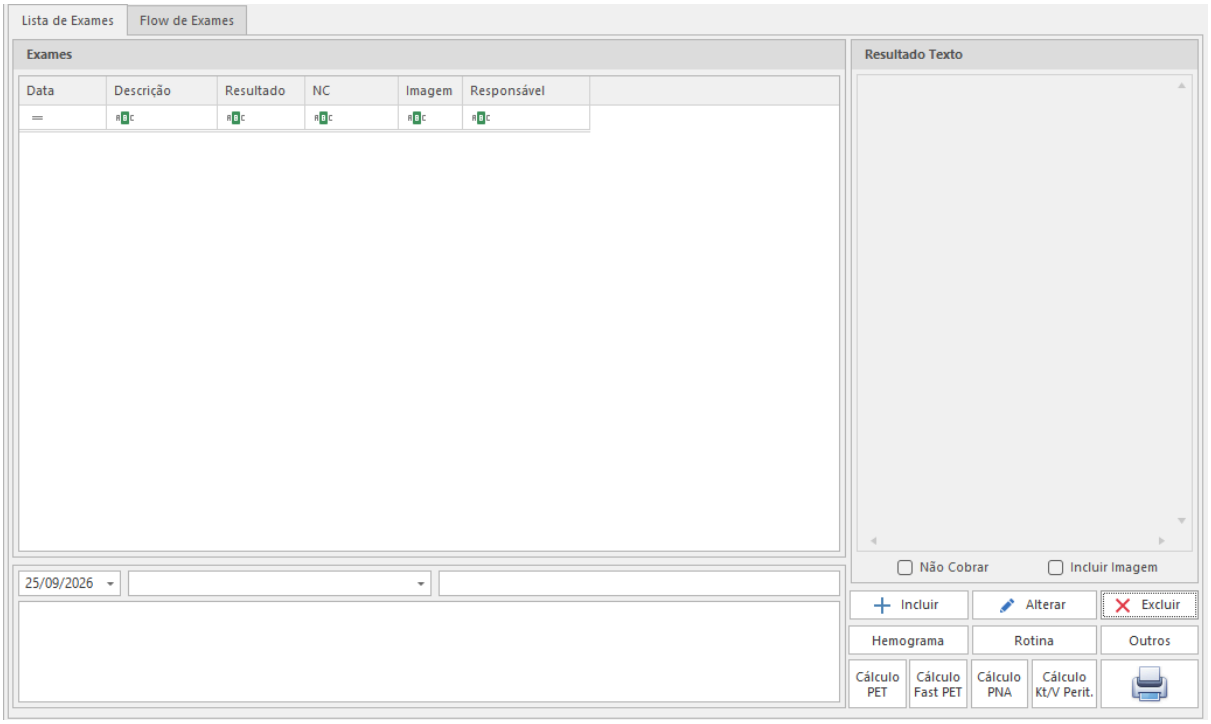
Prescrições de Medicações:



Receitas Impressas:

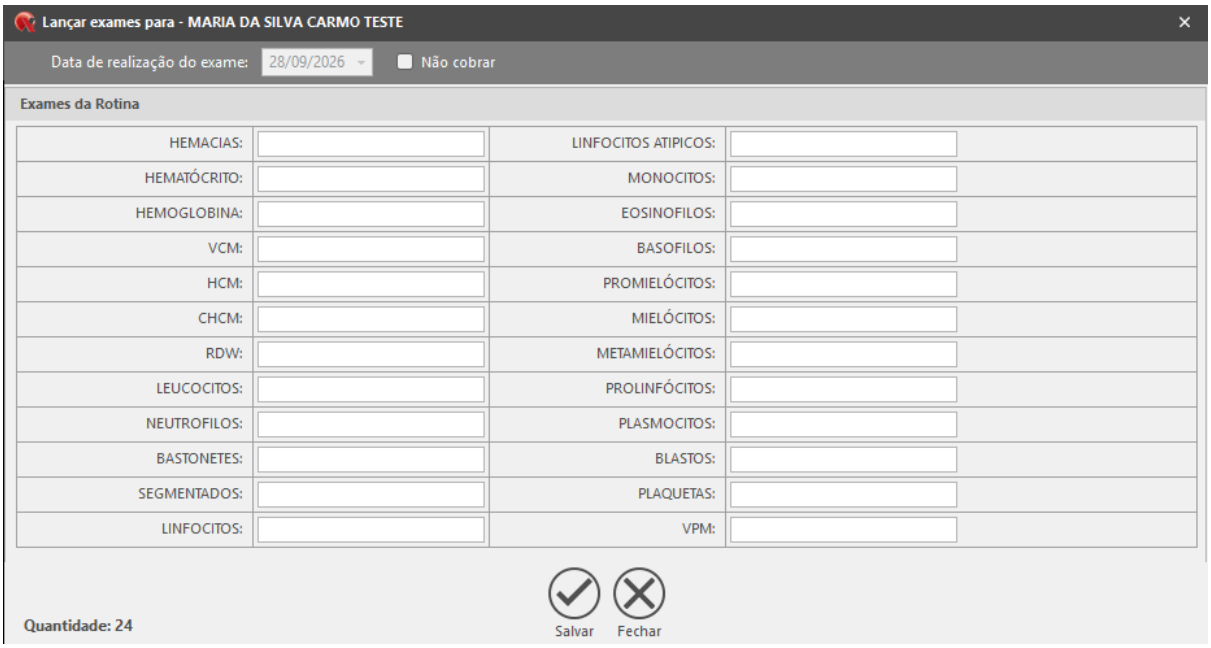


Exames:

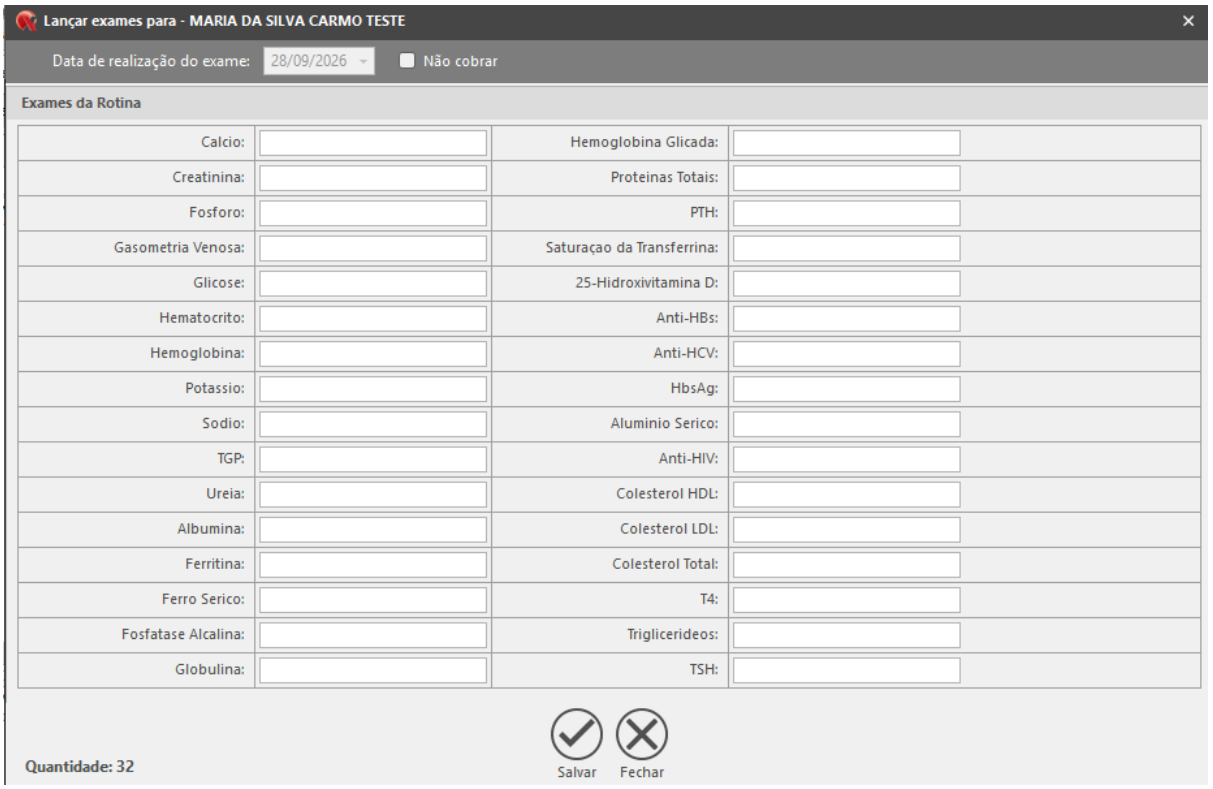


OBS: listar exames utilizados com campo para descrever o resultado, com opções para editar, excluir e incluir.

Hemograma:

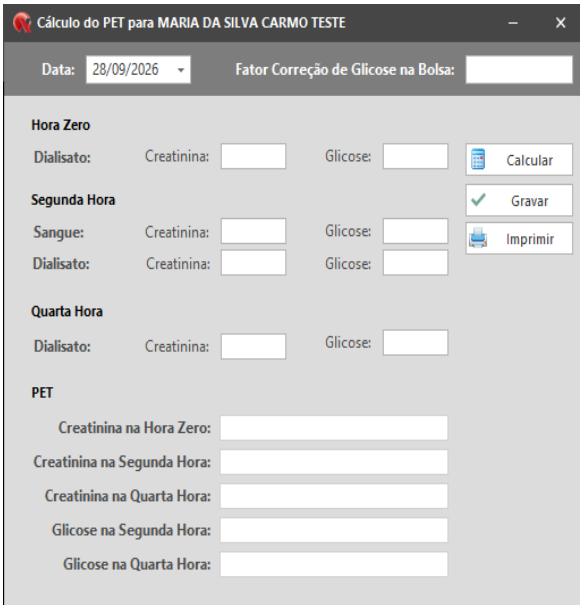


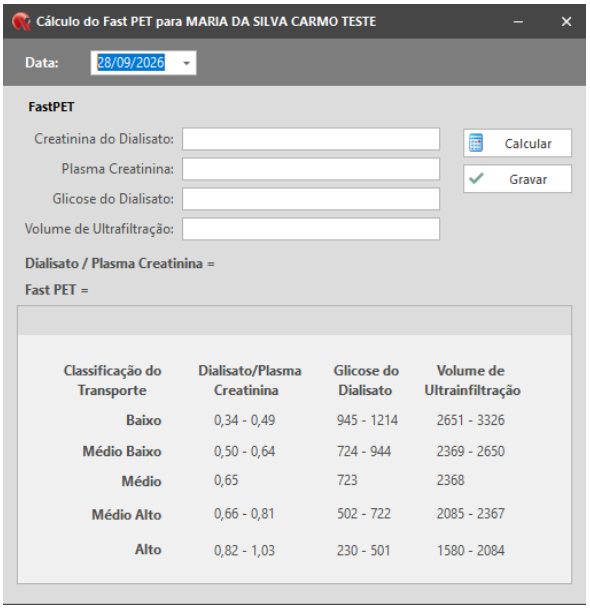
Rotina:



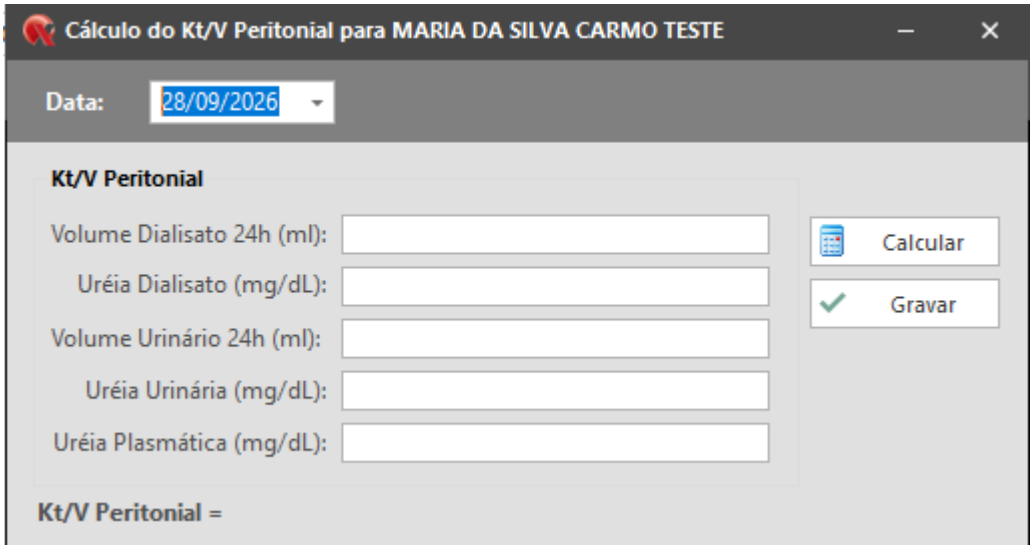
OBS: há um campo para adicionar outro tipo de exame mas só tem a opção de rotina.

Cálculo do PET | Cálculo do Fast PET:



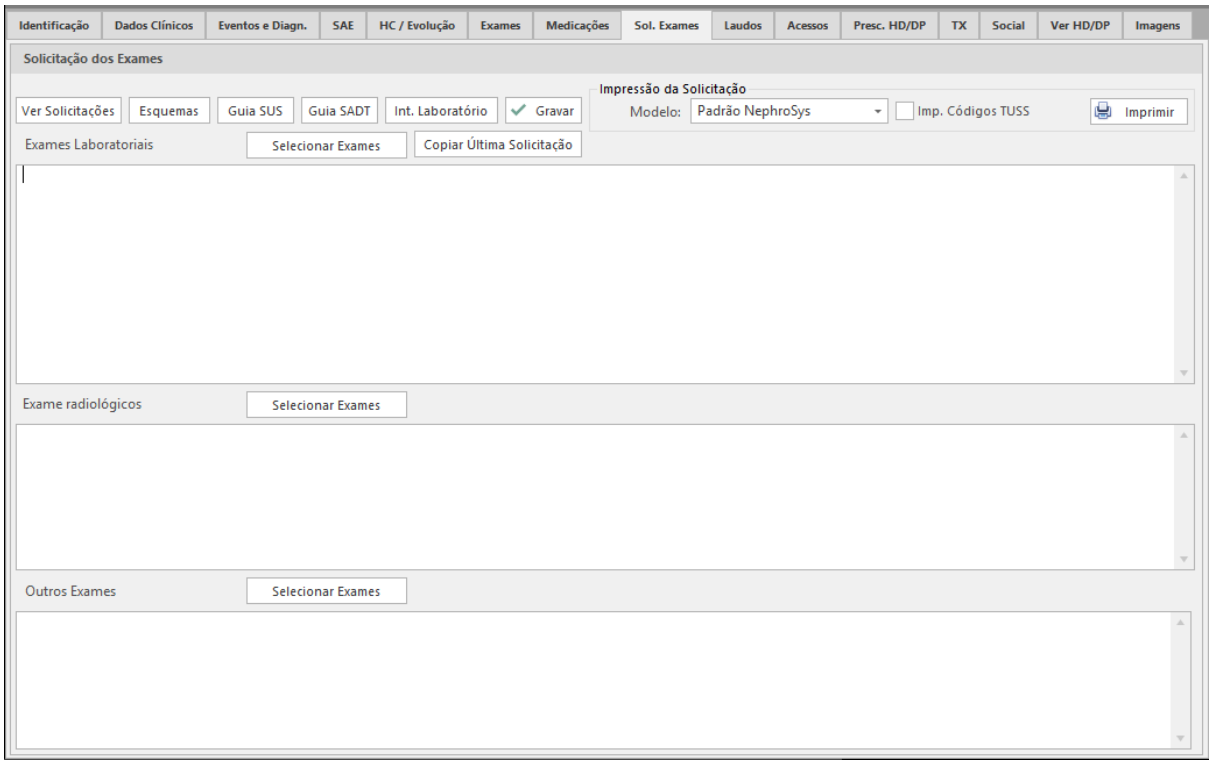


Cálculo do Kt/V Peritonial:

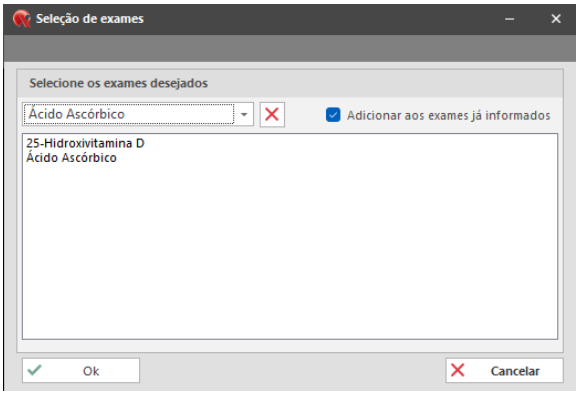


OBS: Todos com opção para calcular com registro depois na tabela e marcações em conjunto com o resultado; Verificar depois o Cálculo do PNA.

Solicitação dos Exames:

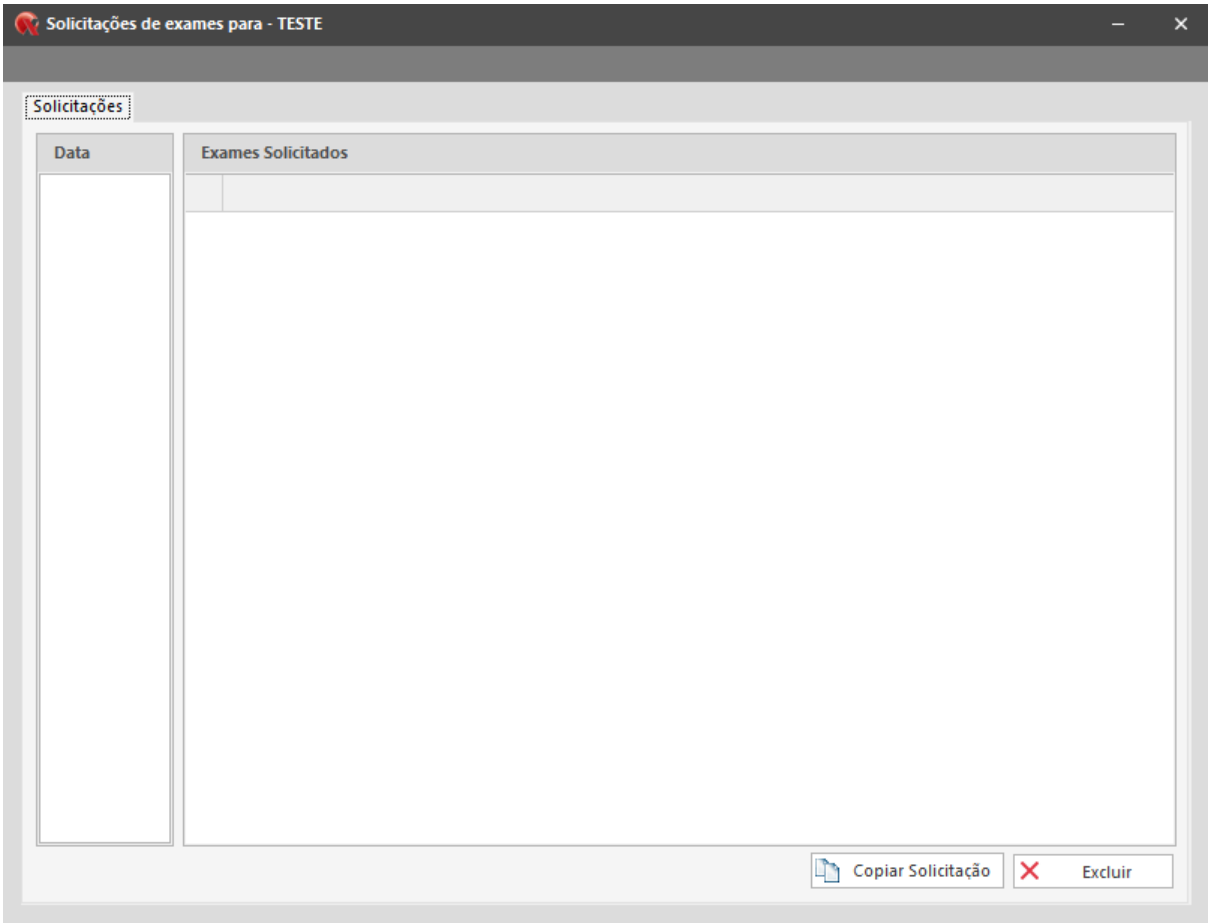


Selecionar Exames:

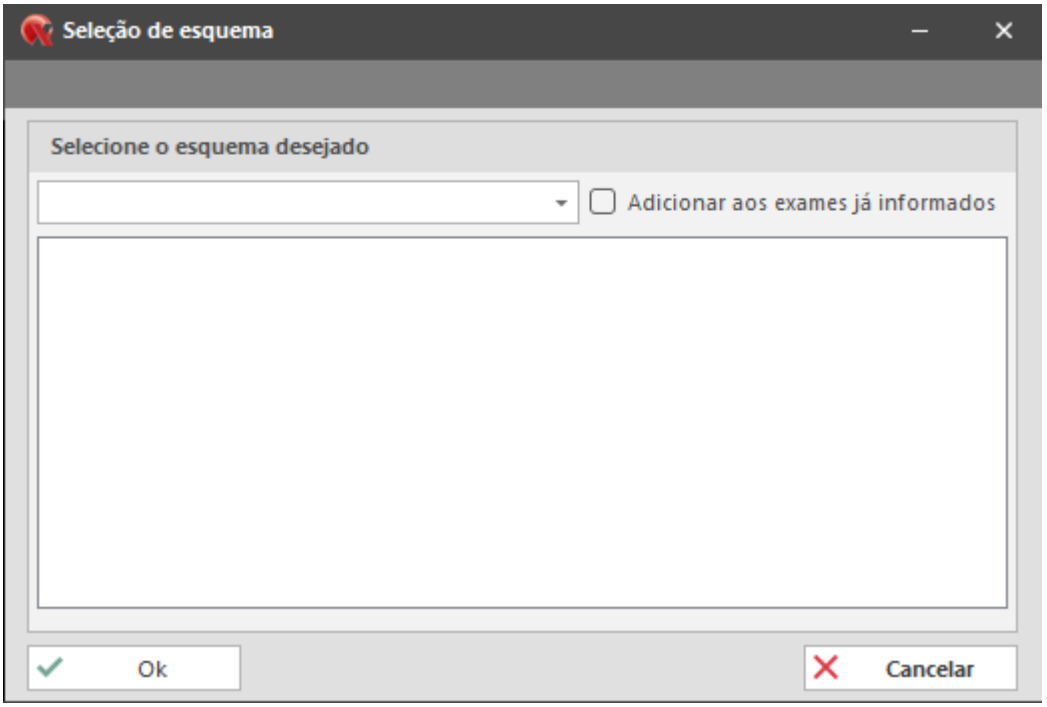


OBS: listagem com exames utilizados (nas 3 opções são os mesmos). com opção de copiar última solicitação

Ver Solicitações | Histórico de exames:

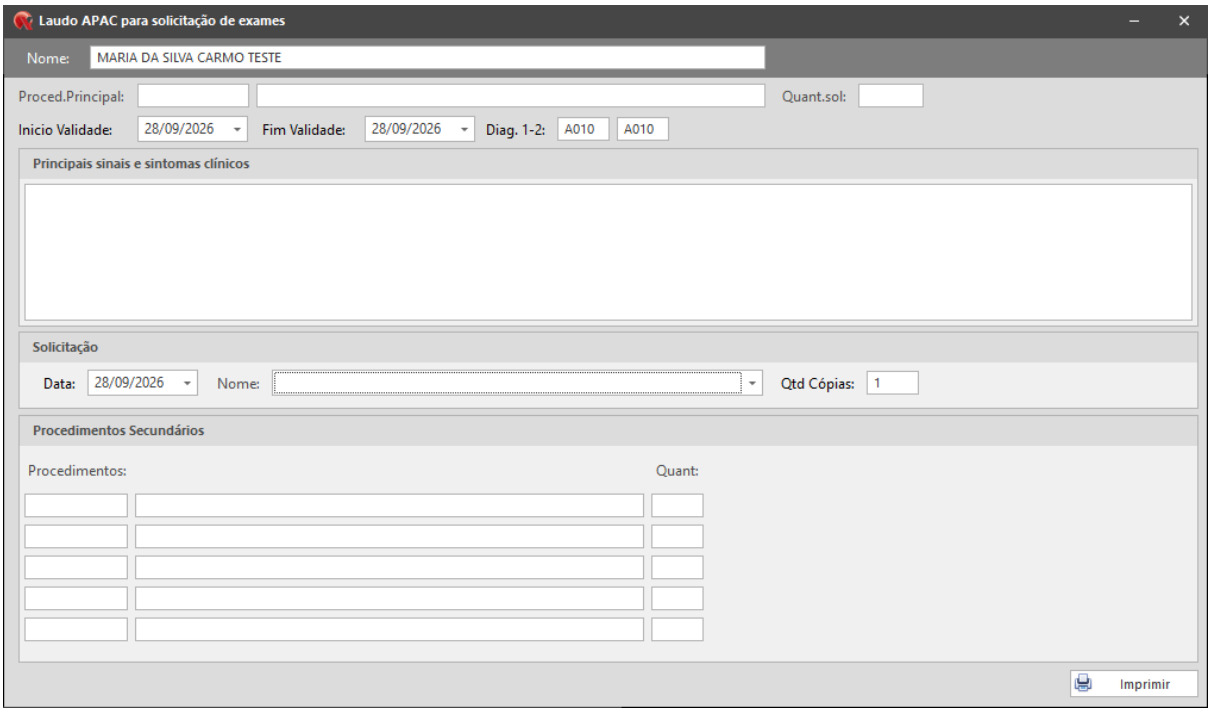


Esquema:

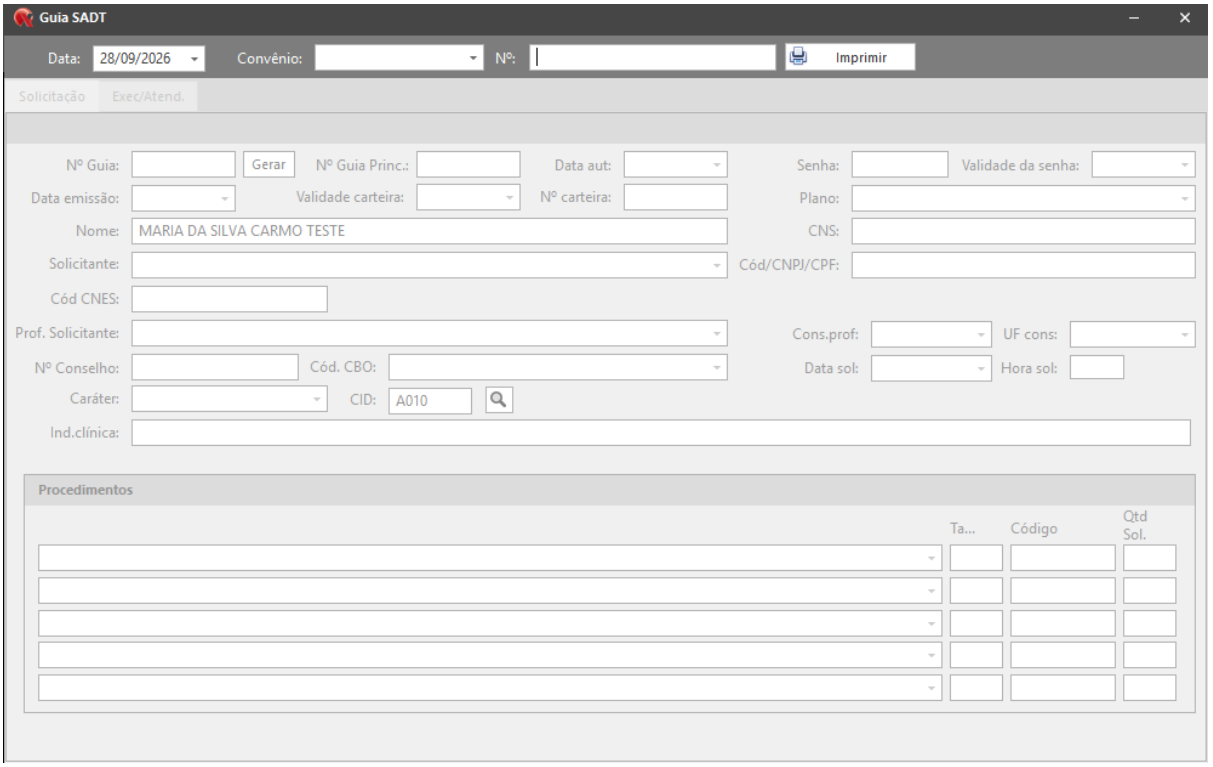


OBS: opção de Rotina SUS, Rotina e Rotina Padrão. Todos funcionam como preenchimento rápido para o campo de exames cada um com alguns componentes de diferença, sugerir uma opção de registro de esquemas por perfil de administrador

Guia SUS | Laudo APAC:

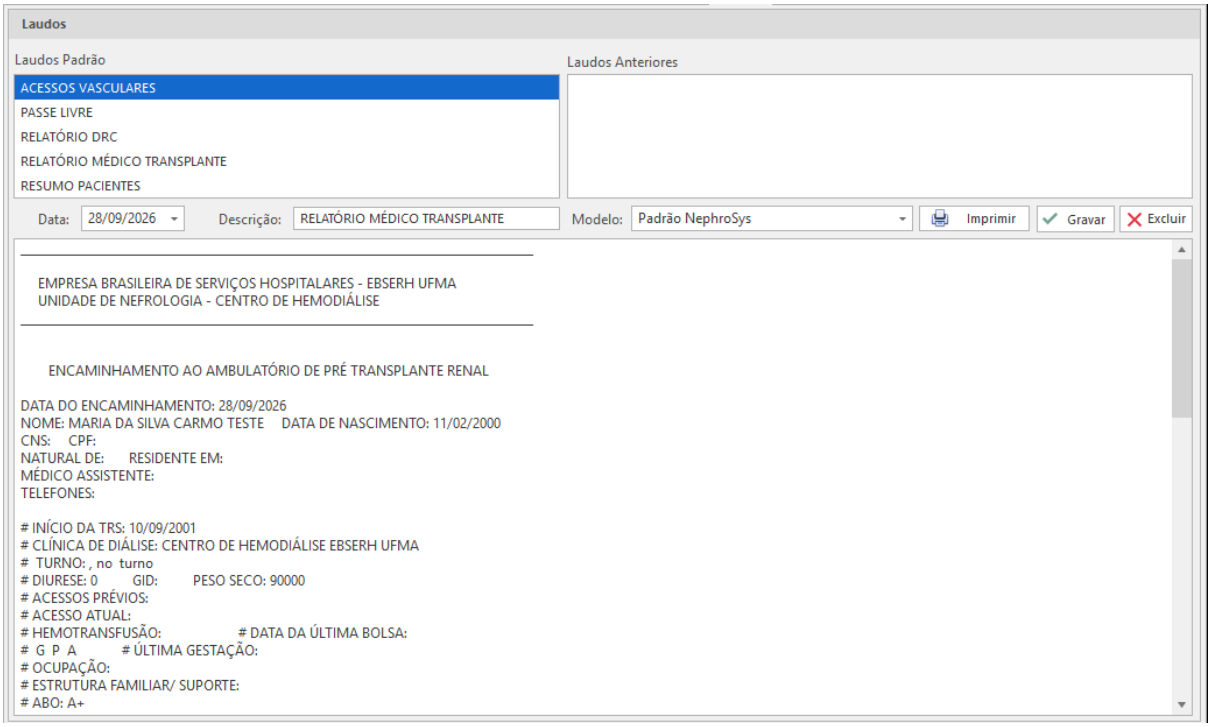


Guia SADT:



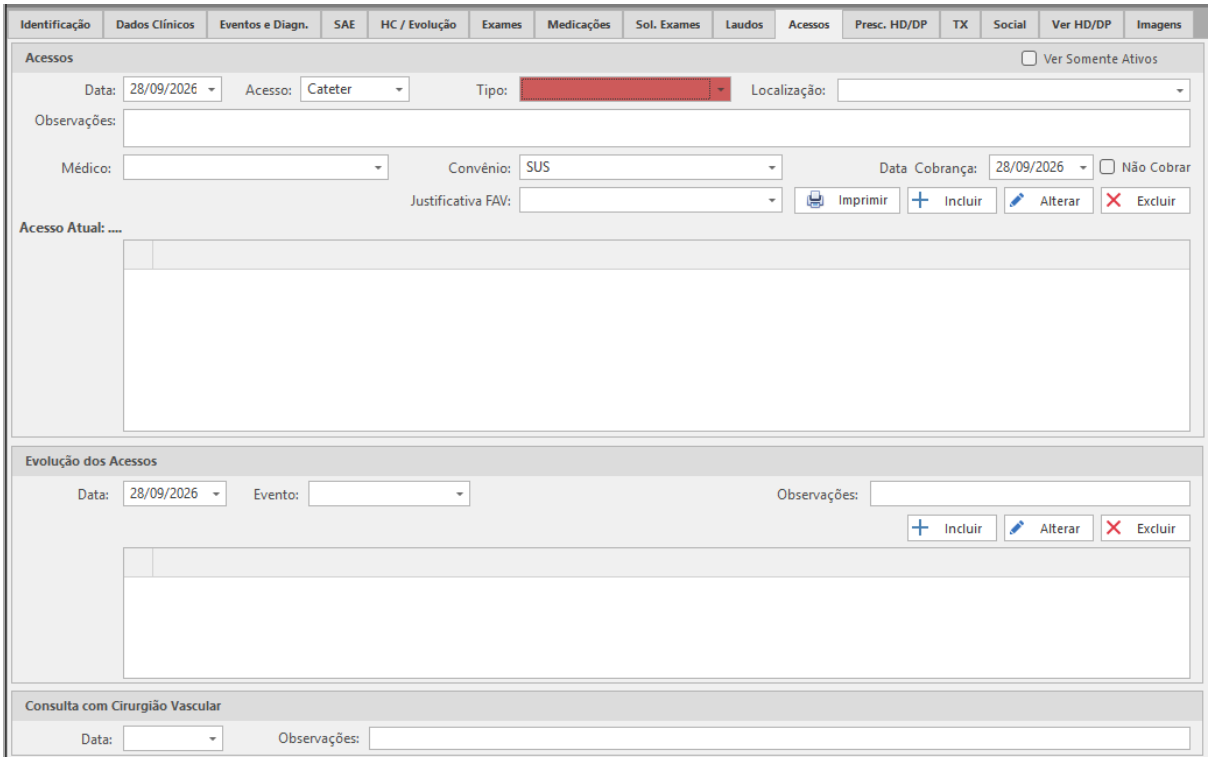
OBS: Aparentemente o int. Laboratório não funciona, verificar modelos de impressão e opção de impressão com código TUSS.

Laudos:

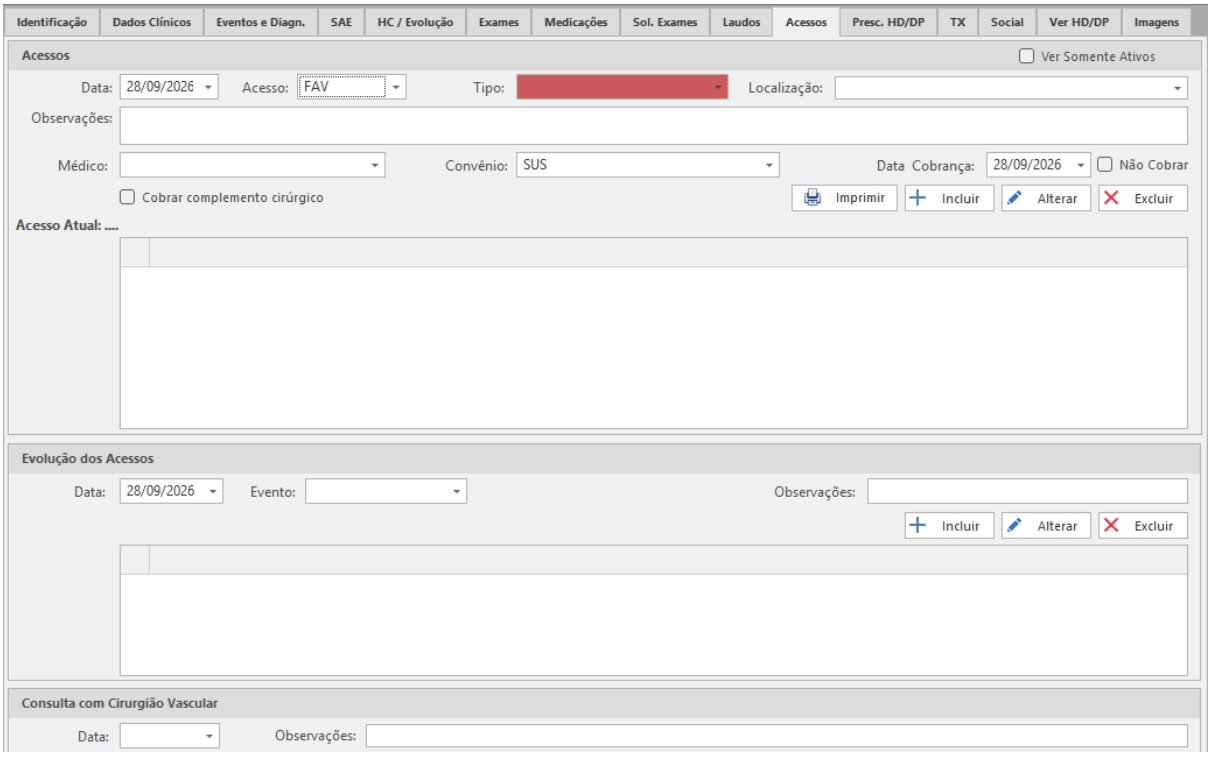


OBS: Modelos de preenchimento rápido com campo para descrição e impressão com modelos diferentes.

Acessos (cateter):



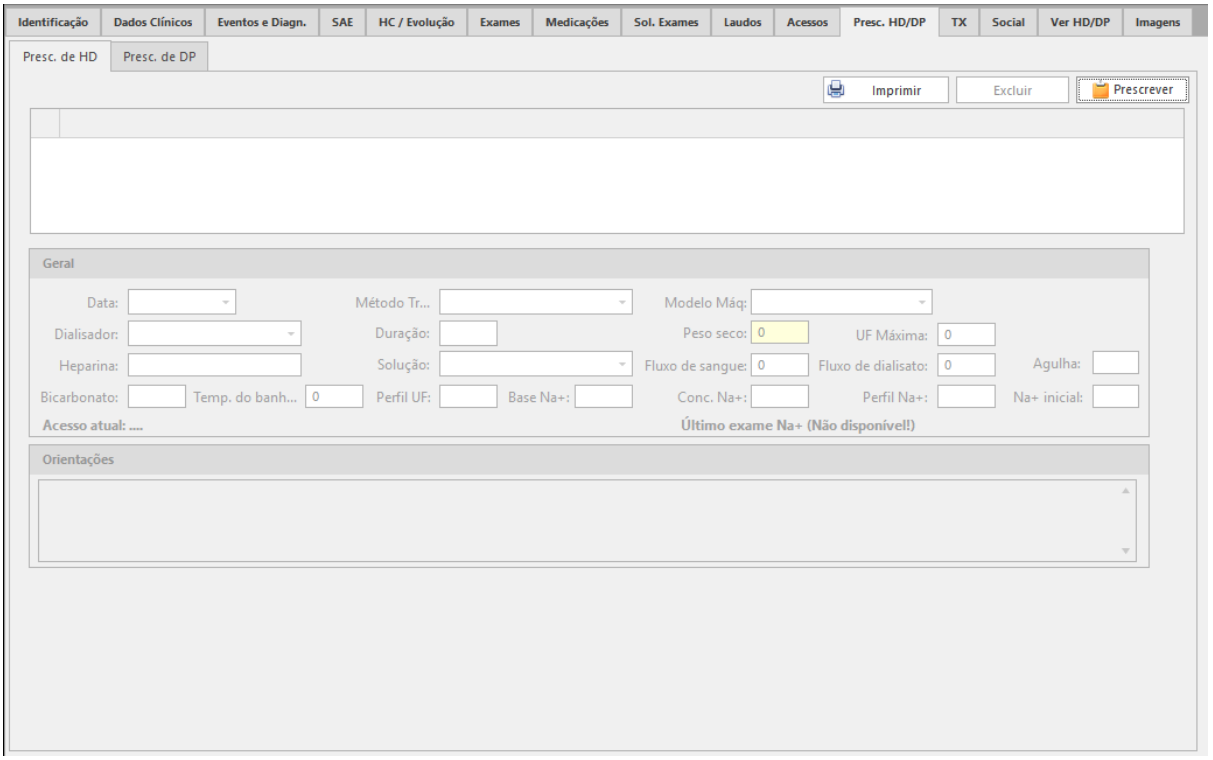
Acessos (FAV):



Localização:

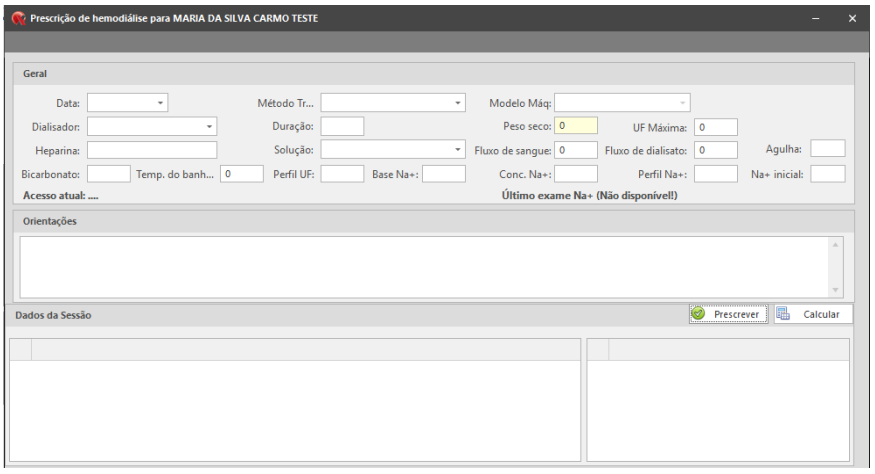
Alça cefálica direita	Braquio cefálica direita	Distal Esquerda	Radio cefálica direita
Alça cefálica esquerda	Braquio cefálica esquerda	Membro Inferior Direita	Radio cefálica esquerda
Alça de basílica Direita	Braquio Umeral direita	Membro Inferior Esquerda	Safeno femoral direita
Alça de basílica Esquerda	Braquio Umeral esquerda	Outra	Safeno femoral esquerda
Alça de Femoral Direita	Bráquio-axilar com PTFE	Proximal Direita	Ulnar Direita
Alça de Femoral Esquerda	Bráquio-axilar direita	Proximal Esquerda	Ulnar Esquerda
Braquio basílica direita	Bráquio-axilar esquerda	Radio basílica direita	
Braquio basílica esquerda	Distal Direita	Radio basílica esquerda	

Prescrição de HD (Remoção de DP):



OBS: opção com histórico de prescrições e de adicionar nova prescrição:

Prescrever:



Dialisador:

B-14H Alto Fluxo	F10 HPS	Fx 100
B-16H Alto Fluxo	F40S	FX40
B-18 H ALTO FLUXO	F50S	Fx60
B-18HF	F60S	FX80
B-20H Alto Fluxo	F6-HPS	FxPaed
Elisio 150 HR	F7	Platinum H1
		Platinum H4

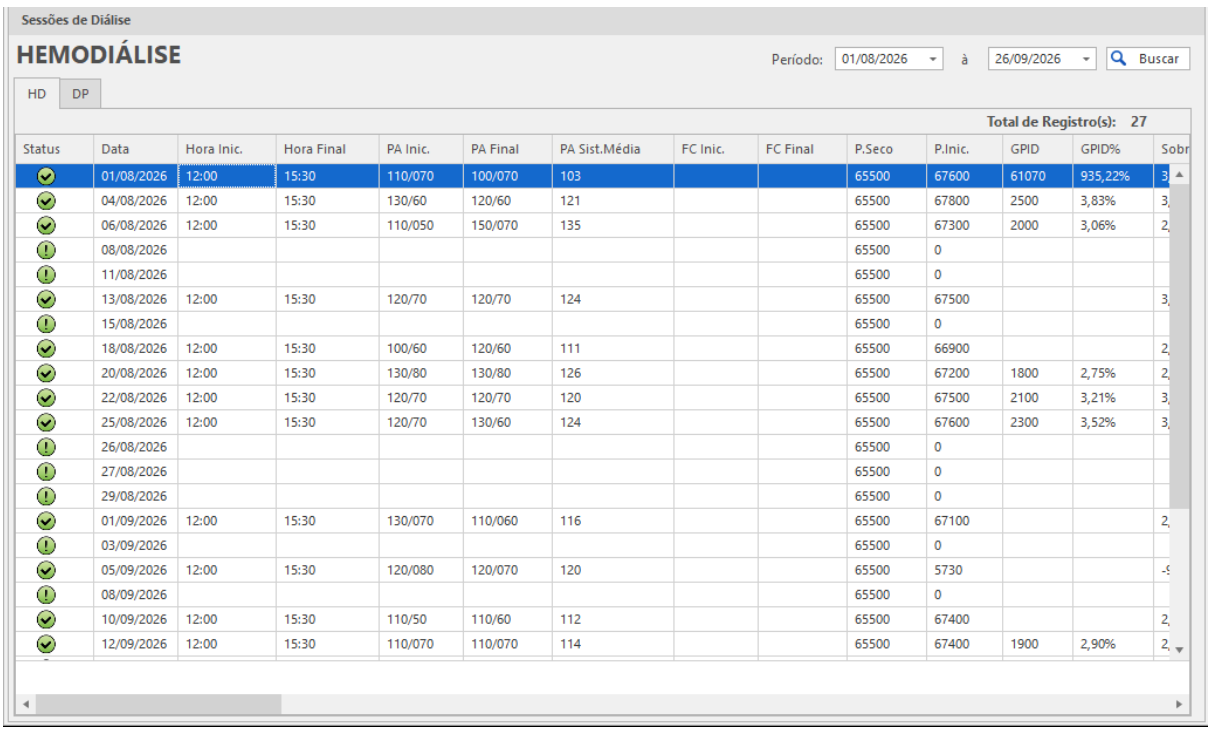
Método de tratamento:

- Hemodiálise
- HDF Mix
- HDF Pré
- HDF Pós
- HF Mix
- HF Pré
- HF Pós

Solução:

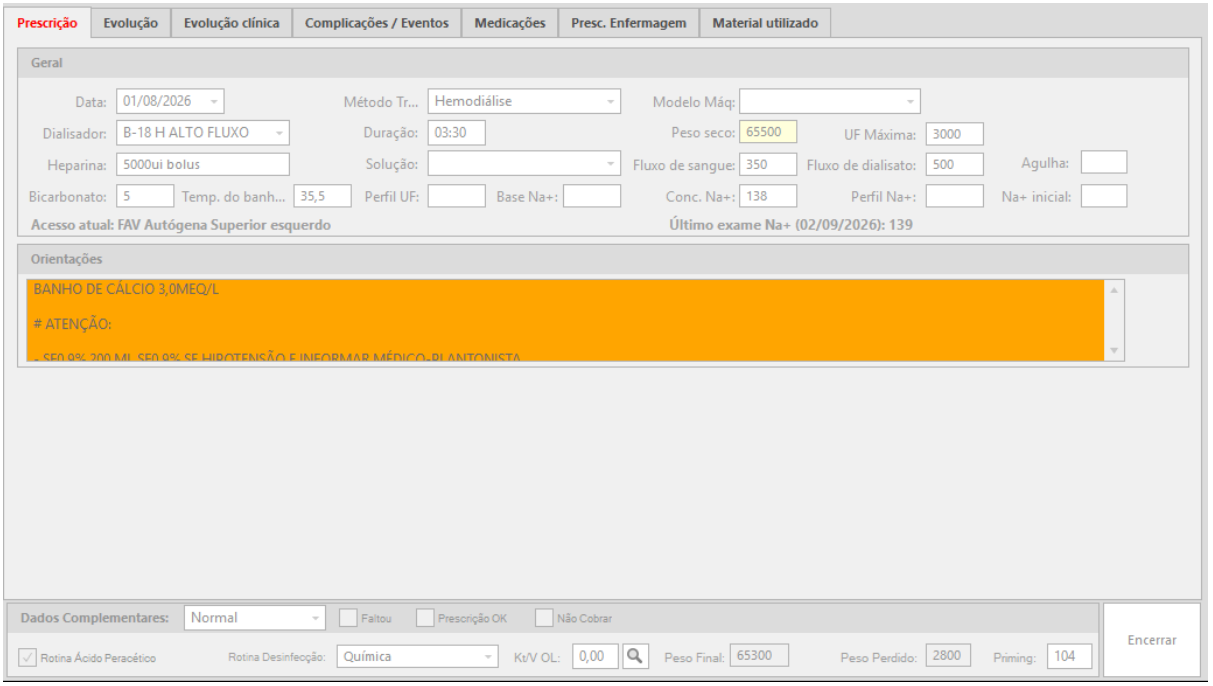
- Acetato
- Bicarbonato
- Padrão
- Solução C/ Glic
- Solução C/ Potá
- Solução Modific
- Solução S/ Potá

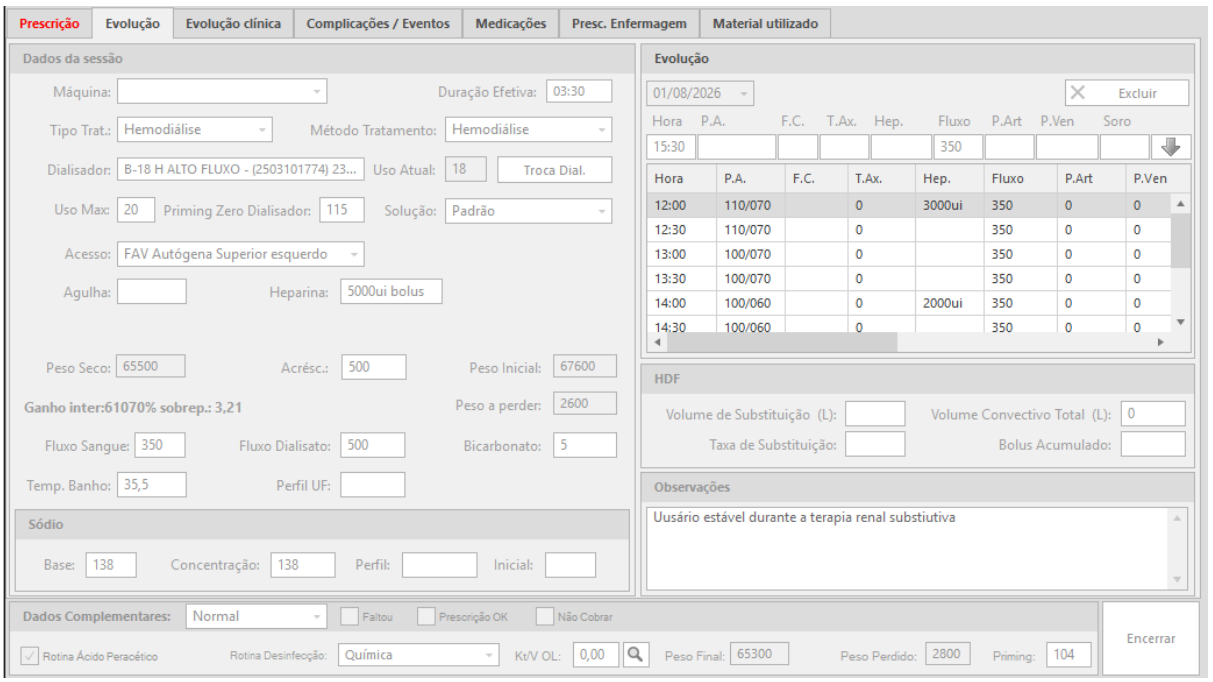
Ver HD (Remoção do DP)

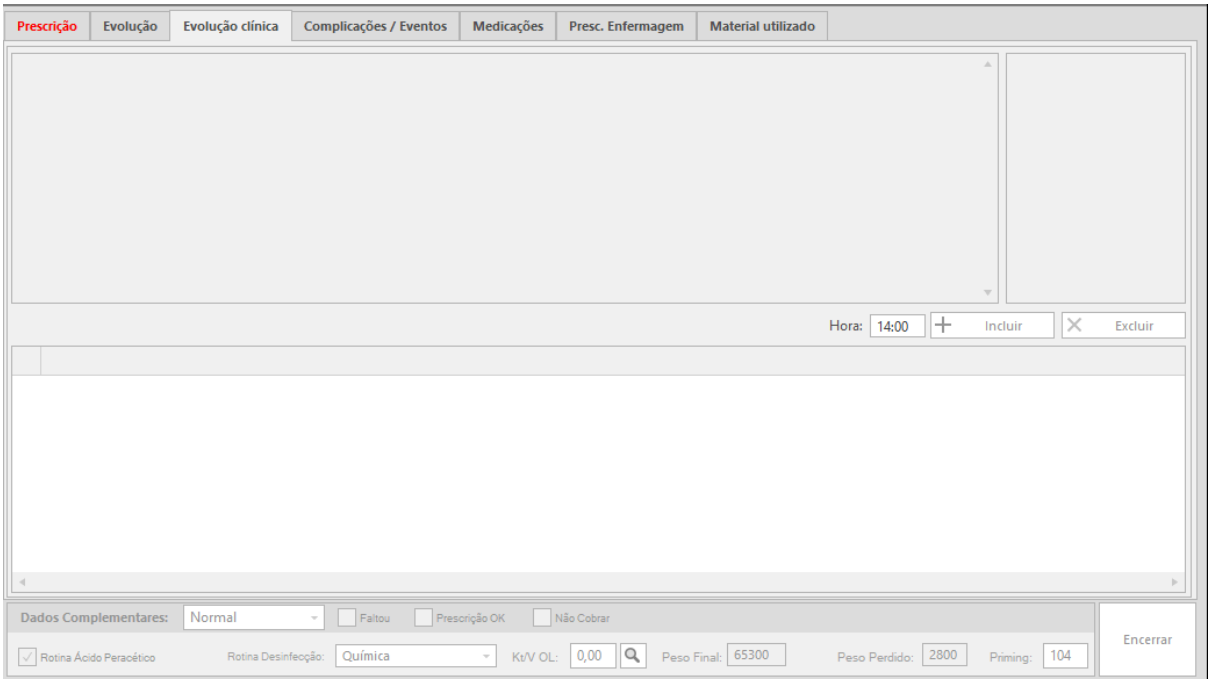


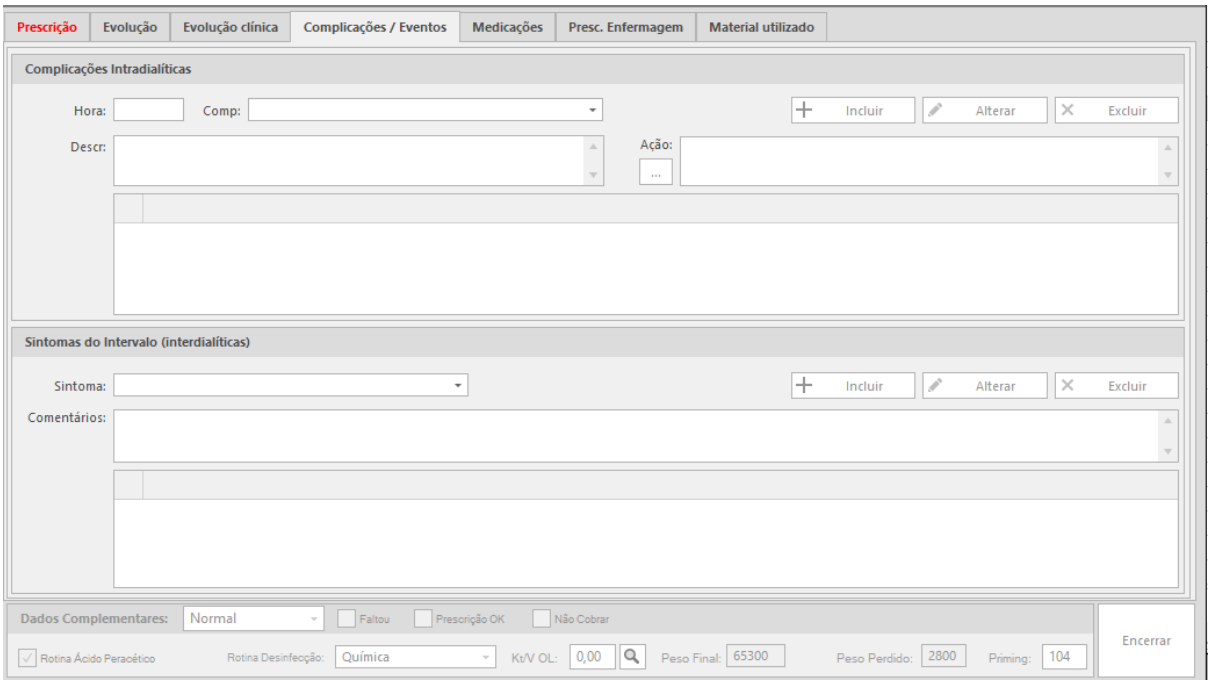
Status	Data	Hora Inic.	Hora Final	PA Inic.	PA Final	PA Sist.Média	FC Inic.	FC Final	P.Seco	P.Inic.	GPID	GPID%	Sobr
✓	01/08/2026	12:00	15:30	110/070	100/070	103			65500	67600	61070	935,22%	3
✓	04/08/2026	12:00	15:30	130/60	120/60	121			65500	67800	2500	3,83%	3
✓	06/08/2026	12:00	15:30	110/050	150/070	135			65500	67300	2000	3,06%	2
!	08/08/2026								65500	0			
!	11/08/2026								65500	0			
✓	13/08/2026	12:00	15:30	120/70	120/70	124			65500	67500			3
!	15/08/2026								65500	0			
✓	18/08/2026	12:00	15:30	100/60	120/60	111			65500	66900			2
✓	20/08/2026	12:00	15:30	130/80	130/80	126			65500	67200	1800	2,75%	2
✓	22/08/2026	12:00	15:30	120/70	120/70	120			65500	67500	2100	3,21%	3
✓	25/08/2026	12:00	15:30	120/70	130/60	124			65500	67600	2300	3,52%	3
!	26/08/2026								65500	0			
!	27/08/2026								65500	0			
!	29/08/2026								65500	0			
✓	01/09/2026	12:00	15:30	130/070	110/060	116			65500	67100			2
!	03/09/2026								65500	0			
✓	05/09/2026	12:00	15:30	120/080	120/070	120			65500	5730			-9
!	08/09/2026								65500	0			
✓	10/09/2026	12:00	15:30	110/50	110/60	112			65500	67400			2
✓	12/09/2026	12:00	15:30	110/070	110/070	114			65500	67400	1900	2,90%	2

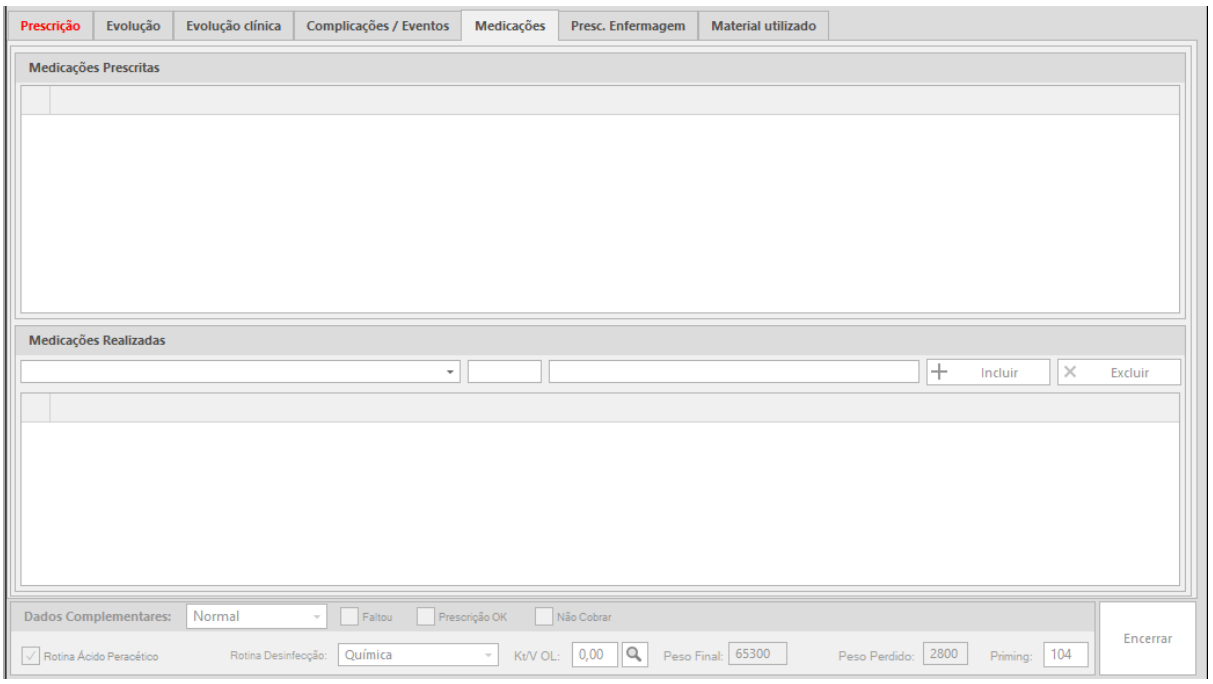
OBS: Histórico do programa de tratamento com cada linha da tabela podendo exibir dados do cliente naquele dia do tratamento com as informações registradas nas telas anteriores.

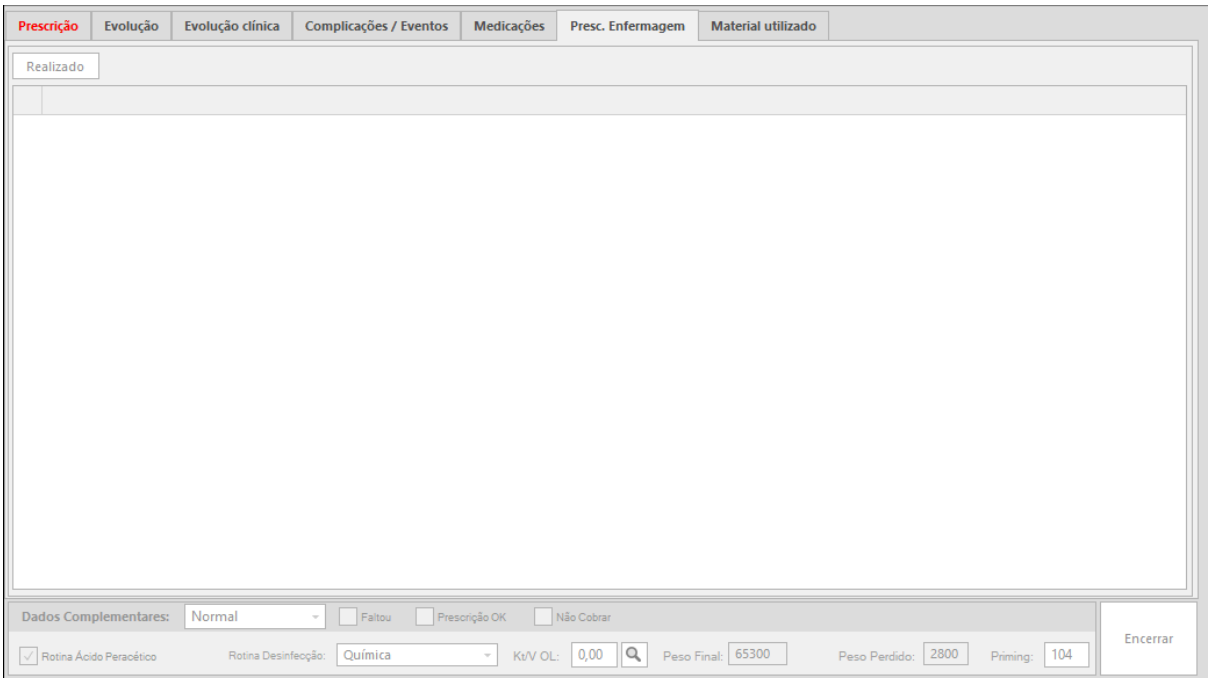


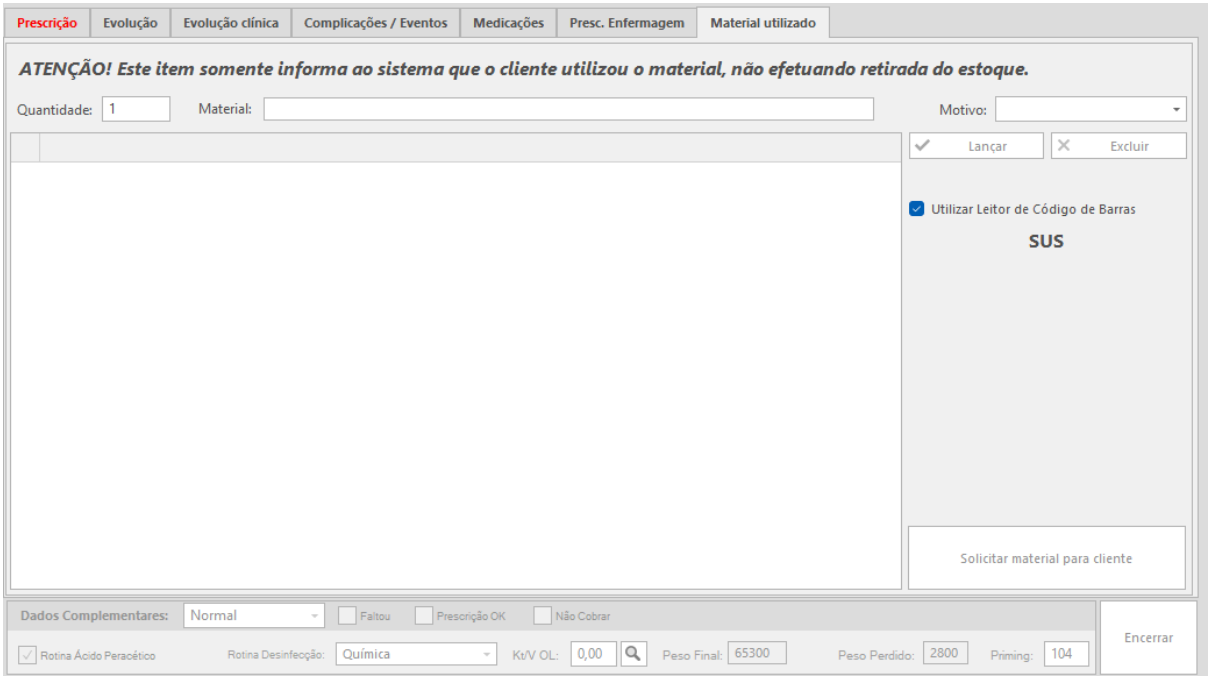



Prescrição
Evolução
Evolução clínica
Complicações / Eventos
Medicações
Presc. Enfermagem
Material utilizado
Hora: 14:00
Incluir
Excluir
Dados Complementares:
Normal
Faltou
Prescrição OK
Não Cobrar
Rotina Ácido Peracético
Rotina Desinfecção:
Química
Kt/V OL:
0,00
Peso Final:
65300
Peso Perdido:
2800
Priming:
104
Encerrar


Prescrição
Evolução
Evolução clínica
Complicações / Eventos
Medicações
Presc. Enfermagem
Material utilizado
Complicações Intradialíticas
Hora:
Comp:
Incluir
Alterar
Excluir
Descr:
Ação:
Sintomas do Intervalo (interdialíticas)
Sintoma:
Incluir
Alterar
Excluir
Comentários:
Dados Complementares:
Normal
Faltou
Prescrição OK
Não Cobrar
Rotina Ácido Peracético
Rotina Desinfecção:
Química
Kt/V OL:
0,00
Peso Final:
65300
Peso Perdido:
2800
Priming:
104
Encerrar

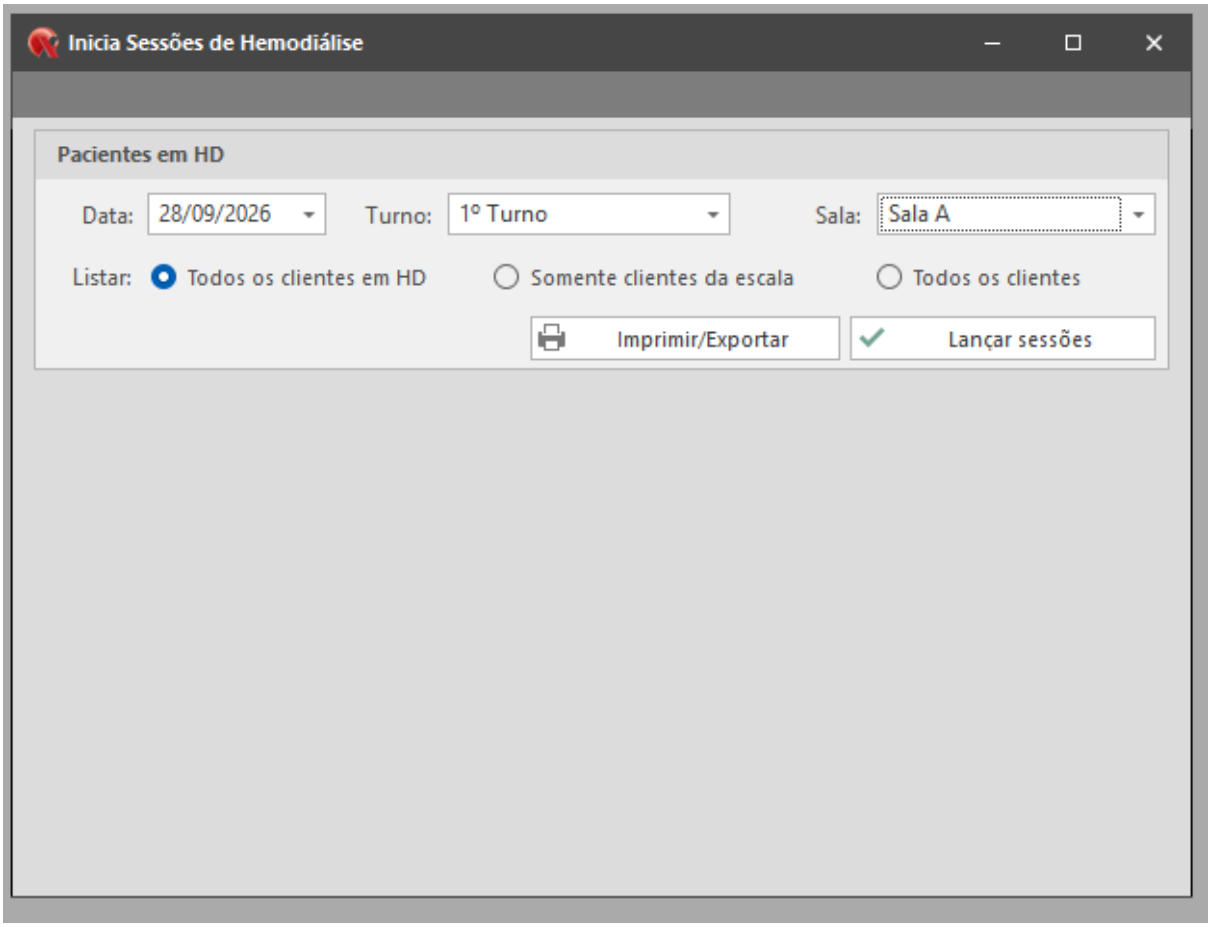

Prescrição
Evolução
Evolução clínica
Complicações / Eventos
Medicações
Presc. Enfermagem
Material utilizado
Medicações Prescritas
Medicações Realizadas
Incluir
Excluir
Dados Complementares:
Normal
Faltou
Prescrição OK
Não Cobrar
Rotina Ácido Peracético
Rotina Desinfecção:
Química
Kt/V OL:
0,00
Peso Final:
65300
Peso Perdido:
2800
Priming:
104
Encerrar

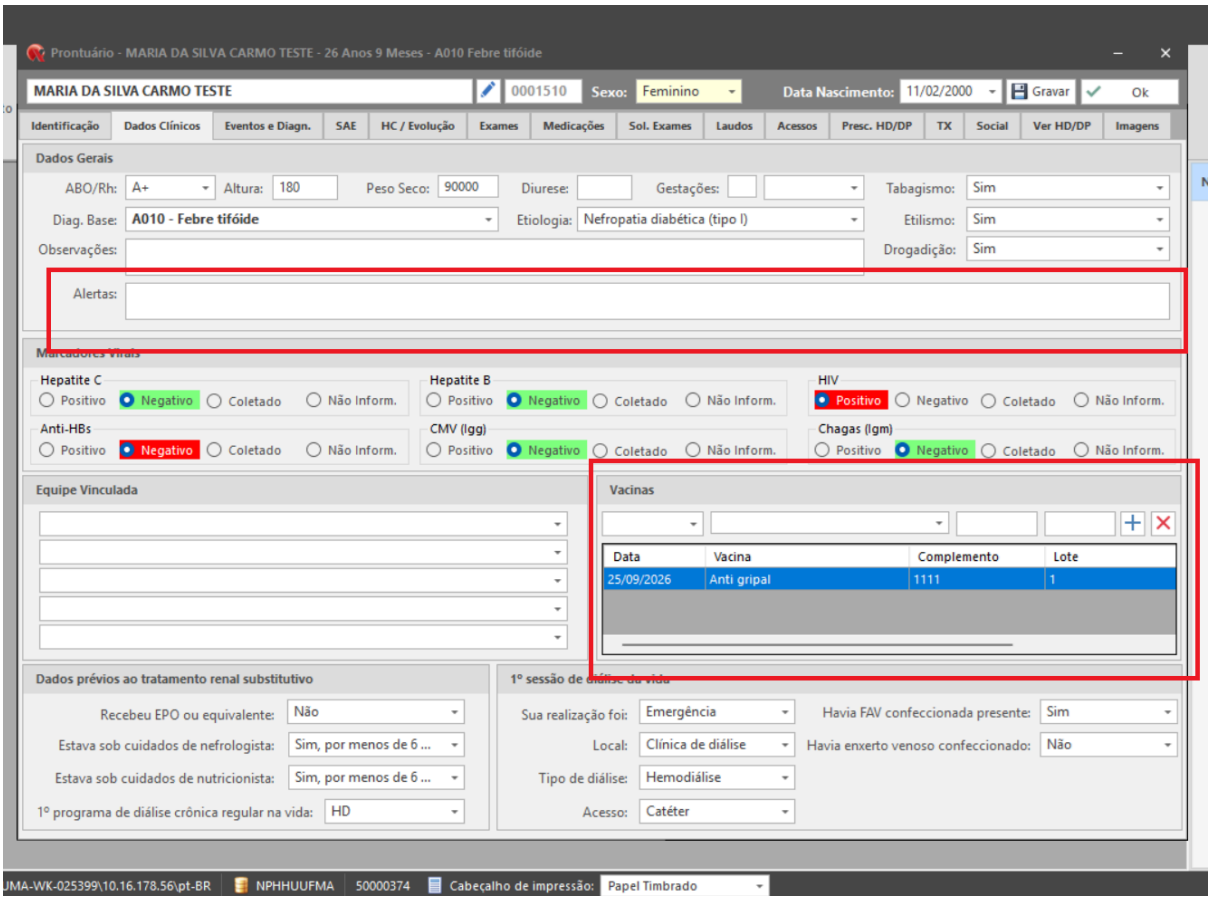

Prescrição
Evolução
Evolução clínica
Complicações / Eventos
Medicações
Presc. Enfermagem
Material utilizado
Realizado
Dados Complementares:
Normal
Faltou
Prescrição OK
Não Cobrar
Rotina Ácido Peracético
Rotina Desinfecção:
Química
Kt/V OL:
0,00
Peso Final:
65300
Peso Perdido:
2800
Priming:
104
Encerrar

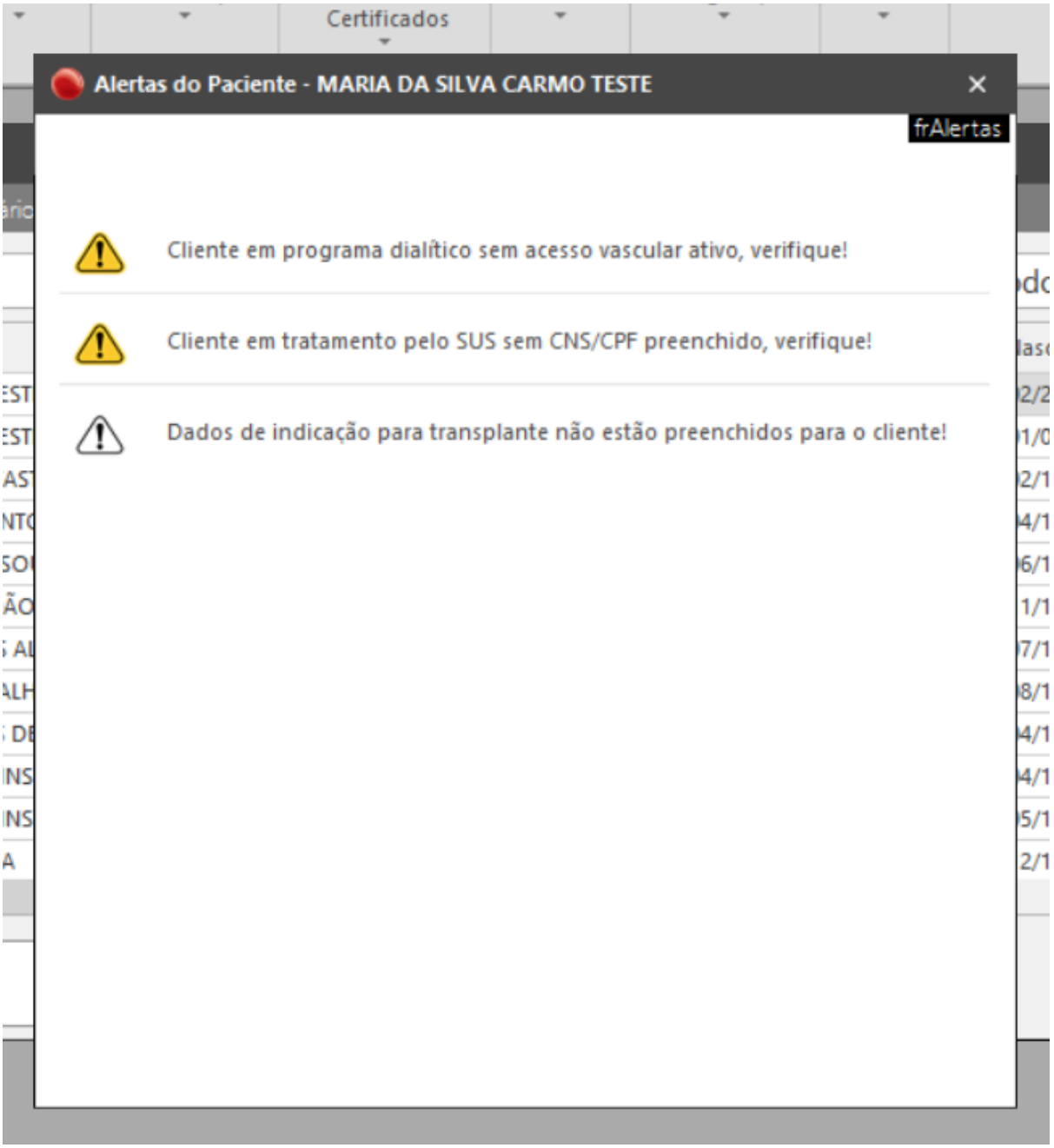


Diálise

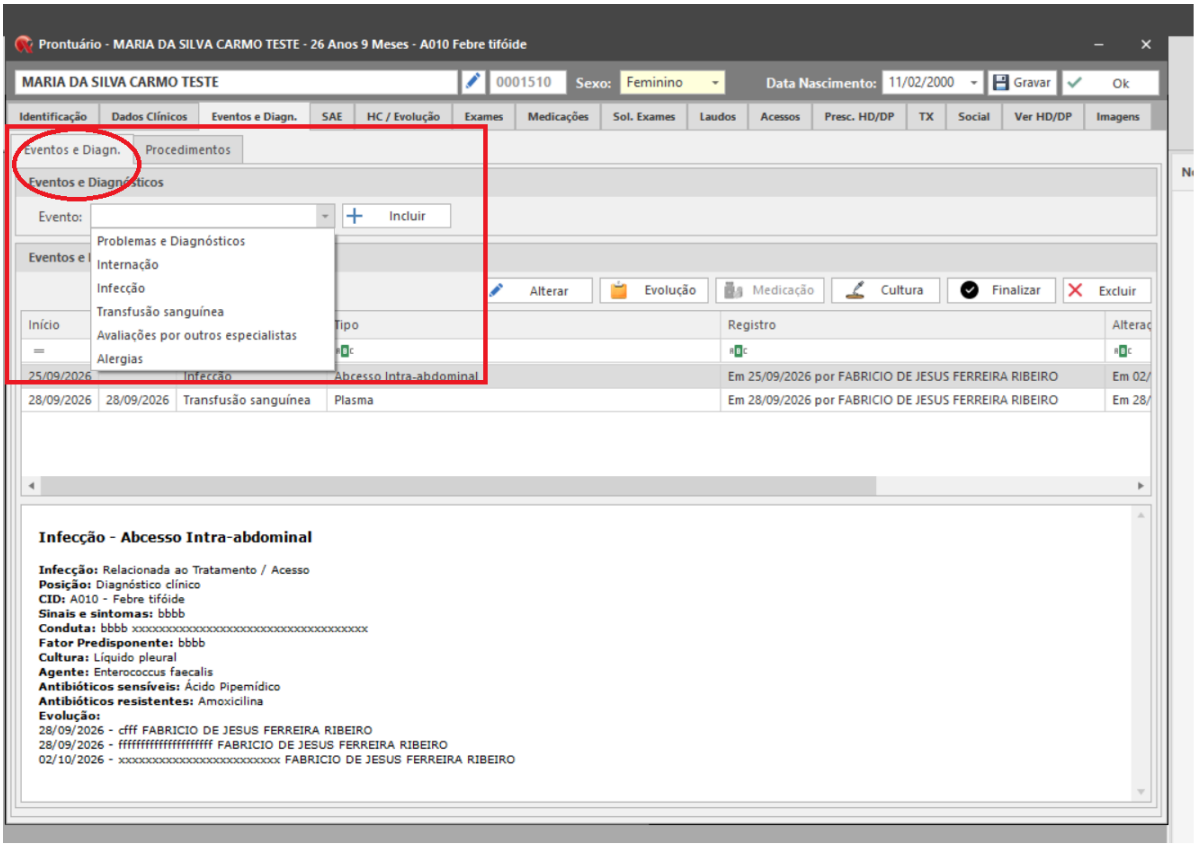
registro e controle das sessões de HD: apenas para listar clientes que tenham hemodiálises previstas nesses filtros seguindo, ou seja, apenas lista clientes.


Inicia Sessões de Hemodiálise
Pacientes em HD
Data:
28/09/2026
Turno:
1º Turno
Sala:
Sala A
Listar:
Todos os clientes em HD
Somente clientes da escala
Todos os clientes
Imprimir/Exportar
Lançar sessões

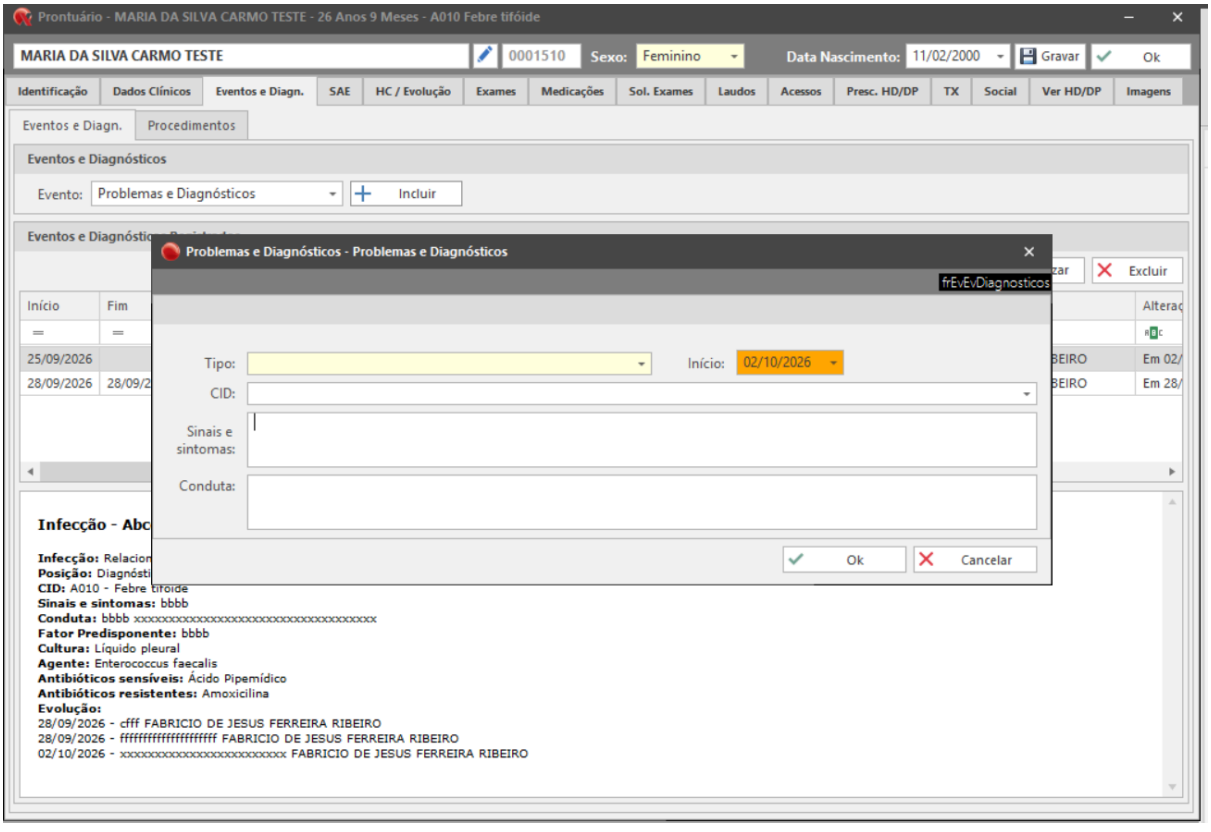

Prontuário - MARIA DA SILVA CARMO TESTE - 26 Anos 9 Meses - A010 Febre tifóide
MARIA DA SILVA CARMO TESTE
0001510
Sexo: Feminino
Data Nascimento: 11/02/2000
Gravar
Ok
Identificação
Dados Clínicos
Eventos e Diagn.
SAE
HC / Evolução
Exames
Medicações
Sol. Exames
Laudos
Acessos
Presc. HD/DP
TX
Social
Ver HD/DP
Imagens
Dados Gerais
ABO/Rh: A+
Altura: 180
Peso Seco: 90000
Diurese:
Gestações:
Tabagismo: Sim
Diag. Base: A010 - Febre tifóide
Etiologia: Nefropatia diabética (tipo I)
Etilismo: Sim
Observações:
Drogadição: Sim
Alertas:
Hepatite C
Positivo
Negativo
Coletado
Não Inform.
Hepatite B
Positivo
Negativo
Coletado
Não Inform.
HIV
Positivo
Negativo
Coletado
Não Inform.
Anti-HBs
Positivo
Negativo
Coletado
Não Inform.
CMV (Igg)
Positivo
Negativo
Coletado
Não Inform.
Chagas (Igm)
Positivo
Negativo
Coletado
Não Inform.
Equipe Vinculada
Vacinas
Data
Vacina
Complemento
Lote
25/09/2026
Anti gripal
1111
1
Dados prévios ao tratamento renal substitutivo
Recebeu EPO ou equivalente: Não
Estava sob cuidados de nefrologista: Sim, por menos de 6 ...
Estava sob cuidados de nutricionista: Sim, por menos de 6 ...
1º programa de diálise crônica regular na vida: HD
Sua realização foi: Emergência
Local: Clínica de diálise
Tipo de diálise: Hemodiálise
Acesso: Catéter
Havia FAV confeccionada presente: Sim
Havia enxerto venoso confeccionado: Não
UMA-WK-025399\10.16.178.56\pt-BR
NPHHUUFMA
50000374
Cabeçalho de impressão:
Papel Timbrado



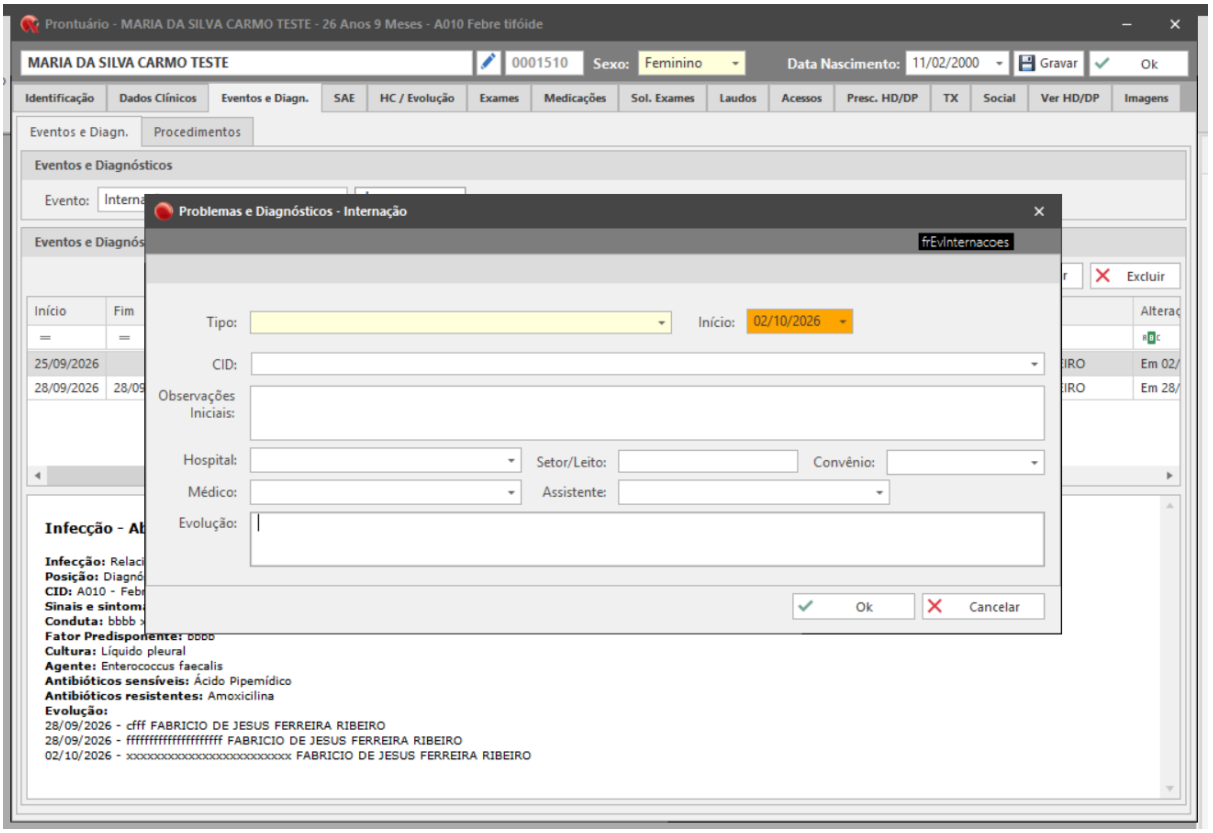
Informações cadastrada no campo de alerta



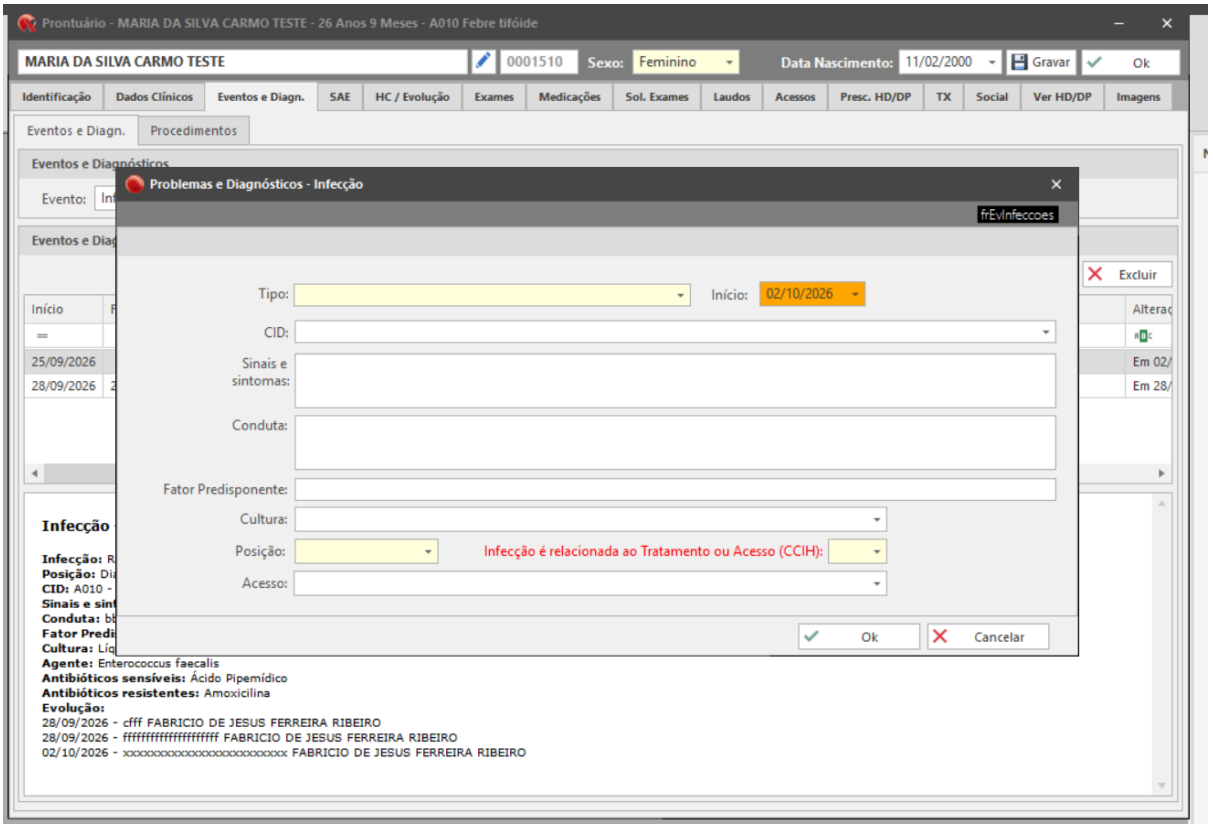
Enfermagem não utiliza: Avaliações por outros especialistas, mas o médico utiliza.



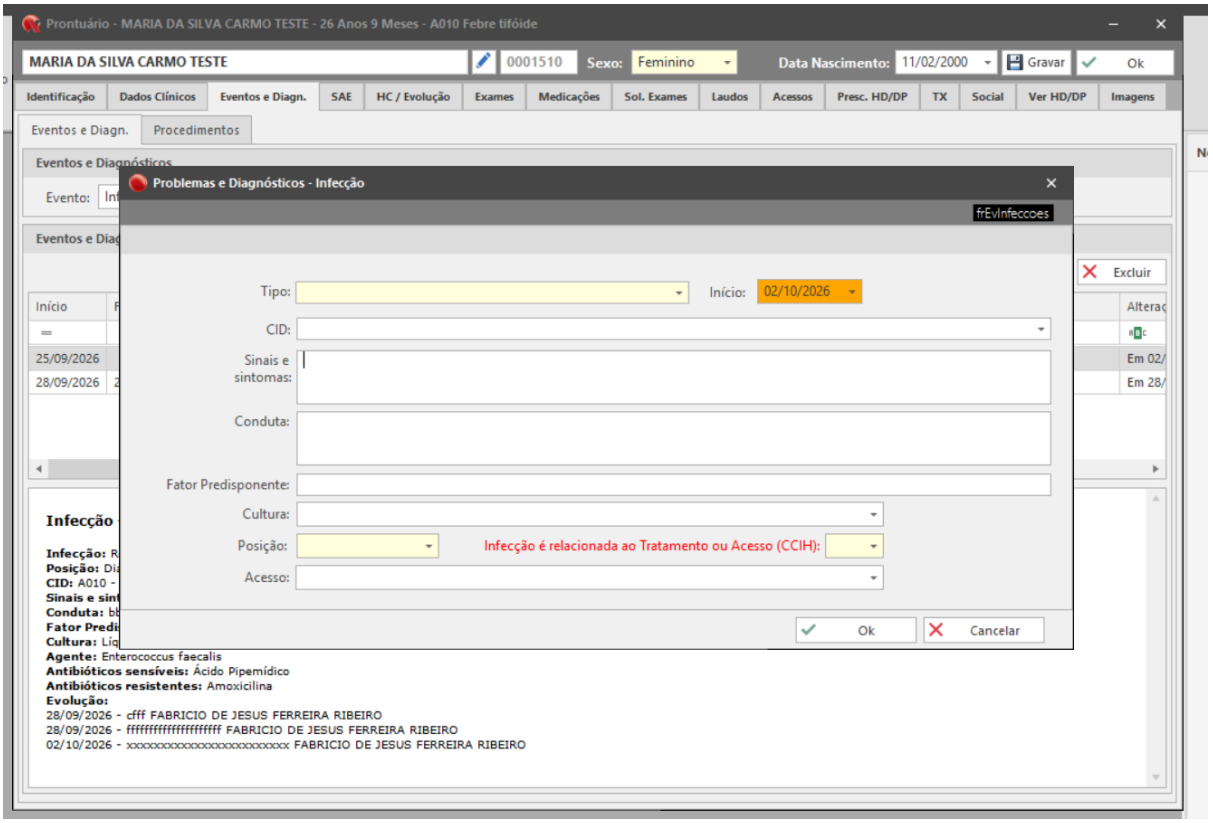
É utilizado todos os tipos // Enfermeira não coloca CID, mas médico usa



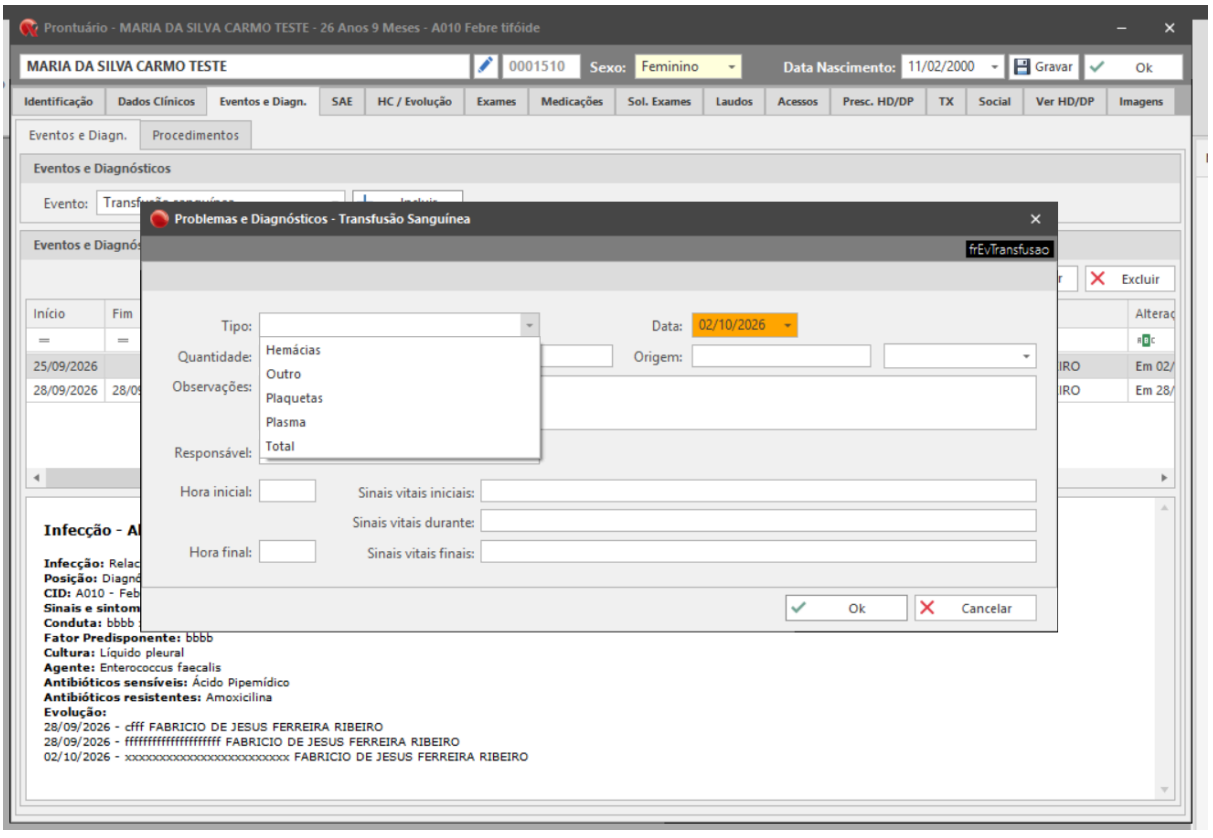
É utilizado todos os tipos // Enfermeira não coloca CID, mas médico usa

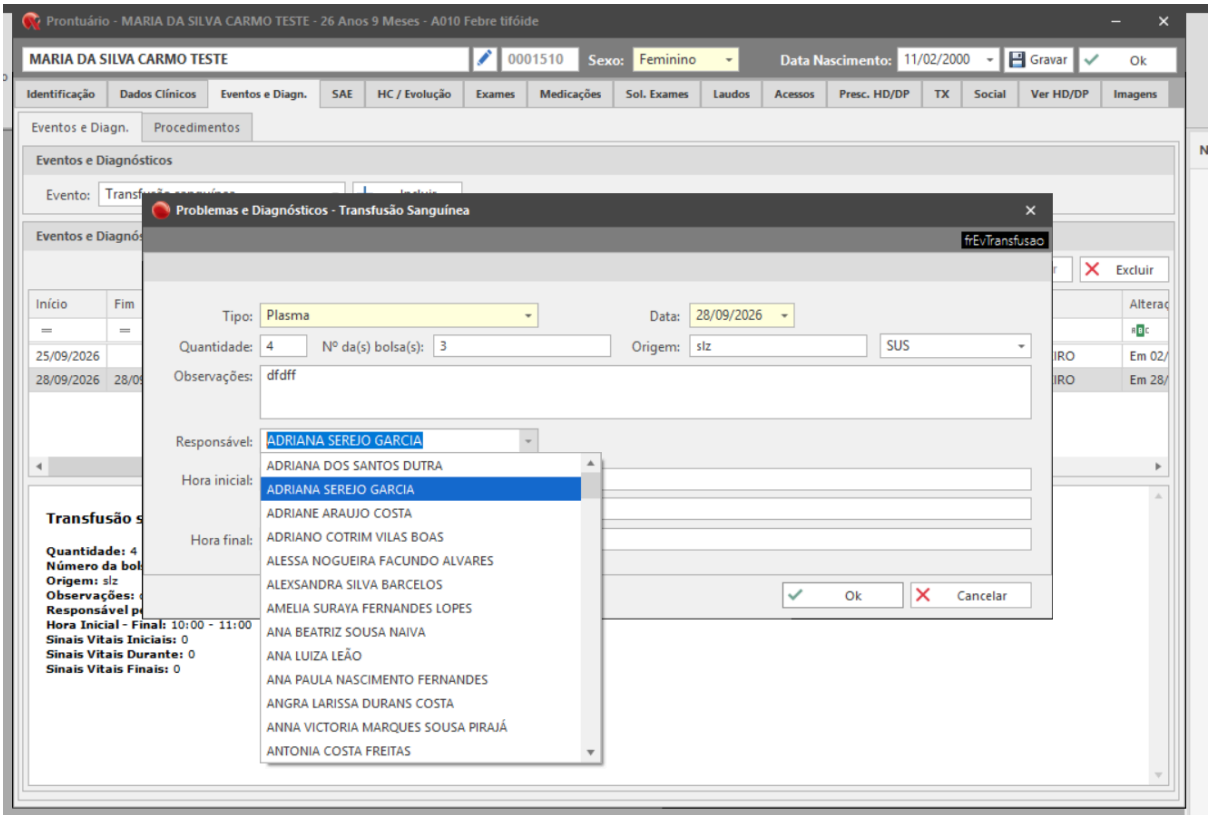


É utilizado todos os tipos // Enfermeira não coloca CID, mas médico usa

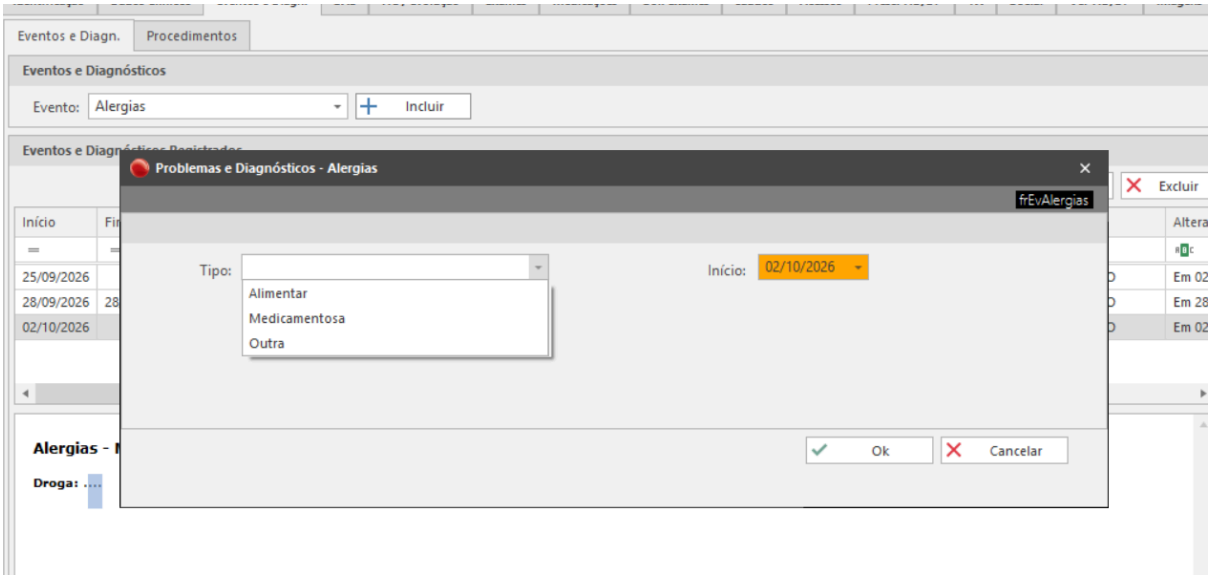


É utilizado todos os tipos // Enfermeira não coloca CID, mas médico usa

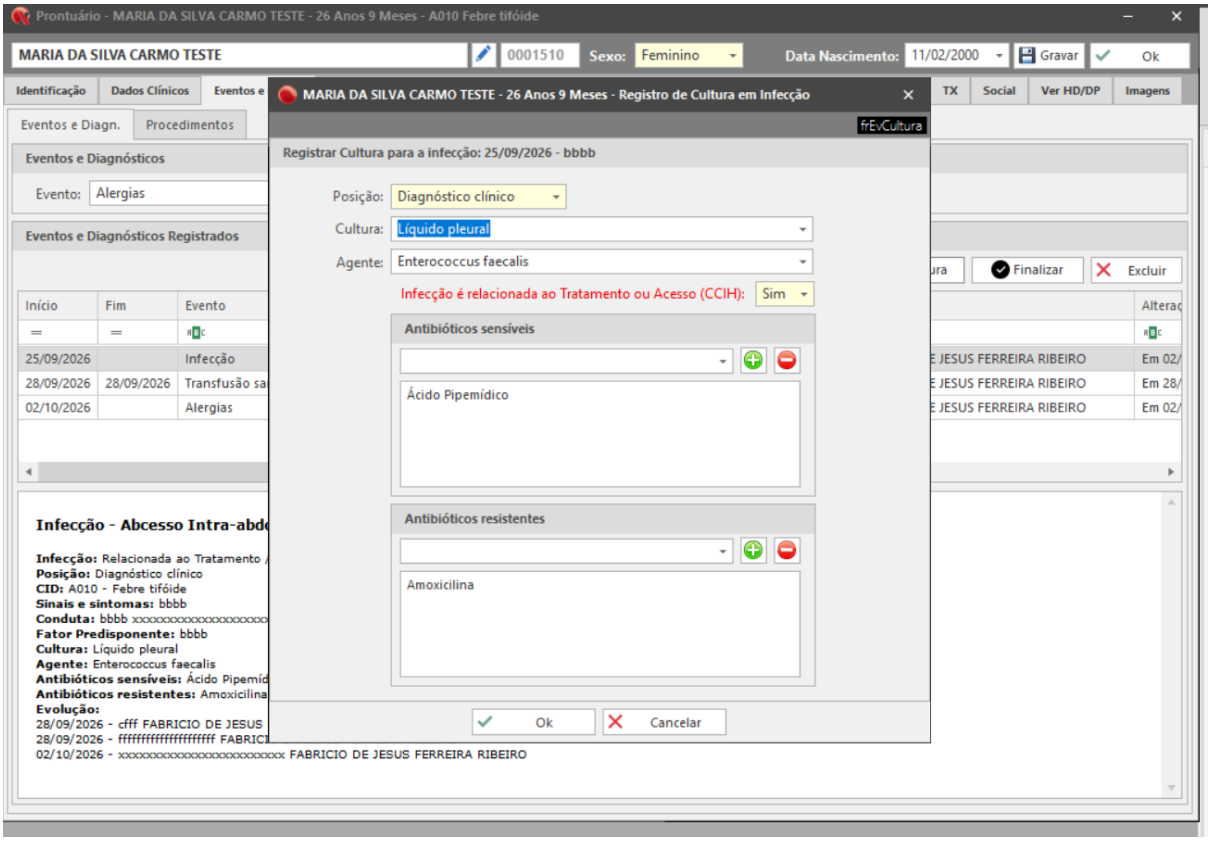




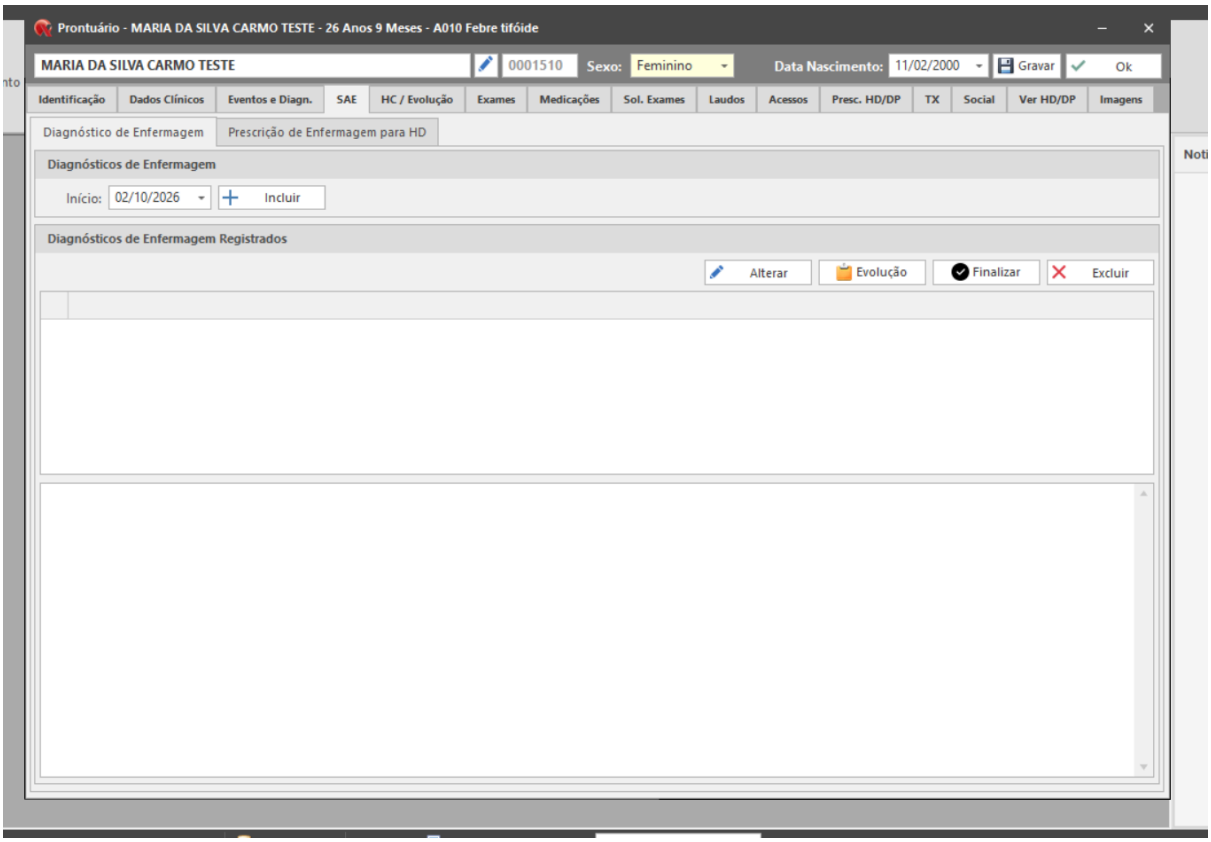
Em responsavel, deixar só os nome dos médicos.



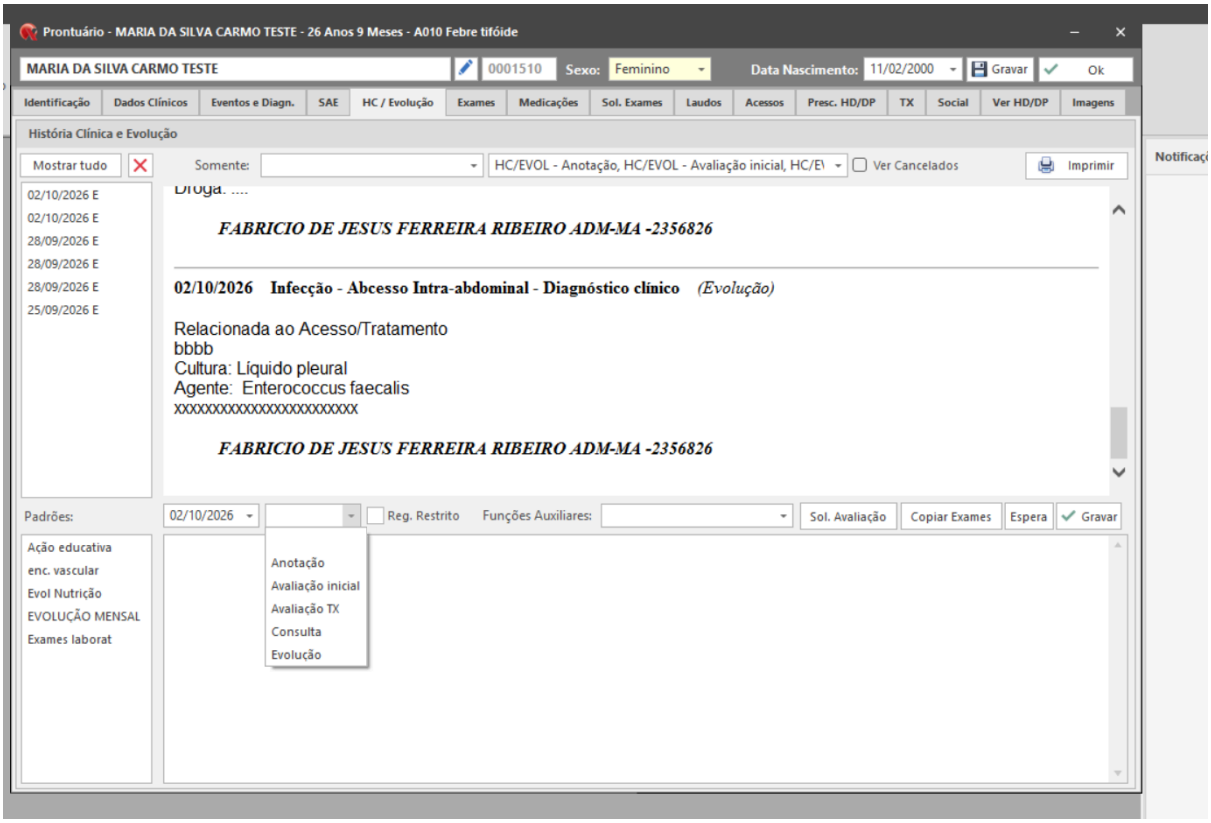
é utilizado todos os campos // incluir campo aberto para outras alergias



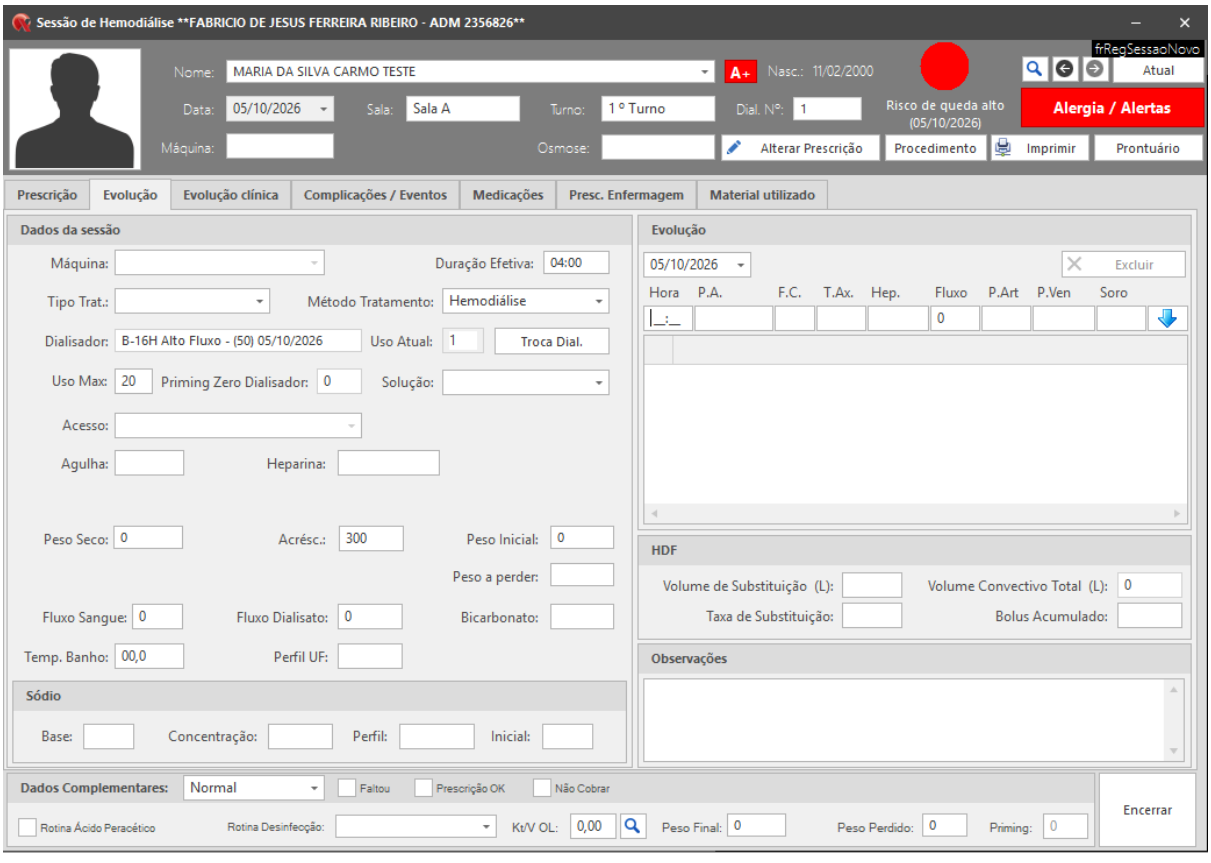
Abre: infecção - cultura (enfermagem utiliza todas as opções)



NÃO UTILIZA

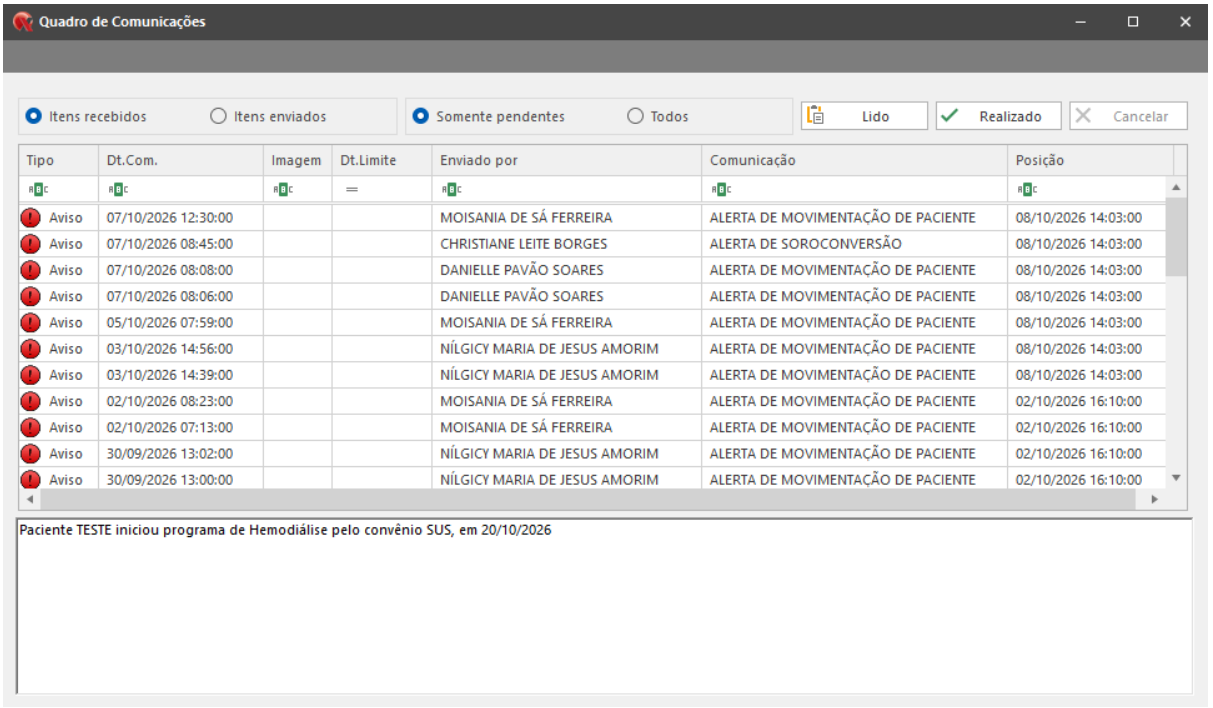


Enfermagem: Anotação(dia a dia), anotação inicial (recebe o paciente) e evolução(semanal)

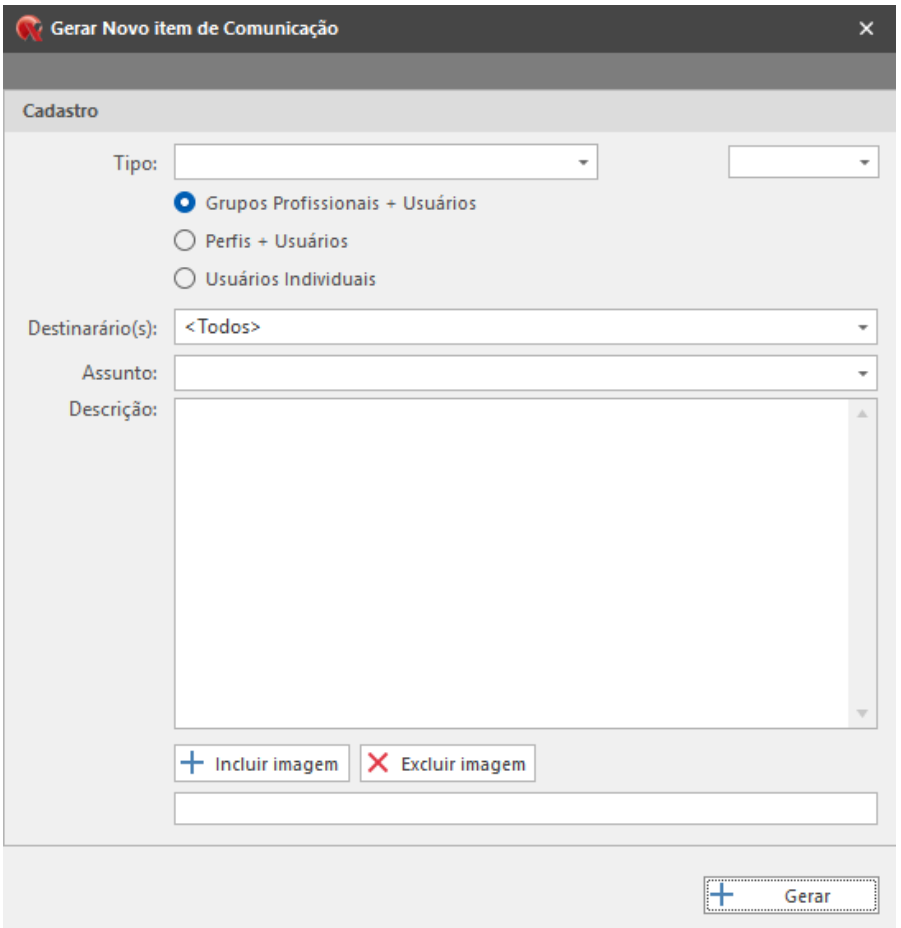


ob: remover box de HDF e por peso fina/perdido perto dos outros pesos

Comunicações:
Quadro de Comunicações:

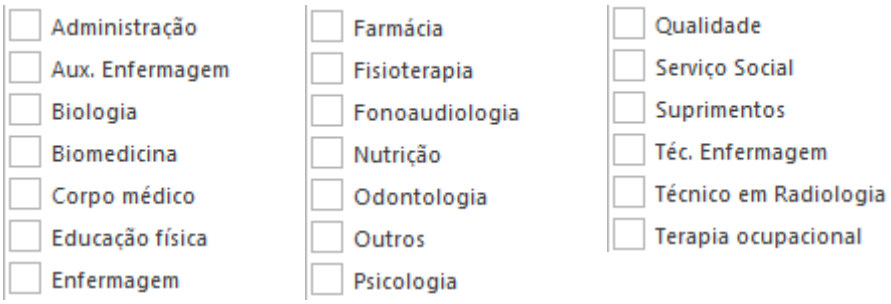


Gerar novo item de comunicação:



Tipo: Solicitação de avaliação, Aviso, Tarefa.
OBS: campo para data também e quando no tipo aviso não há campo de data.

Destinatário:



OBS: também tem a opção de marcar médicos e enfermeiros e téc. de enfermagem e de forma cumulativa e opções de filtros para os destinatários (grupos profissionais + usuários, perfis + usuários, usuários individuais.